MATERIAL PARA FONOAUDIÓLOGOS

100 Fichas Visuais de Fonoaudiologia

Diagnóstico por sintoma, avaliação passo a passo e conduta, prontos para consultar e aplicar.



O que você vai encontrar

- 01–15 Fonologia e articulação
- 16–27 Linguagem infantil
- 28–37 TEA e comunicação
- 38–45 Fluência
- 46–57 Motricidade orofacial
- 58–67 Voz
- 68–77 Disfagia
- 78–87 Leitura e escrita
- 88–94 Audição
- 95–100 Adulto e neurologia

FICHA 01 · FONOLOGIA • INFANTIL

Troca do R pelo L

A criança fala **“balata”** em vez de **“barata”**



O que é

É um **processo fonológico de substituição de líquida**: o som do **R fraco** (o “r” de barata, cara) é trocado pelo **L**, que a criança já domina.

Faz parte do desenvolvimento típico, porque o **L** é adquirido antes do **R**. Vira alvo de terapia quando **persiste além da idade esperada**.

Idade de referência

L · 3a | R · 4a–4a6m | PR/BR · 5a



Idades aproximadas de aquisição no português brasileiro. Há variação individual.

Fonológico ou fonético?

Ela produz o R em alguma palavra ou repetindo o seu modelo?

SIM — Tende a ser fonológico
Ela tem o som, mas ainda não organizou o uso dele no sistema da língua.

NÃO — Investigar a produção (fonético)
Avalie a mobilidade da ponta da língua e o frênulo lingual.

Como avaliar: passo a passo

1. **Nomeação de figuras**
   Palavras com R entre vogais: barata, girafa, cenoura, coruja. Anote cada troca.
2. **Repetição**
   Peça para repetir as mesmas palavras e compare com a fala espontânea.
3. **Estimulabilidade**
   Veja se ela produz o R com o seu modelo, apoio visual ou pista tátil.
4. **Discriminação auditiva**
   Ela percebe a diferença entre “cara” e “cala”? Use pares de figuras.
5. **Exame miofuncional**
   Mobilidade da ponta da língua e avaliação do frênulo lingual.
6. **Outros processos**
   Verifique se há outras trocas no inventário (ex.: “pato” por “prato”).

Estratégias de terapia

- **Bombardeio auditivo:** leia histórias e listas com muitas palavras com R antes de pedir a produção.
- **Contraste de pares mínimos:** jogo de apontar a figura certa e depois ela mesma nomeia.
- **Facilitação pelo D:** “da-da-da” bem rápido aproxima o movimento do toque do R fraco.
- **Praxias de ponta de língua:** estalar, tocar atrás dos dentes e vibrar, como aquecimento.

Pares mínimos

cara × cala
mora × mola
coro × colo

Palavras-alvo

barata · girafa · cenoura · pirulito · coruja · arara · tesoura

Sinais de atenção

- Troca mantida após os 4 anos e meio
- Não produz o R, mesmo com modelo
- Língua presa ou pouca mobilidade
- Vários processos ao mesmo tempo

Orientação à família

- Repita a palavra certa, sem cobrar: “É a barata, sim!”
- Leiam juntos histórias com arara, girafa e pirulito.
- Não imite a troca, mesmo que pareça engraçada.

Base: estudos de aquisição fonológica do português brasileiro

FICHA 02 · FONOLOGIA • INFANTIL

Omissão do R no fim da sílaba

A criança fala **"pota"** em vez de **"porta"**



O que é

É o **apagamento da consoante final**: o R que fecha a sílaba desaparece, como em porta, garfo e mar. O resto da palavra sai correto.

É comum em crianças pequenas e tende a desaparecer com o desenvolvimento. Vira alvo de terapia quando **persiste além da idade esperada**.

Idade de referência

S final · 2a6m | R final · ~4a | PR/BR · 5a



O S no fim da sílaba (pasta) costuma surgir antes do R (porta). Há variação individual.

Por onde começar?

Ela já produz o R fraco no meio da palavra (barata, cara)?

SIM — Foco no R final
Ela já tem o som. O desafio é colocá-lo no fim da sílaba.

NÃO — Comece pelo R fraco
Trabalhe primeiro o R entre vogais (veja a Ficha 01).

Como avaliar: passo a passo

1. **Nomeação de figuras**
   Palavras com R no meio e no fim: porta, garfo, árvore, mar, colher.
2. **Posição na palavra**
   Anote se a omissão ocorre no meio, no fim ou nos dois.
3. **Considere o sotaque**
   Em muitas regiões, o R final dos verbos (amar, comer) some também na fala dos adultos.
4. **Estimulabilidade**
   Veja se ela produz o R quando você separa as sílabas: "por... ta".
5. **Discriminação auditiva**
   Ela diferencia "pena" de "perna" e "baba" de "barba"?
6. **Outros processos**
   Confira se omite outras consoantes finais, como o S ("pata" por "pasta").

Estratégias de terapia

- **Ressilabação:** use frases em que o R encontra uma vogal ("mar azul" soa "ma-ra-zul"), o que facilita a produção.
- **Separação silábica:** fale "por-ta" com palmas e depois junte as sílabas, mantendo o R.
- **Pares mínimos:** mostre que o R muda o significado (pena ou perna?).
- **Progressão:** palavras curtas (mar, dor, cor), depois palavras com R no meio (porta, garfo) e, por fim, frases.

Pares mínimos

perna × pena
barba × baba
mar × má

Palavras-alvo

porta · garfo · árvore · carta · barco · mar · colher

Sinais de atenção

- Omissão mantida após os 4 anos
- Omite também outras consoantes finais
- Não produz o R em nenhuma posição
- Estranhos têm dificuldade para entender

Orientação à família

- Repita a palavra certa com naturalidade: "Fecha a porta!"
- Brinquem com palavras curtas: mar, dor, cor, amor.
- Não peça para repetir várias vezes seguidas.

Base: estudos de aquisição fonológica do português brasileiro

FICHA 03 · FONOLOGIA • INFANTIL

Simplificação do encontro consonantal

A criança fala **"pato"** em vez de **"prato"**



O que é

É a **simplificação do encontro consonantal**: em grupos como PR, BR, TR, CR, PL, BL e FL, a criança produz só a primeira consoante: "pato" por "prato", "fita" por "frita".

É um dos últimos processos a desaparecer, porque o encontro é a sílaba mais complexa do português. É esperado até **cerca de 5 anos**.

3 formas de simplificar

pato
Omissão
Apaga a segunda consoante.

plato
Troca
Troca o R pelo L no grupo.

parato
Vogal extra
Coloca uma vogal no meio.

Cada forma mostra quanto ela já percebe do encontro.

Por onde começar?

Ela produz o R e o L sozinhos, entre vogais (barata, bola)?

SIM — Trabalhe o encontro
Ela tem os sons. O desafio é juntar duas consoantes na mesma sílaba.

NÃO — Trabalhe o som isolado
Primeiro o R fraco (Ficha 01) e o L, depois o encontro.

Como avaliar: passo a passo

1. **Nomeação de figuras**
   Encontros no início e no meio: prato, bruxa, trem, cobra, planta, bicicleta.
2. **Separe por tipo**
   Grupos com R (pr, br) e com L (pl, bl) podem evoluir em tempos diferentes.
3. **Forma usada**
   Registre se é omissão, troca ou vogal extra (veja o quadro acima).
4. **Estimulabilidade**
   Ela produz "pra" quando você fala devagar, "pa-ra", e depois acelera?
5. **Discriminação auditiva**
   Ela diferencia "pato" de "prato" ao ver as duas figuras?
6. **Considere a idade**
   Até cerca de 5 anos, a simplificação ainda é esperada.

Estratégias de terapia

- **Vogal de apoio:** fale "pa-ra-to" e vá acelerando até as duas sílabas virarem uma só: "prato".
- **Pares mínimos:** pato ou prato? fita ou frita? A criança aponta e depois nomeia.
- **Comece pelo mais fácil:** use o encontro que ela já produz em alguma palavra e leve para outras.
- **Pista visual:** dois bloquinhos encostados mostram que as duas consoantes ficam juntas.

Pares mínimos

prato × pato
frita × fita
frio × fio

Palavras-alvo

prato · bruxa · trem · cobra · livro · planta · flor · bicicleta

Sinais de atenção

- Simplificação mantida após os 5 anos
- Não produz o R nem o L simples
- Omite também outras consoantes
- Dificuldade com encontros na escrita

Orientação à família

- Devolva a palavra certa: "Isso, o prato!"
- Brinquem, bem devagar: "três pratos de trigo para três tigres tristes".
- Elogie a tentativa, não só o acerto.

Base: estudos de aquisição fonológica do português brasileiro

FICHA 04 · FONOLOGIA • INFANTIL

Troca do S pelo T

A criança fala **“tapo”** em vez de **“sapo”**



O que é

É a **plosivização de fricativas**: sons de sopro contínuo (F, V, S, Z, CH, J) são trocados por sons curtos e “explosivos” (P, B, T, D): “tapo” por “sapo”, “paca” por “faca”.

É comum nos primeiros anos e costuma desaparecer até **cerca de 3 anos**, quando as fricativas já estão adquiridas.

Idade de referência

F • V	S • Z	CH • J
~2 anos	~2 anos e meio	~3 anos
faca, vaca	sapo, zebra	chave, janela

Idades aproximadas de aquisição das fricativas no português brasileiro.

Por onde começar?

Ela consegue fazer um sopro longo, como o “ssss” da cobra, fora da palavra?

SIM — Leve o som para a palavra
Alongue o S no começo: “ssss-apo”, e encurte aos poucos.

NÃO — Treine o som isolado
Use pistas visuais e brincadeiras de sopro antes das palavras.

Como avaliar: passo a passo

1. **Nomeação de figuras**
   Todas as fricativas: faca, vaca, sapo, zebra, chave, janela.
2. **Mapeie os sons**
   Marque quais são trocados: só o S ou todas as fricativas.
3. **Posição na palavra**
   Teste no início (sapo) e no meio da palavra (vassoura, café).
4. **Estimulabilidade**
   Ela produz o S isolado imitando você? E na sílaba “sa”?
5. **Discriminação auditiva**
   Ela aponta certo quando você diz “saco” e “taco”?
6. **Audição**
   Na dúvida, peça audiometria: perdas leves dificultam perceber esses sons.

Estratégias de terapia

- **Sons longos × curtos:** a cobra (“ssss”) dura, a gota (“t!”) é curta; a criança classifica cada som.
- **Pares mínimos:** saco ou taco? sal ou tal? Mostre que o som muda o significado.
- **Alongamento:** comece com “sssss-apo” e reduza o S aos poucos até “sapo”.
- **Pista tátil:** deslize o dedo devagar no braço da criança enquanto ela faz o S.

Pares mínimos

saco × taco
sal × tal
som × tom

Palavras-alvo

sapo · sino · sofá · suco · faca · vaca · zebra · chuva

Sinais de atenção

- Troca mantida após os 3 anos
- Troca de todas as fricativas
- Histórico de otites frequentes
- Fala difícil de entender

Orientação à família

- Imitem sons longos: cobra (ssss), vento (ffff), abelha (zzzz).
- Repita a palavra certa: “Sapo! Que sapo verde!”
- Leiam livros de bichos e objetos com S e F.

Base: estudos de aquisição fonológica do português brasileiro

FICHA 05 · FONOLOGIA • INFANTIL

Troca do C pelo T

A criança fala **“tasa”** em vez de **“casa”**



O que é

É a **anteriorização** (ou frontalização de velares): os sons feitos com o fundo da língua (C/Q e G) saem com a ponta da língua (T e D): “tasa” por “casa”, “dato” por “gato”.

O C e o G são adquiridos cedo, por volta de 2 anos. A troca é comum no início e costuma ser superada até **cerca de 3 anos e meio**.

Onde a língua trabalha

C • G
Sons de trás
O fundo da língua sobe e toca o céu da boca, lá atrás.

T • D
Sons da frente
A ponta da língua toca logo atrás dos dentes de cima.

Na anteriorização, os sons de trás são levados para a frente.

Por onde começar?

Ela produz o C ou o G em alguma palavra ou imitando você?

SIM — Contraste frente × trás
Ela tem o som. Use pares mínimos para mostrar a diferença.

NÃO — Ensine o ponto do som
Use pistas de posição da língua (veja as estratégias) antes dos pares.

Como avaliar: passo a passo

1. **Nomeação de figuras**
   Palavras com C/Q e G: casa, cama, queijo, gato, gola, foguete.
2. **Posição na palavra**
   Teste no início (casa) e no meio da palavra (boneca, foguete).
3. **C e G separados**
   Compare os dois: a criança pode trocar só um deles.
4. **Estimulabilidade**
   Com a ponta da língua apoiada nos dentes de baixo, ela imita “ka-ka-ka”?
5. **Discriminação auditiva**
   Ela diferencia “capa” de “tapa” e “gado” de “dado”?
6. **Outros processos**
   Veja se há outras trocas associadas, que deixam a fala menos inteligível.

Estratégias de terapia

- **Ponta presa:** com um abaixador de língua, segure a ponta da língua atrás dos dentes de baixo e peça “ka”.
- **Sílabas facilitadoras:** comece por “ko” e “ku”, pois as vogais de trás ajudam o som de trás.
- **Pares mínimos:** capa ou tapa? cola ou tola? A criança aponta e depois nomeia.
- **Pista sonora:** associe o C ao “có-có” da galinha, um som “lá do fundo”.

Pares mínimos

capa × tapa
cola × tola
gado × dado

Palavras-alvo

casa · cama · queijo · boneca · macaco · gato · gola · foguete

Sinais de atenção

- Troca mantida após os 3 anos e meio
- Não produz C nem G, mesmo com modelo
- Vários sons trocados ao mesmo tempo
- Otites frequentes ou suspeita auditiva

Orientação à família

- Brinquem de bichos: galinha (có-có), pato (quá-quá).
- Repita a palavra certa: “Isso, a casa!”
- Valorize as tentativas, sem apontar o erro.

Base: estudos de aquisição fonológica do português brasileiro

FICHA 06 · FONOLOGIA • INFANTIL

Troca do T pelo C

A criança fala **"cacu"** em vez de **"tatu"**



O que é

É a **posteriorização**: os sons feitos com a ponta da língua (T e D) saem com o fundo da língua (C e G): "cacu" por "tatu", "gado" por "dado".

É o inverso da Ficha 05 e é **pouco comum** no desenvolvimento típico. Por isso merece atenção mesmo em crianças pequenas.

Por que observar cedo

Processos esperados
Aparecem em muitas crianças e somem com a idade. Ex.: Fichas 01 e 05.

Processos incomuns
Raros no desenvolvimento típico. Costumam indicar transtorno fonológico.

A posteriorização está entre os processos incomuns.

Por onde começar?

Ela produz o T ou o D em alguma palavra ou imitando você?

SIM — Contraste frente × trás
Ela tem o som. Use pares mínimos para mostrar a diferença.

NÃO — Ensine o ponto do som
Comece pelo controle da ponta da língua (veja as estratégias).

Como avaliar: passo a passo

1. **Nomeação de figuras**
   Palavras com T e D: tatu, tomate, telefone, pato, dado, dedo.
2. **Posição na palavra**
   Teste no início (tatu) e no meio da palavra (pato, cadeira).
3. **Outros sons da frente**
   Confira se N, L e S também vão para trás.
4. **Estimulabilidade**
   Ela faz "ta-ta-ta" com a ponta da língua atrás dos dentes de cima?
5. **Discriminação auditiva**
   Ela diferencia "tapa" de "capa" e "dado" de "gado"?
6. **Exame miofuncional**
   Observe a mobilidade da ponta da língua e o frênulo lingual.

Estratégias de terapia

- **Ponto de referência:** toque com o abaixador logo atrás dos dentes de cima e peça para a língua "bater ali".
- **Exagero proposital:** faça o T com a ponta da língua aparecendo entre os dentes e recue aos poucos.
- **Pares mínimos:** tapa ou capa? tola ou cola? A criança aponta e depois nomeia.
- **Classificação:** cartões de duas cores, uma para os sons da frente (T, D) e outra para os de trás (C, G).

Pares mínimos

tapa × capa
tola × cola
dado × gado

Palavras-alvo

tatu · tomate · telefone · tapete · pato · dado · dedo · cadeira

Sinais de atenção

- Processo incomum: avalie em qualquer idade
- Vários sons trocados ao mesmo tempo
- Fala difícil de entender
- Pouca mobilidade da ponta da língua

Orientação à família

- Brinquem de "língua dançarina": tocar atrás dos dentes de cima.
- Repita a palavra certa: "Olha o tatu!"
- Não corrija a criança na frente de outras pessoas.

Base: estudos de aquisição fonológica do português brasileiro

FICHA 07 · FONOLOGIA • INFANTIL

Troca do CH pelo S

A criança fala **“save”** em vez de **“chave”**



O que é

É a **frontalização de palatais**: o CH (e o X com som de CH) vira S, e o J (e o G de “gelo”) vira Z: “save” por “chave”, “zanela” por “janela”.

O CH e o J costumam ser adquiridos por volta de 3 anos. A troca é esperada no início e tende a desaparecer até **cerca de 4 anos**.

Diferença nos lábios

S • Z
Sorriso
Lábios esticados, como num sorriso.

CH • J
Biquinho
Lábios arredondados e projetados para a frente.

Use o espelho: a diferença nos lábios é a pista visual mais fácil para a criança.

Por onde começar?

Ela faz o “chhh” do silêncio, com o dedo na boca, fora da palavra?

SIM **Leve o som para a palavra**
Alongue o CH no começo: “chhhh-ave”, e encurte aos poucos.

NÃO **Treine o som isolado**
Use o biquinho e o espelho antes de passar às palavras.

Como avaliar: passo a passo

1. **Nomeação de figuras**
   Palavras com CH, X, J e G: chave, chuva, peixe, xícara, janela, girafa.
2. **CH e J separados**
   Anote se a troca ocorre só no CH, só no J ou nos dois.
3. **Posição na palavra**
   Teste no início (chuva) e no meio da palavra (bicho, caixa).
4. **Observe os lábios**
   No espelho, veja se ela arredonda os lábios no CH.
5. **Estimulabilidade**
   Ela produz “chhh” imitando você, com biquinho?
6. **Discriminação auditiva**
   Ela diferencia “chão” de “são” e “acho” de “asso”?

Estratégias de terapia

- **Biquinho × sorriso:** biquinho no CH, sorriso no S. Use o espelho e figuras de apoio.
- **Som do silêncio:** “chhh” com o dedo na boca, depois “chhhh-ão”, “chhhh-uva”.
- **Do S para o CH:** faça “sss”, arredonde os lábios e recue um pouco a língua até virar “chhh”.
- **Pares mínimos:** chão ou são? mancha ou mansa? A criança aponta e depois nomeia.

Pares mínimos

chão × são
acho × asso
mancha × mansa

Palavras-alvo

chave · chuva · chinelo · peixe · bicho · janela · girafa · queijo

Sinais de atenção

- Troca mantida após os 4 anos e meio
- Troca também de outros sons
- Língua entre os dentes no S (Ficha 09)
- Mordida aberta ou chupeta prolongada

Orientação à família

- Brinquem de biblioteca: “chhh, silêncio!”, com biquinho.
- Repita a palavra certa: “A chave, isso!”
- Elogie o esforço, mesmo quando sair diferente.

Base: estudos de aquisição fonológica do português brasileiro

FICHA 08 · FONOLOGIA • INFANTIL

Troca de sons sonoros por surdos

A criança fala **“pola”** em vez de **“bola”**



O que é

É o **ensurdecimento**: sons feitos com vibração das pregas vocais (B, D, G, V, Z, J) são trocados pelos pares sem vibração (P, T, C, F, S, CH): “pola” por “bola”, “faca” por “vaca”.

A diferença entre surdo e sonoro costuma estar estabelecida cedo. A troca persistente merece investigação cuidadosa, **inclusive da audição**.

Os pares surdo × sonoro

P × B	T × D	C × G
F × V	S × Z	CH × J

• surdo (sem vibração) • sonoro (com vibração)

Por onde começar?

A troca acontece em todos os pares ou só em alguns?

TODOS — Investigue audição e percepção
Peça avaliação audiológica e treine a discriminação auditiva.

ALGUNS — Trabalhe os pares alterados
Use contraste e pistas táteis só nos pares que estão trocados.

Como avaliar: passo a passo

1. **Nomeação de figuras**
   Os 6 pares: bola, dado, gato, vaca, zebra, janela.
2. **Mapeie os pares**
   Marque quais pares estão alterados e em que posição da palavra.
3. **Discriminação auditiva**
   Ela diferencia “faca” de “vaca” e “pote” de “bote”?
4. **Estimulabilidade**
   Com a mão no pescoço, ela faz “vvvv” e sente a vibração?
5. **Audição**
   Solicite avaliação audiológica, principalmente se houver otites frequentes.
6. **Escrita**
   Em escolares, verifique se a mesma troca aparece na escrita (Ficha 78).

Estratégias de terapia

- **Motor ligado × desligado:** com a mão no pescoço, a criança sente que a abelha (“zzz”) vibra e a cobra (“sss”) não.
- **Comece pelos contínuos:** V, Z e J permitem sentir a vibração por mais tempo; depois passe para B, D e G.
- **Pares mínimos:** vaca ou faca? bote ou pote? A criança aponta e depois nomeia.
- **Bombardeio auditivo:** leia listas e histórias com o som-alvo antes de pedir a produção.

Pares mínimos

vaca × faca

bote × pote

dia × tia

Palavras-alvo

bola · boneca · dado · dedo · gato · vaca · zebra · janela

Sinais de atenção

- Troca em vários pares ao mesmo tempo
- Otites frequentes ou suspeita auditiva
- Mesma troca na escrita (escolares)
- Troca persistente após os 4 anos

Orientação à família

- Brinquem de abelha (zzz) e cobra (sss) com a mão no pescoço.
- Fale de frente para a criança, em lugar silencioso.
- Repita a palavra certa: “É a bola, sim!”

Base: estudos de aquisição fonológica do português brasileiro

FICHA 09 | FONOLOGIA • INFANTIL

Língua entre os dentes no S

O S sai com a **língua aparecendo** entre os dentes



O que é

É o **ceceio anterior** (ou interdental): no S e no Z, a ponta da língua avança entre os dentes e o som fica abafado, parecido com o "th" do inglês.

É uma **distorção**: a criança não troca o som, mas o produz de forma imprecisa. É frequente em crianças pequenas; após os **4 a 5 anos**, costuma estar ligado a hábitos e alterações orais.

Fatores associados

- **Mordida aberta na frente**
- **Chupeta, mamadeira ou dedo**
- **Respiração pela boca**
- **Língua baixa ou para a frente em repouso**
- **Frênulo lingual alterado**

Na troca dos dentes da frente (6 a 7 anos), o ceceio pode surgir de forma passageira.

Por onde começar?

Os dentes da frente se encostam quando ela morde (sem mordida aberta)?

SIM — Trabalhe a posição da língua
Ensine o S com os dentes juntos e a língua atrás deles.

NÃO — Encaminhe ao dentista
Peça avaliação ortodôntica: a terapia caminha junto com o tratamento.

Como avaliar: passo a passo

1. **Observação no espelho** — Peça palavras com S e Z e observe a ponta da língua.
2. **Oclusão** — Verifique mordida aberta, mordida cruzada e falhas nos dentes.
3. **Hábitos** — Pergunte sobre chupeta, mamadeira, dedo e o hábito de morder objetos.
4. **Repouso** — Observe língua e lábios parados: boca aberta? língua aparecendo?
5. **Deglutição** — Veja se a língua empurra os dentes ao engolir (Ficha 48).
6. **Respiração** — Investigue respiração pela boca e ronco (Ficha 46).

Estratégias de terapia

- **Dentes juntinhos:** sorriso, dentes encostados e língua escondida atrás deles; o ar sai pelo meio: "ssss".
- **Ponto da língua:** ensine a posição de repouso, com a ponta logo atrás dos dentes de cima.
- **Canudo no meio:** soprar por um canudo fino no centro da boca ajuda a sentir a direção do ar.
- **Retirada de hábitos:** planeje com a família a retirada da chupeta e da mamadeira.

Treino em etapas

1. **Som isolado: ssss**
2. **Sílabas: sa, se, si, so, su**
3. **Palavras: sapo, sol, sino**
4. **Frases curtas**
5. **Conversa**

Sinais de atenção

- Ceceio mantido após os 5 anos
- Mordida aberta na frente
- Respiração oral ou ronco
- Outras alterações na fala

Orientação à família

- Ajude a retirar a chupeta e a mamadeira aos poucos.
- Observe se a criança dorme de boca aberta e conte à fono.
- Elogie quando ela fizer o S com os dentes juntinhos.

Base: literatura de fonética clínica e motricidade orofacial

FICHA 10 FONOLOGIA • INFANTIL

S chiado pelo lado da boca

O ar do S **escapa pela lateral** e soa "molhado"



O que é

É o **ceceio lateral**: em vez de sair pelo meio da língua, o ar do S e do Z (às vezes também do CH e do J) escapa por um ou pelos dois lados da boca. O som fica chiado, "molhado".

Diferente de outras alterações, o ceceio lateral **não é uma fase esperada** do desenvolvimento. Não espere passar sozinho.

Como identificar

- Som chiado ou "molhado" no S
- Canto da boca puxado para um lado
- Ar saindo pela lateral ao encostar um canudo no canto da boca
- Pode atingir também o CH e o J

Por onde começar?

Ela produz o T com a ponta da língua atrás dos dentes de cima?

SIM Use o T como ponto de partida
Construa o S a partir do T: "t-t-t" → "tsss" → "sss".

NÃO Trabalhe o controle da língua
Comece pela mobilidade e pela centralização da ponta da língua.

Como avaliar: passo a passo

1. **Escuta atenta**
   Peça palavras com S, Z, CH e J e ouça se o som fica "molhado".
2. **Canudo no canto**
   Encoste um canudo no canto da boca durante o S para perceber o escape.
3. **Lado do escape**
   Observe no espelho se o ar sai por um lado ou pelos dois.
4. **Sons afetados**
   Anote quais sons estão distorcidos: S, Z, CH ou J.
5. **Mobilidade da língua**
   Avalie se ela eleva a ponta e mantém a língua centralizada.
6. **Oclusão**
   Verifique a mordida e peça avaliação odontológica se necessário.

Estratégias de terapia

- **Do T ao S:** "t-t-t" com os dentes juntos, depois "tsss", alongando o ar até virar "sss".
- **Canudo no meio:** soprar por um canudo fino no centro da boca guia o ar pelo meio.
- **Língua em canal:** exercícios para a língua formar um canal no meio, por onde o ar passa.
- **Sem pressa:** só avance de etapa quando o S sair limpo na etapa anterior.

Treino em etapas

1. **Som isolado: tsss → sss**
2. **Sílabas: sa, se, si, so, su**
3. **Palavras: sino, sapo, suco**
4. **Frases curtas**
5. **Conversa**

Sinais de atenção

- Presente em qualquer idade: avalie
- Escape também no CH e no J
- Alterações na mordida
- Criança incomodada com a própria fala

Orientação à família

- Não imite nem brinque com o som da criança.
- Brinquem de "pneu esvaziando": tsss, bem pelo meio.
- Faça em casa os exercícios orientados, alguns minutos por dia.

Base: literatura de fonética clínica e motricidade orofacial

FICHA 11 · FONOLOGIA • INFANTIL

Omissão de sílaba átona

A criança fala **“nana”** em vez de **“banana”**



O que é

É a **redução silábica**: a criança apaga a sílaba fraca (átona) da palavra, geralmente a que vem antes da sílaba forte: “nana” por “banana”, “pato” por “sapato”.

É muito comum entre 1 e 2 anos e costuma desaparecer até **cerca de 3 anos**.

Sílaba forte × sílaba fraca

ba	**na**	na
sa	**pa**	to
bo	**ne**	ca

Em verde, a sílaba forte (tônica). Tracejadas, as sílabas fracas, que podem ser omitidas.

Por onde começar?

Ela bate uma palma para cada sílaba quando você fala junto com ela?

SIM — Leve o ritmo para a fala
Use as palmas como apoio e retire-as aos poucos.

NÃO — Trabalhe ritmo antes
Música, batidas e brincadeiras com sílabas, sem cobrar a fala.

Como avaliar: passo a passo

1. **Nomeação de figuras**
   Palavras com 3 sílabas ou mais: banana, sapato, boneca, macaco, cavalo, telefone.
2. **Qual sílaba some**
   Anote se é a que vem antes da sílaba forte (mais comum) ou outra.
3. **Repetição**
   Peça para repetir palavras longas devagar e compare com a fala espontânea.
4. **Ritmo**
   Observe se ela acompanha palmas e batidas no ritmo das sílabas.
5. **Inteligibilidade**
   Avalie se pessoas de fora da família entendem o que ela fala.
6. **Considere a idade**
   Antes dos 3 anos, a omissão pode ser esperada: acompanhe a evolução.

Estratégias de terapia

- **Trem das sílabas:** cada sílaba é um vagão; a criança fala enquanto empurra os vagões.
- **Palmas e tambor:** uma batida por sílaba, primeiro junto com você, depois sozinha.
- **Destaque a sílaba fraca:** fale-a um pouco mais forte no início e volte ao normal aos poucos.
- **Do curto ao longo:** palavras de 2 sílabas, depois de 3 e, por fim, de 4 sílabas.

Escada de sílabas

1. **2 sílabas: bola, pato**
2. **3 sílabas: banana, sapato**
3. **4 sílabas: telefone, borboleta**

Palavras-alvo

banana · sapato · boneca · macaco · cavalo · panela · telefone

Sinais de atenção

- Omissão mantida após os 3 anos
- Fala muito difícil de entender
- Vocabulário pequeno para a idade
- Dificuldade em acompanhar ritmos

Orientação à família

- Cantem músicas infantis batendo palmas no ritmo.
- Repita a palavra inteira, com calma: “Banana! Quer banana?”
- Leiam histórias com palavras longas e divertidas.

Base: estudos de aquisição fonológica do português brasileiro

FICHA 12 · FONOLOGIA • INFANTIL

Harmonia consonantal

A criança fala **“papato”** em vez de **“sapato”**



O que é

É a **harmonia consonantal** (ou assimilação): uma consoante “copia” outra consoante da mesma palavra: “papato” por “sapato”, “cabebo” por “cabelo”.

É comum nos primeiros anos, quando a criança ainda tem dificuldade de combinar sons diferentes na mesma palavra. Costuma desaparecer até **cerca de 3 anos**.

Para onde o som se espalha

papato
Para trás
O P da sílaba seguinte substitui o S do início.

cabebo
Para a frente
O B da sílaba anterior substitui o L do final.

Nos dois casos, a criança repete um som que já está na palavra.

Por onde começar?

Ela produz os dois sons em palavras diferentes (como em “sapo” e “pato”)?

SIM — Trabalhe a combinação
Ela tem os sons. O desafio é juntá-los na mesma palavra.

NÃO — Trabalhe o som ausente
Primeiro o som que falta (veja a ficha da troca correspondente).

Como avaliar: passo a passo

1. **Nomeação de figuras**
   Palavras com consoantes diferentes: sapato, cabelo, boneca, tomate, cavalo, janela.
2. **Palavras curtas × longas**
   Observe se a harmonia aparece só nas palavras de 3 sílabas ou mais.
3. **Direção**
   Anote se o som se espalha para trás (papato) ou para a frente (cabebo).
4. **Estimulabilidade**
   Ela acerta quando você separa as sílabas: “sa... pa... to”?
5. **Outros processos**
   Veja se há outras trocas e omissões na mesma fala.
6. **Considere a idade**
   Até cerca de 3 anos, a harmonia ainda é esperada.

Estratégias de terapia

- **Sílaba por sílaba:** fale devagar, com uma pequena pausa entre as sílabas, e junte aos poucos.
- **Pista de ponto:** lábios para P, B e M; ponta da língua para T, D e S. Use figuras de apoio.
- **Cartões de sílabas:** monte a palavra com um cartão por sílaba e “leia” cada um com a criança.
- **Progressão:** palavras com consoantes iguais (papai, bebê) e, depois, com consoantes diferentes (sapato).

Treino em etapas

1. **Sílabas separadas: sa · pa · to**
2. **Sílabas juntas, devagar**
3. **Palavra no ritmo normal**
4. **Frase: “Cadê o sapato?”**

Palavras-alvo

sapato · cabelo · boneca · tomate · cavalo · janela

Sinais de atenção

- Harmonia mantida após os 3 anos
- Vários processos ao mesmo tempo
- Fala difícil de entender
- Vocabulário pequeno para a idade

Orientação à família

- Repita a palavra devagar: “Sa-pa-to! Seu sapato!”
- Não peça para repetir: apenas devolva o modelo certo.
- Leiam livros com rimas e palavras que se repetem.

Base: estudos de aquisição fonológica do português brasileiro

FICHA 13 · FONOLOGIA • INFANTIL

Troca do L pelo I

A criança fala **“fior”** em vez de **“flor”**



O que é

É a **semivocalização de líquida**: o L (e às vezes o R) é trocado por um som de vogal, como I: “fior” por “flor”, “iaranja” por “laranja”.

É comum enquanto o L e o R ainda estão sendo adquiridos e tende a desaparecer com eles. Veja as idades de referência nas Fichas 01 e 03.

Erro ou sotaque?

fior
É troca
L no início da sílaba ou no encontro virando I: flor, lua, bola.

sau
Não é troca
L no fim da sílaba soando como U: sal, papel, calça.

No português brasileiro, o L no fim da sílaba soa como U também na fala dos adultos.

Por onde começar?

Ela produz o L entre vogais, como em “bola” e “mala”?

SIM — Trabalhe o L no encontro
Ela tem o som. Leve-o para palavras como flor, planta e blusa.

NÃO — Comece pelo L simples
Ponta da língua atrás dos dentes de cima, cantando “lá-lá-lá”.

Como avaliar: passo a passo

1. **Nomeação de figuras**
   Palavras com L e R: lua, laranja, bola, flor, planta, barata.
2. **Posição na palavra**
   Anote se a troca ocorre no início, entre vogais ou no encontro (fl, pl, bl).
3. **Separe do sotaque**
   Não conte como erro o L do fim da sílaba (sal, papel).
4. **Estimulabilidade**
   Ela faz “lá-lá-lá” com a ponta da língua atrás dos dentes de cima?
5. **Mobilidade da língua**
   Avalie a elevação da ponta da língua e o frênulo lingual.
6. **Outros processos**
   Veja se o R também é trocado e se há outras trocas na fala.

Estratégias de terapia

- **Ponta no lugar:** ponta da língua atrás dos dentes de cima, cantando uma música só com “lá-lá-lá”.
- **Espelho:** no L a ponta da língua sobe; no I ela fica baixa e os lábios sorriem.
- **Vogal de apoio:** nos encontros, fale “fe-lor” e vá acelerando até virar “flor”.
- **Progressão:** L sozinho, depois L entre vogais (bola, mala) e só então os encontros (flor, planta).

Palavras-alvo

lua · laranja · bola · mala · flor · planta · blusa

Sinais de atenção

- Troca no L simples após os 4 anos
- Troca também no R e em outros sons
- Pouca elevação da ponta da língua
- Fala difícil de entender

Orientação à família

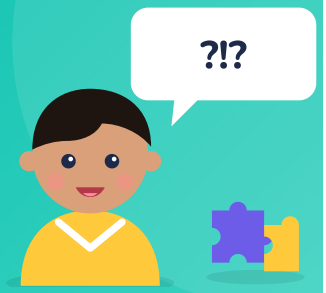
- Cantem músicas com “lá-lá-lá” e “lê-lê-lê”.
- Repita a palavra certa: “Que flor bonita!”
- Não corrija o L do fim da sílaba: ele soa como U mesmo.

Base: estudos de aquisição fonológica do português brasileiro

FICHA 14 · FONOLOGIA • INFANTIL

Fala difícil de entender

Vários processos ao mesmo tempo, além da idade esperada



O que é

Quando vários processos aparecem juntos e persistem além da idade esperada, falamos em **transtorno fonológico** (ou transtorno dos sons da fala).

A fala fica difícil de entender, principalmente para quem não convive com a criança. Ela costuma **compreender bem** e ter audição normal.

Quanto um estranho deve entender

2a · 50% **3a · 75%** **4a · 100%**



Referência clássica de inteligibilidade para ouvintes desconhecidos. Use como orientação, não como regra.

Fonológico ou motor?

Ao repetir a mesma palavra 3 vezes, os erros saem iguais ou mudam?

IGUAIS — Padrão fonológico
Erros consistentes: trabalhe os processos por ordem de prioridade.

MUDAM — Investigue apraxia
Erros inconsistentes podem indicar apraxia de fala (Ficha 15).

Como avaliar: passo a passo

1. **Amostra de fala**
   Grave de 5 a 10 minutos de conversa e brincadeira.
2. **Teste padronizado**
   Aplique uma prova de nomeação e imitação (ex.: ABFW, parte de Fonologia).
3. **Liste os processos**
   Anote cada processo e quantas vezes ele aparece.
4. **Calcule o PCC**
   Porcentagem de Consoantes Corretas: acertos ÷ total de consoantes × 100.
5. **Consistência**
   Peça as mesmas palavras 3 vezes, em momentos diferentes da sessão.
6. **Audição e exame oral**
   Descarte perda auditiva e alterações na estrutura da boca.

Estratégias de terapia

- **Priorize:** comece pelos processos que mais prejudicam a inteligibilidade.
- **Modelo de ciclos:** trabalhe vários processos em rodízio, um de cada vez, em ciclos de algumas semanas.
- **Pares mínimos:** escolha pares que contrastem os processos-alvo (veja as Fichas 01 a 13).
- **Bombardeio auditivo:** no início de cada sessão, leia uma lista curta com o som trabalhado.

Gravidade pelo PCC

> 85%	Leve
65–85%	Levemente moderado
50–65%	Moderadamente grave
< 50%	Grave

Sinais de atenção

- Estranhos não entendem aos 4 anos
- Erros que mudam na mesma palavra
- Frustração ou recusa em falar
- Casos de dificuldade de fala ou leitura na família

Orientação à família

- Não finja que entendeu: peça para a criança mostrar ou apontar.
- Fale devagar, de frente e com frases curtas.
- Elogie a comunicação, não só a fala correta.

Base: literatura de transtornos dos sons da fala na infância

FICHA 15 FONOLOGIA • INFANTIL

Apraxia de fala na infância

A criança sabe o que quer dizer, mas **não coordena** os movimentos



O que é

A **apraxia de fala na infância** é um transtorno motor: o cérebro tem dificuldade de planejar e sequenciar os movimentos da fala, sem fraqueza nos músculos.

A criança costuma compreender muito mais do que fala. O diagnóstico é difícil **antes dos 3 anos** e deve ser feito por fonoaudiólogo.

3 sinais principais

- **Erros inconsistentes em consoantes e vogais quando repete a mesma palavra**
- **Transições difíceis e "quebradas" entre sons e sílabas**
- **Prosódia alterada, principalmente na sílaba forte das palavras**

Características consensuais descritas pela ASHA (Associação Americana de Fala, Linguagem e Audição).

Apraxia ou transtorno fonológico?

Ao repetir a mesma palavra várias vezes, os erros mudam a cada tentativa?

MUDAM **Suspeita de apraxia**
Investigue os sinais motores (veja os passos abaixo).

IGUAIS **Mais sugestivo de fonológico**
Erros consistentes apontam para transtorno fonológico (Ficha 14).

Como avaliar: passo a passo

1. **Repetição tripla**
   Peça a mesma palavra 3 vezes e compare as produções.
2. **Palavras crescentes**
   Aumente as sílabas: "pa", "pato", "sapato", "sapateiro".
3. **Diadococinesia**
   Peça "pa-ta-ka" repetido e veja se a sequência se desorganiza.
4. **Tateio**
   Observe movimentos de "busca" da boca antes de falar.
5. **Automática × voluntária**
   Compare a fala espontânea (ou cantada) com a fala pedida.
6. **Vogais**
   Anote erros nas vogais, comuns na apraxia e menos frequentes em outros quadros.

Estratégias de terapia

- **Prática intensa:** sessões frequentes, com muitas repetições do movimento em cada sessão.
- **Pistas multissensoriais:** combine o que a criança vê, ouve e sente (toques no rosto, espelho, gestos).
- **Ritmo e melodia:** batidas e entonação ajudam a encadear as sílabas.
- **Comunicação alternativa:** gestos e figuras apoiam a comunicação enquanto a fala se desenvolve.

Complexidade crescente

1. **Sílabas simples: pa, ma**
2. **Sílabas repetidas: papa, mama**
3. **Sílabas diferentes: pato, mala**
4. **Palavras longas**
5. **Frases do dia a dia**

Sinais de atenção

- **Pouquíssimas palavras e dificuldade em imitar**
- **Erros diferentes a cada tentativa**
- **Tateio visível ao tentar falar**
- **Fala "robotizada" ou com sílaba forte errada**

Orientação à família

- **Pratique pouco de cada vez, várias vezes por dia.**
- **Aceite gestos e figuras: eles não atrapalham a fala.**
- **Mantenha a terapia regular: a frequência faz diferença.**

Base: ASHA (2007) e literatura sobre apraxia de fala na infância

FICHA 16 LINGUAGEM • INFANTIL

Fala poucas palavras aos 2 anos

Família diz que **"só fala mamã e papá"**



O que é

Chamamos de **falante tardio** a criança de 18 a 30 meses que fala bem menos palavras do que o esperado, mas compreende bem e se desenvolve normalmente nas outras áreas.

Muitas alcançam as outras crianças, mas não dá para saber quais. Por isso a recomendação é **avaliar e acompanhar**, e não só esperar.

Marcos de referência

primeiras palavras | 50+ palavras | Frases de 3+



Aos 2 anos, espera-se cerca de 50 palavras ou mais e frases de 2 palavras.

Por onde começar?

Ela compreende bem o que dizem e usa gestos para se comunicar?

SIM — Perfil de falante tardio
Oriente a família e acompanhe de perto a evolução.

NÃO — Investigue mais
Avalie audição, desenvolvimento global e sinais de TEA (Ficha 35).

Como avaliar: passo a passo

1. **Lista de palavras**
   Com a família, liste as palavras que a criança fala (inventário de vocabulário).
2. **Compreensão**
   Ela atende ordens simples e aponta objetos e partes do corpo?
3. **Gestos**
   Ela aponta, dá tchau, mostra e entrega objetos para pedir ajuda?
4. **Audição**
   Solicite avaliação audiológica em toda criança que fala pouco.
5. **Brincadeira**
   Observe o faz de conta: dar comida para a boneca, falar ao telefone.
6. **Fatores de risco**
   Prematuridade, otites frequentes e casos de atraso na família.

Estratégias e orientação

- **Narração:** fale sobre o que a criança está fazendo, com frases curtas: "Carro rápido!".
- **Expansão:** ela diz "água", você responde "quer água": um passo à frente da fala dela.
- **Espera ativa:** crie oportunidades e espere alguns segundos antes de ajudar.
- **Leitura diária:** livros de figuras, nomeando e apontando juntos.

Esperado aos 2 anos

1. Fala 50 palavras ou mais
2. Junta 2 palavras
3. Segue ordens simples
4. Aponta para mostrar

Sinais de atenção

- Não compreende ordens simples
- Não aponta nem usa gestos
- Perdeu palavras que já falava
- Pouco interesse em interagir

Orientação à família

- Desligue a TV de fundo durante as brincadeiras.
- Narre o dia: "Agora vamos tomar banho!"
- Espere a criança tentar antes de dar o que ela quer.

Base: literatura de desenvolvimento da linguagem infantil

FICHA 17 LINGUAGEM • INFANTIL

Não junta duas palavras

Fala “água”, mas ainda não “quer água”



O que é

Por volta dos 2 anos, a criança começa a **combinar duas palavras**: “qué água”, “mamãe vem”, “cabô suco”. É um marco importante da linguagem expressiva.

Quando as combinações não aparecem até **2 anos e meio**, mesmo com algumas palavras soltas, é sinal de atraso e merece avaliação.

Primeiras combinações

Pedido
“qué bola”
“mais suco”

Ação
“nenê dorme”
“papai foi”

Negação
“não qué”
“cabô água”

Gesto + palavra (apontar e dizer “água”) costuma vir antes das frases de 2 palavras.

Por onde começar?

Ela já fala cerca de 50 palavras, incluindo algumas ações?

SIM Pronta para combinar
Modele frases de 2 palavras nas rotinas e brincadeiras.

NÃO Amplie o vocabulário
Trabalhe primeiro novas palavras, inclusive verbos (Ficha 16).

Como avaliar: passo a passo

1. **Lista de palavras**
   Conte as palavras que ela fala e separe nomes, ações e outras.
2. **Gesto + palavra**
   Observe se ela combina gesto e palavra (apontar e dizer “água”).
3. **Compreensão**
   Ela entende frases simples, como “dá a bola pra mamãe”?
4. **Tipos de palavra**
   Fala só nomes de objetos ou também ações (abre, dá, cai)?
5. **Imitação**
   Ela tenta repetir frases curtas de 2 palavras?
6. **Audição**
   Confirme a avaliação audiológica, se ainda não foi feita.

Estratégias de terapia

- **Expansão:** ela diz “bola”, você diz “chuta bola!” ou “bola azul!”.
- **Palavras-pivô:** use palavras como mais, quer, acabou e cadê, combinadas com nomes.
- **Frase do tamanho certo:** fale com frases de 2 a 3 palavras, um passo à frente dela.
- **Rotinas repetidas:** banho, lanche e esconde-esconde, sempre com as mesmas frases.

Palavras-pivô

mais · quer · acabou · cadê · não · abre · dá

Frases-modelo

1. mais suco
2. cadê papai?
3. abre porta
4. acabou água

Sinais de atenção

- Não combina palavras aos 2 anos e meio
- Usa quase só nomes de objetos
- Não compreende frases simples
- Pouca imitação de sons e palavras

Orientação à família

- Expanda a fala: “carro” vira “carro azul!”.
- Brinque de esconder: “Cadê o urso? Achou!”
- Ofereça escolhas: “Suco ou água?”, em vez de perguntas de sim ou não.

Base: literatura de desenvolvimento da linguagem infantil

FICHA 18 LINGUAGEM • INFANTIL

Fala de si na terceira pessoa

A criança diz **“Lulu qué”** em vez de **“eu quero”**



O que é

Muitas crianças pequenas falam de si pelo nome (“Lulu qué”) antes de usar “eu”. É uma **fase comum** da aquisição dos pronomes.

Os pronomes “eu” e “você” costumam aparecer entre 2 e 3 anos. O uso do nome no lugar de “eu” tende a sumir até **cerca de 3 anos**.

Fase comum × atenção

“Lulu qué”
Fase comum
Usa o próprio nome para falar de si, por volta de 2 a 3 anos.

“Você qué?”
Atenção
Usa “você” para pedir algo para si (inversão de pronomes).

Fase ou sinal de atenção?

Ela usa “você quer...?” para pedir algo para si mesma?

SIM — Investigue mais
Avalie ecolalia e sinais de TEA (Fichas 28 e 35).

NÃO — Fase esperada
Modele o uso do “eu” no dia a dia, sem cobrar.

Como avaliar: passo a passo

1. **Observe na brincadeira**
   Veja como ela se refere a si mesma e às outras pessoas.
2. **Compreensão**
   Ela entende “mostra o seu nariz” e “mostra o meu nariz”?
3. **Outros pronomes**
   Ela usa meu, seu, ele e ela? Anote os que já aparecem.
4. **Ecolalia**
   Ela repete frases prontas de desenhos ou de adultos?
5. **Interação**
   Observe contato visual, apontar e atenção compartilhada.
6. **Considere a idade**
   Até cerca de 3 anos, usar o próprio nome é esperado.

Estratégias de terapia

- **Fale por ela:** no momento do pedido, modele em primeira pessoa: “Eu quero suco!”.
- **Espelho:** aponte para si dizendo “eu” e para a criança dizendo “você”.
- **Jogos de vez:** “minha vez”, “sua vez”, passando um objeto de mão em mão.
- **Adultos em primeira pessoa:** troque “a mamãe vai pegar” por “eu vou pegar”.

Pronomes-alvo

eu · você · meu · seu · minha · sua

Frases-modelo

1. eu quero
2. minha vez
3. é meu
4. você pega

Sinais de atenção

- Inversão eu/você após os 3 anos
- Repete falas de desenho fora de contexto
- Pouco contato visual ou interação
- Perdeu palavras que já falava

Orientação à família

- Fale de si como “eu”, e não como “mamãe” ou “papai”.
- Brinquem de “minha vez, sua vez”.
- Repita o pedido do jeito certo: “Eu quero água!”

Base: literatura de desenvolvimento da linguagem infantil

FICHA 19 LINGUAGEM • INFANTIL

Frases curtas e telegráficas

A criança diz **“nenê bola”** em vez de **“o nenê quer a bola”**



O que é

Na **fala telegráfica**, a criança usa só as palavras principais e omite artigos, preposições e terminações dos verbos. Entre 2 e 3 anos, isso é esperado.

Aos 3 anos, as frases já têm 3 ou 4 palavras. Dificuldade persistente com a estrutura da frase é um dos sinais do **TDL** (Ficha 27).

O que está faltando

nenê qué bola
Telegráfica
Só as palavras principais.

o nenê quer a bola
Completa
Com artigos e verbo flexionado.

Observe a falta de artigos (o, a), preposições (de, no), plural e tempos verbais.

Por onde começar?

Ela compreende frases longas e perguntas (quem? onde? o quê?)?

SIM Foco na expressão
Trabalhe a construção da frase, um elemento por vez.

NÃO Investigue a compreensão
Avalie compreensão e sinais de TDL (Fichas 21 e 27).

Como avaliar: passo a passo

1. **Amostra de fala**
   Grave uma conversa e transcreva cerca de 50 frases da criança.
2. **Extensão das frases**
   Calcule a média de palavras por frase (extensão média do enunciado).
3. **O que falta**
   Anote ausência de artigos, preposições, plural e tempos verbais.
4. **Compreensão**
   Teste frases com “quem”, “onde” e “o quê”, sem apoio de gestos.
5. **Repetição de frases**
   Ela repete frases de 4 a 5 palavras sem omitir partes?
6. **Histórico**
   Pergunte sobre atraso de fala e dificuldades escolares na família.

Estratégias de terapia

- **Reformulação:** ela diz “nenê qué bola”, você responde “o nenê quer a bola!”, sem corrigir.
- **Apoio visual:** um cartão para cada parte da frase: quem, faz o quê, onde.
- **Um alvo por vez:** escolha um elemento (ex.: artigos) e repita-o muito nas brincadeiras.
- **Histórias com figuras:** ela conta o que vê, com frases cada vez mais completas.

Construindo a frase

1. **Quem: o nenê**
2. **+ faz: o nenê come**
3. **+ o quê: ... a maçã**
4. **+ onde: ... na mesa**

Sinais de atenção

- Frases de 2 palavras após os 3 anos
- Erros de concordância após os 4 anos
- Dificuldade para compreender frases
- Casos de atraso de linguagem na família

Orientação à família

- Repita a frase completa, sem corrigir: “Isso! O nenê quer a bola.”
- Leiam livros e peça para ela contar o que vê.
- Converse durante as rotinas, com frases curtas e completas.

Base: literatura de desenvolvimento da linguagem infantil

FICHA 20 LINGUAGEM • INFANTIL

Dificuldade para achar a palavra

A criança diz **“é... aquilo... aquela coisa...”**



O que é

É a **dificuldade de evocação lexical**: a criança conhece a palavra (entende quando ouve), mas não consegue “buscá-la” na hora de falar.

Pode aparecer sozinha ou junto com TDL, dislexia e TDAH. É diferente de vocabulário pequeno, em que a palavra **ainda não foi aprendida**.

Como aparece

- Pausas e hesitações: “é... é...”
- Palavras genéricas: “coisa”, “isso”, “aquilo”
- Descreve em vez de nomear: “aquilo de cortar”
- Troca por palavra parecida: “garfo” por “colher”
- Gestos no lugar da palavra

Evocação ou vocabulário?

Ela aponta a figura certa quando você fala o nome?

SIM Dificuldade de evocação
Ela conhece a palavra, mas não consegue acessá-la.

NÃO Vocabulário
Ela ainda não aprendeu a palavra: ensine o vocabulário.

Como avaliar: passo a passo

1. **Nomeação de figuras**
   Anote os erros e o tempo que ela leva para responder.
2. **Reconhecimento**
   Peça para apontar as mesmas figuras e compare com a nomeação.
3. **Fluência verbal**
   “Fale o máximo de animais que conseguir em 1 minuto.”
4. **Tipo de erro**
   A troca é por palavra de mesmo sentido (garfo/colher) ou de som parecido?
5. **Efeito da pista**
   Ela acerta quando você diz a primeira sílaba (“ca...”)?
6. **Escola**
   Investigue queixas de leitura, escrita e atenção.

Estratégias de terapia

- **Pistas de sentido:** “é um animal, late e tem rabo”.
- **Pistas de som:** diga o primeiro som ou sílaba: “ca...” para cachorro.
- **Teia da palavra:** explore categoria, função, lugar, partes e som inicial de cada palavra nova.
- **Estratégia própria:** ensine a criança a descrever a palavra quando ela “sumir”.

Perguntas da teia

1. **Categoria: é um...**
2. **Função: serve para...**
3. **Lugar: onde encontro?**
4. **Como é: cor, partes**
5. **Som: começa com...**

Sinais de atenção

- Pausas longas e frustração ao falar
- Uso frequente de “coisa” e “aquilo”
- Dificuldades escolares associadas
- Entende muito mais do que consegue falar

Orientação à família

- Dê tempo: não complete a frase rápido demais.
- Se ela travar, dê uma pista: “Começa com ca...”.
- Brinquem de categorias: falar frutas, bichos e cores.

Base: literatura de desenvolvimento da linguagem infantil

FICHA 21 LINGUAGEM • INFANTIL

Não compreende ordens simples

Não atende a pedidos como **"pega o bloco azul"**



O que é

A **compreensão vem antes da fala**. Quando a criança não entende pedidos simples, a fala também tende a atrasar.

Antes de pensar em linguagem, é preciso investigar **audição, atenção e desenvolvimento**. Muitas crianças parecem entender só porque se apoiam no contexto.

Ordens esperadas por idade



Ex.: "dá tchau" (com gesto), "pega o sapato" (1 etapa), "pega o sapato e guarda" (2 etapas).

Por onde começar?

Ela reage a sons e responde quando é chamada pelo nome?

SIM — Avalie a compreensão
Teste ordens e vocabulário sem pistas do contexto.

NÃO — Priorize audição e TEA
Avaliação auditiva e investigação de TEA (Fichas 29 e 35).

Como avaliar: passo a passo

1. **Audição**
   Solicite avaliação audiológica antes de qualquer conclusão.
2. **Sem pistas**
   Dê a ordem sem olhar nem apontar para o objeto pedido.
3. **Complexidade**
   Comece com ordens de 1 etapa e passe para 2 etapas.
4. **Vocabulário receptivo**
   Peça para apontar figuras: "Cadê o cachorro?".
5. **Conceitos**
   Teste em cima/embaixo, dentro/fora, grande/pequeno.
6. **Atenção**
   Observe se ela sustenta a atenção durante a tarefa.

Estratégias de terapia

- **Atenção primeiro:** chame pelo nome e espere o olhar antes de falar.
- **Fale menos, mostre mais:** frases curtas, com gestos e objetos reais.
- **Retirada de pistas:** comece com gesto e fala; depois, só a fala.
- **Ordens da rotina:** "põe no lixo", "pega o sapato": primeiro com ajuda, depois sozinha.

Ordens por nível

1. **Com gesto: "dá tchau"**
2. **1 etapa: "pega a bola"**
3. **2 etapas: "pega a bola e põe na caixa"**

Sinais de atenção

- Não reage a sons nem ao nome
- Não entende ordens simples aos 2 anos
- Parece entender só pelo contexto
- Deixou de compreender o que já entendia

Orientação à família

- Chame pelo nome e espere o olhar antes de falar.
- Use frases curtas e mostre o que está pedindo.
- Transforme pedidos em brincadeira: "O urso quer a bola!"

Base: literatura de desenvolvimento da linguagem infantil

FICHA 22 LINGUAGEM • INFANTIL

Não consegue contar o que aconteceu

A história sai **solta e sem ordem**



O que é

A **narrativa** é a capacidade de contar fatos e histórias em ordem: quem, onde, o que aconteceu e como terminou. Ela depende de vocabulário, gramática, memória e organização do pensamento.

Dificuldade persistente para narrar é comum no **TDL** (Ficha 27) e costuma se refletir, mais tarde, na leitura e na escrita.

Como a narrativa evolui

~3 anos
Fatos soltos
Fala de coisas que viu, sem ligar uma à outra.

~4 anos
Sequência
Conta ações em ordem simples: "e depois...".

5–6 anos
História
Começo, meio e fim, com problema e solução.

Idades aproximadas. Há variação individual.

Por onde começar?

Ela organiza a história quando tem figuras em sequência para apoiar?

SIM — Retire o apoio aos poucos
Ela organiza com ajuda. Diminua as figuras até contar sozinha.

NÃO — Trabalhe a base
Vocabulário, frases e ordem dos fatos antes da história completa.

Como avaliar: passo a passo

1. **Reconto com figuras** — Conte uma história curta com 3 a 4 cenas e peça para ela recontar.
2. **Narrativa pessoal** — Pergunte: "O que você fez no fim de semana?" e grave a resposta.
3. **Elementos** — Ela diz quem, onde, o que aconteceu e como terminou?
4. **Ordem** — Os fatos aparecem na sequência certa ou embaralhados?
5. **Conectivos** — Ela usa palavras de ligação: e, depois, porque, então?
6. **Compreensão** — Faça perguntas sobre a história para ver se ela entendeu.

Estratégias de terapia

- **Sequência de figuras:** ela organiza 3 ou 4 cenas na ordem e conta a história.
- **Perguntas-guia:** quem? onde? o que aconteceu? como terminou?
- **Palavras de ligação:** ensine "primeiro", "depois", "no final" e "porque".
- **Histórias da vida real:** use fotos de passeios e da rotina para contar o que aconteceu.

Mapa da história

1. Quem?
2. Onde?
3. O que aconteceu?
4. Como resolveu?
5. Como terminou?

Sinais de atenção

- Aos 5 anos, não conta fatos em ordem
- Histórias sem começo, meio e fim
- Frases curtas e vocabulário restrito
- Dificuldade para entender histórias

Orientação à família

- No fim do dia, pergunte: "O que foi mais legal hoje?"
- Leiam juntos e peça para ela recontar com as figuras.
- Olhem fotos de passeios e contem juntos o que aconteceu.

Base: literatura de desenvolvimento da linguagem infantil

FICHA 23 LINGUAGEM • INFANTIL

Vocabulário pobre para a idade

Usa **“isso”** e **“aquilo”** para quase tudo



O que é

É quando a criança conhece e usa **menos palavras do que o esperado** para a idade. Ela troca nomes específicos por palavras genéricas, como “isso”, “aquilo” e “coisa”.

O vocabulário é a base da conversa, da compreensão de textos e da aprendizagem escolar. Por isso merece atenção **desde cedo**.

Os dois vocabulários

Receptivo
As palavras que a criança entende quando ouve.

Expressivo
As palavras que a criança fala.

É normal entender mais do que falar. Avalie os dois separadamente.

Por onde começar?

Ela entende as palavras quando ouve, mas não as usa ao falar?

SIM Foco no vocabulário expressivo
Ela conhece. Trabalhe o uso e a evocação (Ficha 20).

NÃO Ensine o significado
Comece pelo vocabulário receptivo: entender vem antes de falar.

Como avaliar: passo a passo

1. **Prova de vocabulário**
   Use um instrumento padronizado (ex.: ABFW, parte de Vocabulário).
2. **Receptivo × expressivo**
   Compare o que ela aponta com o que ela consegue nomear.
3. **Categorias**
   Veja quais campos estão mais fracos: alimentos, animais, ações, roupas.
4. **Tipos de palavra**
   Ela usa verbos, adjetivos e palavras de lugar, ou só nomes?
5. **Palavras genéricas**
   Anote quantas vezes usa “isso”, “aquilo” e “coisa”.
6. **Contexto**
   Pergunte sobre leitura em casa, telas e conversas no dia a dia.

Estratégias de terapia

- **Ensino por temas:** trabalhe um campo por vez (comida, casa, animais), com objetos reais.
- **Muitas repetições:** use a mesma palavra várias vezes, em brincadeiras diferentes.
- **Leitura compartilhada:** leia conversando, apontando, perguntando e explicando palavras novas.
- **Teia da palavra:** categoria, função, partes e som inicial ajudam a fixar (Ficha 20).

Ensinar uma palavra

1. **Mostre o objeto real**
2. **Nomeie várias vezes**
3. **Use na brincadeira**
4. **Peça para ela apontar**
5. **Peça para ela nomear**

Sinais de atenção

- Uso constante de “isso” e “aquilo”
- Vocabulário bem abaixo das outras crianças
- Dificuldade para aprender palavras novas
- Dificuldade de compreensão na escola

Orientação à família

- Nomeie tudo nas rotinas: “a colher, o prato, o garfo”.
- Use palavras novas e explique: “Enorme é muito grande!”
- Leiam todos os dias, conversando sobre as figuras.

Base: literatura de desenvolvimento da linguagem infantil

FICHA 24 | LINGUAGEM • INFANTIL

Não responde a "por quê?" e "como?"

Responde **fora do contexto** às perguntas abertas



O que é

As perguntas são compreendidas **em uma ordem previsível**: primeiro as concretas (o quê? onde?), depois as que exigem raciocínio (por quê? como? quando?).

Quando a criança responde "na escola" para "por que você está chorando?", ela mostra que **não reconheceu o tipo de pergunta**.

Ordem de aquisição

~2–3 anos
O quê? Onde?
Objetos e lugares que ela vê.

~3 anos
Quem? De quem?
Pessoas e posse.

~4–5 anos
Por quê? Como?
Causa, modo e tempo (quando?).

Idades aproximadas. Há variação individual.

Por onde começar?

Ela responde bem às perguntas "o quê?" e "onde?"?

SIM — Avance para as abstratas
Trabalhe "por quê?" e "como?" com apoio visual.

NÃO — Comece pelas concretas
Primeiro "o quê?" e "onde?", com objetos e figuras.

Como avaliar: passo a passo

1. **Perguntas por tipo**
   Faça perguntas de cada tipo usando figuras e anote os acertos.
2. **Tipo de resposta**
   A resposta combina com a pergunta? "Onde?" pede lugar; "quem?", pessoa.
3. **Palavras de causa e tempo**
   Ela entende "porque", "antes", "depois" e "quando"?
4. **Repetição da pergunta**
   Ela repete a pergunta em vez de responder (Ficha 28)?
5. **Compreensão geral**
   Avalie se a dificuldade é só com perguntas ou com frases em geral.
6. **Atenção e memória**
   Observe se ela esquece a pergunta antes de responder.

Estratégias de terapia

- **Ícones das perguntas:** um símbolo para cada pergunta (rosto para "quem?", casa para "onde?").
- **Situações com figuras:** "Por que o menino está chorando?" Mostre a cena e as pistas.
- **Modele a resposta:** se ela não souber, responda por ela ("Porque ele caiu.").
- **Causa e consequência:** livros e brincadeiras em que uma ação leva a outra.

Ordem de trabalho

1. O quê? → 2. Onde? → 3. Quem? → 4. Por quê? → 5. Como? → 6. Quando?

Sinais de atenção

- Respostas fora do contexto aos 5 anos
- Repete a pergunta em vez de responder
- Dificuldade de compreensão em geral
- Dificuldade de atenção nas conversas

Orientação à família

- Pergunte "por quê?" nas rotinas: "Por que vamos pôr o casaco?"
- Se ela não souber, dê a resposta como exemplo.
- Na leitura, pergunte: "O que vai acontecer agora?"

Base: literatura de desenvolvimento da linguagem infantil

FICHA 25 LINGUAGEM • INFANTIL

Criança bilíngue: atraso ou fase?

Mistura as línguas: **“quero water”**



O que é

Crianças bilíngues atingem os marcos de linguagem em **tempos parecidos** com os das monolíngues. O bilinguismo, por si só, não causa atraso nem transtorno de linguagem.

O vocabulário costuma estar dividido entre as línguas: somando as duas, ele é comparável ao de outras crianças. **Misturar as línguas é normal.**

Esperado × atenção

Esperado

Misturar palavras; vocabulário dividido; período de silêncio ao entrar em contato com uma língua nova.

Atenção

Dificuldade nas duas línguas, mesmo com boa exposição a ambas.

Bilinguismo ou transtorno?

A dificuldade aparece também na língua mais forte da criança?

SIM — Investigue transtorno

Um transtorno de linguagem aparece nas duas línguas.

NÃO — Efeito do bilinguismo

Oriente a família e acompanhe a evolução.

Como avaliar: passo a passo

1. **História linguística**
   Desde quando ouve cada língua, com quem e por quanto tempo por dia.
2. **Avalie as duas línguas**
   Use um familiar ou intérprete na língua que você não domina.
3. **Vocabulário total**
   Some os conceitos conhecidos nas duas línguas, sem contar repetidos.
4. **Compreensão**
   Teste ordens e perguntas na língua mais forte da criança.
5. **Compare com pares**
   Compare com crianças de experiência bilíngue parecida.
6. **Audição**
   Descarte perda auditiva, como em qualquer atraso de fala.

Estratégias e orientação

- **Língua da família:** cada adulto fala com a criança na língua que domina melhor.
- **Exposição rica:** leitura, música e conversas nas duas línguas.
- **Mistura sem bronca:** responda com naturalidade e devolva o modelo completo.
- **Terapia nas duas línguas:** considere as duas na avaliação e na escolha dos alvos.

Mitos comuns

1. **“Duas línguas confundem”**
2. **“Pare de falar a língua de casa”**
3. **“Misturar é sinal de problema”**
4. **Nenhum tem apoio científico**

Sinais de atenção

- Dificuldade nas duas línguas
- Não compreende ordens simples em nenhuma das línguas
- Evolução muito lenta, mesmo com boa exposição
- Casos de atraso de linguagem na família

Orientação à família

- Fale com a criança na língua em que você se sente à vontade.
- Não deixe de falar a língua de casa por causa da escola.
- Leiam e cantem nas duas línguas.

Base: literatura sobre desenvolvimento de linguagem em crianças bilíngues

FICHA 26 LINGUAGEM • INFANTIL

Só aponta e não fala

Pede tudo **por gestos**



O que é

Apontar é um **ótimo sinal de intenção comunicativa**: a criança quer se comunicar e sabe usar o corpo para isso. O desafio é transformar o gesto em palavra.

É importante diferenciar o gesto comunicativo do uso da mão do adulto como ferramenta, que pode ser **sinal de TEA**.

Que tipo de gesto?

Comunicativo
Aponta, olha para você e de volta para o objeto.

Atenção
Pega a sua mão e leva até o objeto, sem olhar para você.

Por onde começar?

Ela aponta e alterna o olhar entre você e o objeto?

APONTA E OLHA Gesto → palavra
Boa base: transforme os gestos em sons e palavras.

LEVA A MÃO Investigue mais
Avalie interação e sinais de TEA (Ficha 35).

Como avaliar: passo a passo

1. **Gestos**
   Liste os gestos que ela usa: apontar, dar tchau, mandar beijo, balançar a cabeça.
2. **Sons**
   Ela produz sons, sílabas ou tentativas de palavras junto com os gestos?
3. **Imitação**
   Ela imita sons de bichos, de carro e sílabas simples?
4. **Compreensão**
   Ela entende ordens simples sem você apontar?
5. **Audição**
   Solicite avaliação audiológica.
6. **Tentativas motoras**
   Se ela tenta falar e não consegue, investigue apraxia (Ficha 15).

Estratégias de terapia

- **Gesto + palavra:** quando ela apontar, diga a palavra com ênfase: “Bola!”.
- **Espera ativa:** dê alguns segundos para ela tentar falar antes de entregar.
- **Aceite aproximações:** “bó” para bola é uma vitória e merece elogio.
- **Sinais e figuras:** funcionam como ponte para a fala e não atrapalham.

Do gesto à palavra

1. **Aponta**
2. **Aponta + som**
3. **Aponta + sílaba: “bó”**
4. **Palavra: “bola”**
5. **Frase: “quer bola”**

Sinais de atenção

- Nenhuma palavra aos 16 meses
- Leva a mão do adulto em vez de apontar
- Não imita sons nem palavras
- Perdeu palavras que já falava

Orientação à família

- Quando ela apontar, diga o nome do objeto.
- Comemore qualquer tentativa de som ou palavra.
- Não exija a palavra para entregar o que ela quer.

Base: literatura de desenvolvimento da linguagem infantil

FICHA 27 | LINGUAGEM • INFANTIL

Transtorno de linguagem (TDL)

Dificuldade de linguagem **persistente**, sem causa aparente



O que é

O **Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem** é uma dificuldade de linguagem que persiste ao longo do tempo e afeta a vida diária e escolar, sem ser explicada por perda auditiva, deficiência intelectual, TEA ou lesão.

Atinge cerca de **7 em cada 100 crianças**. Antes dos 4 a 5 anos, costuma-se falar em atraso, porque parte das crianças evolui sozinha.

Sinais mais comuns

- Erros de gramática persistentes (“eu fazi”)
- Frases curtas e simples para a idade
- Dificuldade para aprender palavras novas
- Dificuldade para entender frases longas
- Narrativa desorganizada (Ficha 22)

TDL ou outro quadro?

A dificuldade é explicada por outra condição (perda auditiva, TEA, deficiência intelectual)?

SIM — Linguagem associada
Trate a linguagem dentro do quadro principal.

NÃO — Considere TDL
Dificuldade persistente sem outra causa conhecida.

Como avaliar: passo a passo

1. **História**
   Desenvolvimento da fala e casos de TDL ou dislexia na família.
2. **Testes padronizados**
   Avalie vocabulário, gramática e compreensão (ex.: ABFW).
3. **Amostra de fala**
   Analise a extensão das frases e os erros de gramática (Ficha 19).
4. **Repetição**
   Repetição de palavras inventadas e de frases é muito sensível ao TDL.
5. **Audição**
   Descarte perda auditiva com avaliação audiológica.
6. **Equipe**
   Peça avaliação psicológica para descartar outras causas.

Estratégias de terapia

- **Alvos funcionais:** escolha o que mais pesa na vida da criança (conversa, escola, amigos).
- **Muitas repetições:** o mesmo alvo em contextos variados, sessão após sessão.
- **Reformulação:** devolva a frase correta, sem corrigir (“Eu fiz!”). Veja a Ficha 19.
- **Parceria com a escola:** instruções curtas, apoio visual e checagem da compreensão.

Áreas para avaliar

vocabulário | gramática | compreensão | narrativa | fonologia | pragmática

Sinais de atenção

- Dificuldade que persiste após os 5 anos
- Casos de TDL ou dislexia na família
- Dificuldade com leitura e escrita
- Isolamento ou frustração com os colegas

Orientação à família

- Fale de frente, com frases curtas e claras.
- Confirme se ela entendeu pedindo que explique com as palavras dela.
- Converse com a escola sobre o diagnóstico e as adaptações.

Base: consenso CATALISE (2017) e literatura sobre TDL

FICHA 28 TEA • COMUNICAÇÃO

Repete falas (ecolalia)

Repete a pergunta ou **frases de desenho**



O que é

A **ecolalia** é a repetição de palavras ou frases ditas por outras pessoas. Imitar faz parte do desenvolvimento típico até cerca de 2 a 3 anos.

Quando persiste ou é a principal forma de comunicar, é um dos sinais associados ao **TEA**. Muitas vezes ela tem função: pedir, protestar ou se acalmar.

Dois tipos

agora
Imediata
Repete logo após ouvir: "Quer suco?" → "Quer suco?"

depois
Tardia
Repete horas ou dias depois, como falas de desenhos.

Qual é a função?

A repetição parece ter uma intenção (pedir, protestar, brincar, participar)?

SIM Use a função
Responda à intenção e modele a forma certa de dizer.

NÃO Pode ser autorregulação
Observe quando acontece. Não proíba nem puna.

Como avaliar: passo a passo

1. **Registre exemplos**
   Anote o que ela repete, quando, com quem e o que acontece depois.
2. **Função**
   Classifique: pedido, protesto, resposta, autorregulação ou brincadeira.
3. **Fala espontânea**
   Ela também produz frases próprias, além das repetidas?
4. **Compreensão**
   Avalie se ela entende o significado do que repete.
5. **Outros sinais**
   Observe interação, contato visual e interesses restritos.
6. **Encaminhamento**
   Se houver suspeita de TEA, encaminhe para avaliação médica e multiprofissional.

Estratégias de terapia

- **Responda à intenção:** se ela diz "quer suco?" querendo suco, entregue e modele: "Eu quero suco."
- **Fale como ela falaria:** use frases que ela possa repetir do jeito certo, na primeira pessoa.
- **Menos perguntas:** troque "você quer?" por escolhas com os objetos à vista.
- **Frases úteis:** ensine frases curtas e funcionais que ela possa reaproveitar.

Funções comuns

1. **Pedir algo**
2. **Recusar ou protestar**
3. **Responder ("sim")**
4. **Participar da conversa**
5. **Acalmar-se**

Sinais de atenção

- Ecolalia como principal forma de fala após os 3 anos
- Pouca fala espontânea
- Pouco contato visual ou interação
- Interesses muito restritos

Orientação à família

- Responda ao que ela quer dizer, não só às palavras.
- Fale do jeito que ela poderia repetir: "Eu quero água."
- Não brigue nem proíba a repetição.

Base: literatura sobre comunicação no Transtorno do Espectro Autista

FICHA 29 | TEA • COMUNICAÇÃO

Não responde quando chamado pelo nome

A família diz: **"Parece que não ouve"**



O que é

Responder ao próprio nome é um **marco social** esperado por volta dos 9 a 12 meses: o bebê vira a cabeça e olha para quem chamou.

Não responder ao nome pode ter duas causas principais: **perda auditiva** ou dificuldade de atenção social, como no TEA. As duas precisam ser investigadas.

Marcos de referência

~6 meses
Vira para sons
Procura vozes e barulhos.

9–12 meses
Responde ao nome
Olha para quem chamou.

12 meses
Sinal de alerta
Se ainda não responde.

Por onde começar?

Ela reage a outros sons, como música ou embalagem de biscoito?

SIM — Investigue atenção social
Observe interação e sinais de TEA. Ainda assim, confirme a audição.

NÃO — Priorize a audição
Peça avaliação audiológica completa o quanto antes.

Como avaliar: passo a passo

1. **Teste do nome**
   Chame 2 ou 3 vezes, de lado ou de trás, sem tocar e sem outros estímulos.
2. **Audição**
   Solicite avaliação audiológica completa, adequada à idade.
3. **Contexto**
   Ela responde em casa? Só quando ouve algo de que gosta?
4. **Atenção compartilhada**
   Ela segue o seu olhar e o seu apontar? (Ficha 30)
5. **Rastreio**
   Entre 16 e 30 meses, aplique o M-CHAT-R/F (Ficha 35).
6. **Encaminhamento**
   Se houver sinais de TEA, encaminhe para avaliação médica e multiprofissional.

Estratégias de terapia

- **Nome = coisa boa:** chame e, quando ela olhar, ofereça algo de que gosta ou uma brincadeira.
- **Entre no campo de visão:** chame na altura dos olhos dela, a uma distância curta.
- **Sem repetir à toa:** não chame o nome várias vezes seguidas sem esperar a resposta.
- **Jogos de pessoa:** cócegas, esconde-achou e cavalinho aumentam o interesse pelo adulto.

Treino do nome

1. **Perto e de frente**
2. **Perto e de lado**
3. **Longe e de frente**
4. **Longe e de costas**
5. **Com distrações**

Sinais de atenção

- Não responde ao nome aos 12 meses
- Não reage a sons do ambiente
- Não aponta nem segue o apontar
- Perdeu habilidades que já tinha

Orientação à família

- Chame pelo nome uma vez e espere alguns segundos.
- Quando ela olhar, sorria e faça algo divertido.
- Se ainda não foi feita, leve a criança para avaliação auditiva.

Base: literatura sobre comunicação no Transtorno do Espectro Autista

FICHA 30 TEA • COMUNICAÇÃO

Não aponta para mostrar

Aponta para **pedir**, mas não para **compartilhar**



O que é

A **atenção compartilhada** é olhar para a mesma coisa que outra pessoa e saber que ela também está olhando. Apontar para mostrar ("olha o avião!") é a sua forma mais clara.

Apontar para mostrar costuma surgir entre 12 e 14 meses. A ausência aos **18 meses** é um sinal de alerta importante para TEA.

Dois jeitos de apontar

Para pedir
"Quero aquilo." Aponta para conseguir um objeto.

Para mostrar
"Olha aquilo!" Aponta e olha para você, para dividir o interesse.

Apontar só para pedir não substitui o apontar para mostrar.

Por onde começar?

Ela aponta para pedir o que quer?

SIM Trabalhe o mostrar
Ela já aponta. Leve o gesto para situações de compartilhar.

NÃO Comece pelo pedido
Ensine gestos para conseguir o que quer, depois o mostrar.

Como avaliar: passo a passo

1. **Segue o apontar**
   Aponte para algo interessante: ela olha para onde você apontou?
2. **Segue o olhar**
   Olhe para um objeto sem apontar: ela acompanha o seu olhar?
3. **Mostra objetos**
   Ela traz brinquedos só para mostrar, sem querer ajuda?
4. **Alterna o olhar**
   Ela olha para o objeto e depois para você, como quem comenta?
5. **Rastreio**
   Entre 16 e 30 meses, aplique o M-CHAT-R/F (Ficha 35).
6. **Outros sinais**
   Observe resposta ao nome, sorriso social e brincadeira.

Estratégias de terapia

- **Siga o interesse dela:** comente o que ela já está olhando, em vez de mudar o foco.
- **Aponte com emoção:** "Olha!" com entusiasmo, olhando para o objeto e depois para ela.
- **Brinquedos-surpresa:** com bolhas, balões e piões, pare a brincadeira e espere o olhar.
- **Mostrar e dar:** comemore quando ela trouxer algo para mostrar.

Sequência esperada

1. **Segue o seu olhar**
2. **Segue o seu apontar**
3. **Aponta para pedir**
4. **Aponta para mostrar**
5. **Traz objetos para mostrar**

Sinais de atenção

- Não aponta para mostrar aos 18 meses
- Não segue o apontar do adulto
- Não responde ao nome
- Pouco sorriso social

Orientação à família

- Mostre coisas no passeio: "Olha o cachorro!"
- Comemore quando ela mostrar algo para você.
- Brinque de bolhas de sabão, pausando para ela pedir mais.

Base: literatura sobre comunicação no Transtorno do Espectro Autista

FICHA 31 TEA • COMUNICAÇÃO

Pouco contato visual na interação

Evita o olhar e **prefere os objetos**



O que é

O olhar é uma das bases da comunicação: com ele a criança pede, mostra, compartilha e acompanha a conversa. Pouco **contato visual** pode ser um dos sinais de TEA.

O mais importante não é a quantidade de olhares, mas o seu **uso social**. Forçar a criança a olhar não é recomendado e pode causar desconforto.

O que observar

- Olha para compartilhar ou só para pedir?
- Alterna o olhar entre o objeto e você?
- Sorri quando olha para você?
- Olha quando você fala com ela?
- Busca o seu rosto em situações novas?

Por onde começar?

Ela olha para você quando quer algo ou quando algo a surpreende?

SIM **Base presente**
Amplie as interações com jogos de pessoa.

NÃO **Investigue mais**
Avalie atenção compartilhada e sinais de TEA (Fichas 30 e 35).

Como avaliar: passo a passo

1. **Observação livre**
   Brinque com a criança e observe quando e como ela olha.
2. **Qualidade do olhar**
   O olhar vem junto com gestos, sons ou sorriso?
3. **Situações de pedido**
   Ela olha para você ao pedir ajuda com um pote fechado?
4. **Sensorial**
   Observe incômodo com luz, sons ou toque, que pode afastar a interação.
5. **Rastreio**
   Entre 16 e 30 meses, aplique o M-CHAT-R/F (Ficha 35).
6. **Encaminhamento**
   Com outros sinais, encaminhe para avaliação médica e multiprofissional.

Estratégias de terapia

- **Na altura dos olhos:** sente-se no chão, de frente, e segure os brinquedos perto do seu rosto.
- **Jogos de pessoa:** cócegas, cavalinho e esconde-achou, com pausas para ela pedir mais.
- **Imite a criança:** imitar as ações dela aumenta o interesse por você.
- **Não force:** evite segurar o rosto ou exigir “olha para mim”.

Jogos que convidam o olhar

1. **Bolhas de sabão**
2. **Esconde-achou**
3. **Cócegas com pausa**
4. **Balão que esvazia**
5. **Música com pausas**

Sinais de atenção

- Quase não olha para as pessoas
- Não responde ao nome nem aponta
- Pouco sorriso social
- Perdeu habilidades sociais que tinha

Orientação à família

- Brinque no chão, na altura dos olhos dela.
- Faça pausas na brincadeira e espere ela pedir mais.
- Não force o olhar: torne o seu rosto interessante.

Base: literatura sobre comunicação no Transtorno do Espectro Autista

FICHA 32 | TEA • COMUNICAÇÃO

Fala, mas não conversa

Só fala do **assunto preferido**



O que é

A **pragmática** é o uso social da linguagem: iniciar e manter uma conversa, revezar a vez, adequar a fala a quem ouve e entender o que não é dito ao pé da letra.

A criança pode ter bom vocabulário e frases corretas e, mesmo assim, ter dificuldade de conversar. Isso é comum no TEA e no transtorno da comunicação social.

Habilidades pragmáticas

- Revezar a vez de falar
- Manter o assunto da conversa
- Adequar a fala a quem ouve
- Entender ironias, piadas e expressões
- Perceber se o outro está interessado

TEA ou comunicação social?

A dificuldade vem junto com interesses restritos e comportamentos repetitivos?

SIM — Investigue TEA
Encaminhe para avaliação diagnóstica (Ficha 35).

NÃO — Considere comunicação social
Pode ser transtorno da comunicação social (pragmática).

Como avaliar: passo a passo

1. **Conversa livre**
   Converse sobre vários assuntos e observe turnos e tópico.
2. **Protocolo**
   Use um roteiro de observação (ex.: ABFW, parte de Pragmática).
3. **Linguagem não literal**
   Ela entende "chover canivete" e "cair a ficha"?
4. **Perspectiva do outro**
   Ela percebe o que o outro sabe, pensa ou sente?
5. **Narrativa**
   Ela conta fatos considerando o que o ouvinte já sabe? (Ficha 22)
6. **Outros sinais**
   Observe interesses restritos, rigidez e questões sensoriais.

Estratégias de terapia

- **Histórias sociais:** textos curtos com figuras que explicam uma situação e como agir nela.
- **Jogos de turno:** um objeto passa de mão em mão, e só fala quem está com ele.
- **Pistas visuais:** cartões como "pergunte algo ao amigo" e "mude de assunto".
- **Grupos pequenos:** treine a conversa com outras crianças, com mediação.

Uma boa conversa

1. Cumprimentar
2. Escolher um assunto
3. Revezar a vez
4. Fazer perguntas
5. Encerrar

Sinais de atenção

- Só fala do assunto preferido
- Não percebe quando o outro perde o interesse
- Entende tudo ao pé da letra
- Dificuldade de fazer e manter amigos

Orientação à família

- Brinquem de jogos de vez: "agora você, agora eu".
- Explique expressões: "Chover canivete é chover muito".
- Antes de passeios, conte o que vai acontecer e como agir.

Base: literatura sobre comunicação no Transtorno do Espectro Autista

FICHA 33 TEA • COMUNICAÇÃO

Seletividade alimentar

Aceita **poucos alimentos** e recusa os novos



O que é

Na **seletividade alimentar**, a criança aceita um repertório pequeno de alimentos e recusa os novos por textura, cor, cheiro ou até pela marca. É frequente no TEA.

Envolve aspectos sensoriais, motores e comportamentais. O trabalho costuma ser em **equipe**: fono, nutricionista, terapeuta ocupacional e pediatra.

Possíveis causas

- **Sensorial: textura, cheiro, cor, temperatura**
- **Motora oral: dificuldade para mastigar**
- **Comportamental: rigidez e apego à rotina**
- **Médica: refluxo, constipação, alergias**

Por onde começar?

Ela mastiga bem os alimentos que aceita, como biscoito crocante?

SIM — Foco sensorial e comportamental
A mastigação existe. Trabalhe a aceitação aos poucos.

NÃO — Avalie a motricidade oral
Investigue mastigação e deglutição (Ficha 51).

Como avaliar: passo a passo

1. **Diário alimentar**
   Peça o registro de tudo o que a criança come durante 3 dias.
2. **Lista de aceitos**
   Anote cor, textura, temperatura e marca dos alimentos aceitos.
3. **Motricidade oral**
   Avalie mastigação, movimento de língua e deglutição.
4. **Reações**
   Observe ânsia, vômito ou choro ao ver, tocar ou cheirar alimentos.
5. **Crescimento**
   Confira peso e altura com pediatra ou nutricionista.
6. **Rotina das refeições**
   Pergunte sobre telas, horários, local e pressão para comer.

Estratégias de terapia

- **Exposição gradual:** a criança avança aos poucos (tolerar, tocar, cheirar, provar, comer).
- **Pontes alimentares:** parta de um alimento aceito para outro parecido em cor, sabor ou textura.
- **Sem pressão:** não force, não esconda alimentos e não troque comida por prêmio.
- **Brincar com comida:** fora das refeições, montar, pintar, cheirar e tocar alimentos.

Escada da exposição

1. **Tolerar na mesa**
2. **Tocar**
3. **Cheirar**
4. **Lamber**
5. **Morder**
6. **Mastigar e engolir**

Sinais de atenção

- **Aceita menos de 20 alimentos**
- **Perda de peso ou baixo ganho**
- **Ânsia ou vômito com alimentos novos**
- **Engasgos frequentes**

Orientação à família

- **Coloque um pouco do alimento novo no prato, sem exigir que coma.**
- **Comam juntos e mostrem que gostam do alimento.**
- **Evite telas durante as refeições.**

Base: literatura sobre alimentação e seletividade alimentar no TEA

FICHA 34 TEA • COMUNICAÇÃO

Comunicação alternativa (CAA)

Quando e como começar com a **criança não verbal**



O que é

A **Comunicação Aumentativa e Alternativa** (CAA) reúne recursos que complementam ou substituem a fala: gestos, sinais, figuras e aplicativos com voz.

A CAA **não impede a fala**: as pesquisas mostram que ela pode até favorecê-la. Não há pré-requisitos. Pode começar cedo, em qualquer idade.

Tipos de recurso

Sem tecnologia
Gestos, sinais e expressões.

Baixa tecnologia
Pranchas e cartões de figuras (ex.: PECS).

Alta tecnologia
Tablets e aplicativos com voz.

Quando indicar?

A fala atual dá conta de tudo o que ela precisa comunicar no dia a dia?

SIM — Siga com a fala
Continue a terapia de fala e linguagem.

NÃO — Introduza a CAA
Use a CAA junto com a terapia de fala, não no lugar dela.

Como avaliar: passo a passo

1. **Necessidades** — Liste o que ela precisa comunicar: pedir, recusar, chamar, comentar.
2. **Motivadores** — Descubra os itens, brincadeiras e pessoas preferidos.
3. **Visão e símbolos** — Ela reconhece fotos, desenhos ou só objetos reais?
4. **Acesso motor** — Ela aponta com o dedo, toca na tela ou entrega cartões?
5. **Ambientes** — Onde ela vai usar a CAA: casa, escola, terapia?
6. **Parceiros** — Quem vai apoiar o uso no dia a dia? Oriente essas pessoas.

Estratégias de terapia

- **Modelagem:** use a CAA ao falar com a criança, tocando as figuras enquanto fala.
- **Palavras úteis primeiro:** comece com palavras que servem em muitas situações.
- **Em todos os lugares:** o recurso deve estar sempre à mão, em casa, na escola e na terapia.
- **Responda sempre:** trate cada mensagem pela CAA como se fosse fala.

Vocabulário essencial

quero · mais · acabou · ajuda · não · sim · eu · você · ir · olha

Quando considerar

- Frustração por não ser entendida
- Fala insuficiente para o dia a dia
- Apraxia ou fala muito difícil de entender
- Crises ligadas à comunicação (Ficha 37)

Orientação à família

- Deixe a prancha ou o tablet sempre ao alcance.
- Use as figuras ao falar com ela, não só espere que ela use.
- Comemore toda mensagem: por figura, gesto ou fala.

Base: literatura de Comunicação Aumentativa e Alternativa

FICHA 35 | TEA • COMUNICAÇÃO

Rastreio com o M-CHAT-R/F

Triagem de sinais de TEA entre **16 e 30 meses**



O que é

O **M-CHAT-R/F** é um questionário de rastreio de TEA com 20 perguntas de sim ou não, respondidas pelos pais, para crianças de **16 a 30 meses**.

Rastreio **não é diagnóstico**: ele indica quem precisa de avaliação. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o rastreio entre 18 e 24 meses.

Pontuação

0–2
Baixo risco
Acompanhe. Abaixo de 24 meses, repita depois dos 2 anos.

3–7
Risco moderado
Faça a entrevista de seguimento.

8–20
Alto risco
Encaminhe direto para avaliação.

Depois da entrevista de seguimento

Na entrevista de seguimento, a pontuação ficou em 2 ou mais?

SIM **Rastreio positivo**
Encaminhe para avaliação diagnóstica e estimulação.

NÃO **Rastreio negativo**
Acompanhe o desenvolvimento nas próximas consultas.

Como avaliar: passo a passo

1. **Idade certa**
   Aplique apenas entre 16 e 30 meses.
2. **Aplicação**
   Os pais respondem às 20 perguntas pensando no comportamento habitual.
3. **Pontuação**
   Some as respostas de risco. Atenção: nos itens 2, 5 e 12, o "sim" é que pontua.
4. **Seguimento**
   De 3 a 7 pontos, aplique a entrevista de seguimento item por item.
5. **Devolutiva**
   Explique o resultado com calma e sem rótulos.
6. **Registro**
   Anote o resultado e a conduta no prontuário.

Como conversar com a família

- **Rastreio ≠ diagnóstico:** o resultado indica a necessidade de avaliação, não confirma TEA.
- **Fatos, não rótulos:** fale dos comportamentos observados, com exemplos.
- **Não esperar:** a estimulação pode começar antes do diagnóstico.
- **Caminho claro:** oriente onde buscar avaliação (pediatra, neuropediatra ou serviço de referência).

Fluxo resumido

1. **Aplicar 20 itens**
2. **Pontuar**
3. **0–2: acompanhar**
4. **3–7: entrevista**
5. **8+: encaminhar**

Cuidados na aplicação

- Não use antes de 16 nem após 30 meses
- Não substitui a avaliação clínica
- Pode não detectar casos mais leves
- Repita se surgir nova preocupação

Orientação à família

- Responda pensando em como a criança costuma agir.
- Um rastreio positivo não é um diagnóstico.
- Buscar avaliação cedo traz benefícios para a criança.

Base: M-CHAT-R/F (Robins, Fein e Barton) e Sociedade Brasileira de Pediatria

FICHA 36 TEA • COMUNICAÇÃO

Perdeu palavras que já falava

A família diz: **"Falava e parou"**



O que é

A **regressão** é a perda de habilidades que a criança já tinha: palavras, gestos, interesse social ou brincadeiras. É **sempre um sinal de alerta**.

Acontece em parte das crianças com TEA, geralmente entre 15 e 24 meses, mas também pode ter outras causas. Por isso precisa de avaliação médica.

Possíveis causas

- TEA (mais comum entre 15 e 24 meses)
- Perda auditiva
- Síndrome de Landau-Kleffner (epilepsia)
- Síndrome de Rett (em meninas)
- Outras condições neurológicas

Qual a urgência?

A perda veio junto com crises convulsivas, mudanças motoras ou perda do uso das mãos?

SIM — Encaminhe com urgência
Neuropediatra o quanto antes.

NÃO — Investigue sem esperar
Avalie TEA e audição e encaminhe ao médico.

Como avaliar: passo a passo

1. **Linha do tempo**
   O que a criança fazia, desde quando e quando parou.
2. **Vídeos antigos**
   Peça vídeos da criança falando e brincando antes da perda.
3. **Audição**
   Solicite avaliação audiológica.
4. **Habilidades sociais**
   Observe olhar, apontar, resposta ao nome e brincadeira.
5. **Motor e mãos**
   Pergunte sobre perda do uso das mãos, da marcha ou crises.
6. **Encaminhamento**
   Encaminhe para avaliação médica, com o registro em mãos.

Conduta

- **Não espere:** regressão nunca é para "esperar voltar sozinha".
- **Registre com datas:** anote o que mudou e quando; isso ajuda o médico.
- **Comece a estimulação:** inicie a terapia enquanto a avaliação médica acontece.
- **Acolha a família:** a perda costuma assustar muito, então explique os próximos passos.

Perguntas da linha do tempo

1. **Com que idade falava?**
2. **Quais palavras usava?**
3. **Quando parou?**
4. **O que mudou junto?**

Sinais de atenção

- Perdeu palavras ou frases
- Parou de responder ao nome
- Perdeu gestos (tchau, apontar)
- Crises convulsivas ou perda do uso das mãos

Orientação à família

- Separe vídeos antigos da criança falando ou brincando.
- Anote as datas e as mudanças que você notou.
- Não espere passar: procure avaliação logo.

Base: literatura sobre regressão do desenvolvimento na infância

FICHA 37 TEA • COMUNICAÇÃO

Crises por não conseguir se comunicar

Frustração e **choro intenso** quando não é entendida



O que é

Muitas crises acontecem porque a criança **não tem um jeito eficiente** de pedir, recusar ou dizer que algo incomoda. O comportamento passa a ser a forma de comunicar.

Por isso, ensinar comunicação é uma das formas mais eficazes de **reduzir as crises**.

Birra × crise

Birra

Tem um objetivo, costuma parar quando ele é atingido e a criança observa a reação do adulto.

Crise

É uma sobrecarga: não para com recompensa e a criança precisa de calma e segurança.

Por onde começar?

As crises acontecem quando ela não consegue pedir ou recusar algo?

SIM Ensine a comunicar

Ofereça um jeito de pedir e recusar: gestos ou CAA (Ficha 34).

NÃO Investigue outros gatilhos

Sensorial, rotina, sono, dor e mudanças no ambiente.

Como avaliar: passo a passo

1. **Registro ABC**
   Anote o que acontece antes, a crise em si e o que acontece depois.
2. **Função**
   A crise serve para pedir, recusar, fugir, ter atenção ou aliviar um incômodo?
3. **Comunicação atual**
   Como ela pede, recusa e pede ajuda hoje?
4. **Sensorial**
   Barulho, luz, multidão ou roupas podem estar sobrecarregando?
5. **Rotina**
   As crises aparecem nas mudanças de atividade ou de ambiente?
6. **Saúde**
   Investigue dor, sono ruim e constipação com o pediatra.

Estratégias de terapia

- **"Não" e "ajuda":** ensine uma forma clara de recusar e de pedir ajuda.
- **Rotina visual:** figuras com a sequência do dia e avisos antes das mudanças.
- **Escolhas:** ofereça duas opções, para a criança ter algum controle.
- **Depois da crise:** a conversa e o ensino ficam para quando ela estiver calma.

Durante a crise

1. **Garanta a segurança**
2. **Fale pouco e com calma**
3. **Reduza estímulos**
4. **Espere acalmar**
5. **Converse depois**

Sinais de atenção

- Crises que machucam a criança ou outros
- Aumento rápido da frequência
- Crises sem gatilho aparente
- Sinais de dor ou sono muito ruim

Orientação à família

- Use uma rotina com figuras para antecipar o dia.
- Avise antes de mudar de atividade: "Mais 2 minutos".
- Na crise, mantenha a calma e fale pouco.

Base: literatura sobre comportamento e comunicação no TEA

FICHA 38 FLUÊNCIA

Gagueira ou disfluência comum?

A criança repete palavras: **fase ou gagueira?**



O que é

Entre 2 e 5 anos, muitas crianças têm **disfluências comuns**: repetem palavras, hesitam e refazem frases enquanto a linguagem se desenvolve.

A **gagueira** tem disfluências de outro tipo: repetição de sílabas, prolongamentos e bloqueios, muitas vezes com tensão.

Os dois tipos

Comuns

Repete palavras inteiras ("eu, eu quero"), "é...", "hã...", refaz frases. Sem tensão.

Típicas da gagueira

Repete sílabas ("ca-ca-casa"), prolonga sons, bloqueia. Muitas vezes com tensão.

Fase ou gagueira?

Há repetições de sílabas, prolongamentos ou bloqueios com frequência?

SIM Possível gagueira
Faça a avaliação completa e oriente a família.

NÃO Disfluência comum
Oriente a família e acompanhe a evolução.

Como avaliar: passo a passo

1. **Amostra de fala**
   Grave uma conversa e transcreva 200 sílabas da fala da criança.
2. **Classifique**
   Separe as disfluências comuns das típicas da gagueira.
3. **Calcule**
   Disfluências típicas ÷ sílabas × 100. Acima de 3% sugere gagueira.
4. **Tensão**
   Observe esforço, tensão e movimentos associados (Ficha 42).
5. **Fatores de risco**
   Gagueira na família, tempo desde o início, sexo e idade de início.
6. **Impacto**
   Como a criança se sente? Ela evita falar ou mostra frustração?

Conduta

- **Orientação imediata:** com fatores de risco, não espere a gagueira "passar".
- **Modelo de fala:** o adulto fala de forma tranquila, com pausas, sem pressa.
- **Programas com evidência:** para pré-escolares, existem programas como o Lidcombe.
- **Reavalie:** acompanhe a cada poucos meses, com nova amostra de fala.

Risco de persistir

1. **Gagueira persistente na família**
2. **Mais de 12 meses desde o início**
3. **Início após 3 anos e meio**
4. **Ser menino**

Sinais de atenção

- Disfluências com tensão ou esforço
- Mais de 12 meses de duração
- Criança incomodada ou evitando falar
- Gagueira persistente na família

Orientação à família

- Ouça com calma e olhe para a criança enquanto ela fala.
- Não complete as palavras nem diga "fala devagar".
- Fale você mais devagar, com pausas.

Base: literatura de fluência e gagueira (incluindo ABFW – Fluência)

FICHA 39 FLUÊNCIA

Trava no início da palavra (bloqueio)

A boca se prepara, mas **a voz não sai**



O que é

O **bloqueio** é uma parada na fala: a criança posiciona a boca para o som, mas ele não sai por alguns instantes. É uma disfluência típica da gagueira.

Costuma vir com **tensão** e pode gerar esforço, medo de falar e evitação de palavras ou situações.

Como aparece

- Boca na posição, mas o som não sai
- Tensão nos lábios, na mandíbula ou no pescoço
- Pausa silenciosa no início ou no meio da palavra
- Esforço visível, às vezes com movimentos de cabeça

Por onde começar?

Ela percebe os bloqueios e mostra incômodo ou medo de falar?

SIM Inclua o lado emocional
Trabalhe sentimentos e atitudes junto com a fluência.

NÃO Foco na fluência
Orientação à família e técnicas de fala mais suave.

Como avaliar: passo a passo

1. **Amostra de fala**
   Grave a fala e conte os bloqueios em 200 sílabas.
2. **Duração**
   Cronometre os 3 bloqueios mais longos, como na escala SSI-4.
3. **Comportamentos associados**
   Observe piscar, movimentos de cabeça e tensão facial.
4. **Situações**
   Pergunte em que situações e com quais palavras piora.
5. **Sentimentos**
   Use questionários de atitude (ex.: KiddyCAT, para pré-escolares).
6. **Evitação**
   Ela troca palavras ou deixa de falar para não gaguejar?

Estratégias de terapia

- **Início suave:** começar a palavra com o ar já saindo e a voz entrando devagar.
- **Contato leve:** lábios e língua se tocam de leve, sem apertar.
- **Cancelamento:** depois de um bloqueio, fazer uma pausa e dizer a palavra de forma mais suave.
- **Sem tabu:** falar sobre a gagueira com naturalidade diminui o medo.

Técnicas de suavização

1. **Início suave da voz**
2. **Contato leve**
3. **Fala lenta e contínua**
4. **Pausas planejadas**

Sinais de atenção

- Bloqueios longos e frequentes
- Movimentos de esforço (cabeça, olhos)
- Evita palavras ou situações de fala
- Ansiedade ou medo de falar

Orientação à família

- Espere a palavra sair, sem completar.
- Mantenha o olhar tranquilo durante o bloqueio.
- Converse sobre a gagueira com naturalidade, se ela quiser.

Base: literatura de fluência e gagueira (incluindo ABFW – Fluência)

FICHA 40 FLUÊNCIA

Estica os sons (prolongamento)

A criança diz **“mmmmamãe”**



O que é

O **prolongamento** é quando um som se estende além do normal, geralmente no início da palavra: “mmmmamãe”, “ssssapo”. É uma disfluência típica da gagueira.

É diferente do alongamento usado para dar ênfase (“muuuito!”), que é **intencional e sem tensão**.

Prolongamento × ênfase

mmmamãe
Prolongamento
Involuntário, no início da palavra, muitas vezes com tensão.

muuuito!
Ênfase
Intencional, para expressar emoção. Sem tensão.

Fase ou gagueira?

Os prolongamentos são frequentes ou vêm com tensão e esforço?

SIM Sinal de gagueira
Faça a avaliação completa (Ficha 38).

NÃO Acompanhe
Oriente a família e reavalie em alguns meses.

Como avaliar: passo a passo

1. **Amostra de fala**
   Grave a fala e conte os prolongamentos em 200 sílabas.
2. **Outros tipos**
   Anote também repetições de sílabas e bloqueios.
3. **Duração**
   Observe quanto tempo o som fica esticado.
4. **Posição**
   Acontece no início da palavra ou da frase?
5. **Tensão**
   Há tensão nos lábios, na voz ou no rosto?
6. **Reação**
   A criança percebe e fica incomodada?

Estratégias de terapia

- **Fala deslizada:** passar de um som para o outro de forma suave e contínua.
- **Modelo do adulto:** falar mais devagar e com pausas, sem pedir que ela faça igual.
- **Programas com evidência:** no Lidcombe, os pais elogiam a fala fluente, com orientação da fono.
- **Menos pressão:** evite várias perguntas seguidas e interrupções.

Comunicação sem pressa

1. **Uma pergunta por vez**
2. **Pausa antes de responder**
3. **Esperar a vez dela**
4. **Conversa diária sem pressa**

Sinais de atenção

- Prolongamentos longos ou frequentes
- Tensão na voz ou no rosto
- Também repete sílabas ou bloqueia
- Criança evita falar

Orientação à família

- Fale de forma calma, com pausas.
- Reserve alguns minutos por dia de conversa sem pressa.
- Evite dizer “respira” ou “fala de novo”.

Base: literatura de fluência e gagueira (incluindo ABFW – Fluência)

FICHA 41 FLUÊNCIA

Repete sílabas

A criança diz **“ca-ca-casa”**



O que é

A **repetição de sílabas** (“ca-ca-casa”) é uma disfluência típica da gagueira. É diferente da repetição de palavras inteiras (“eu, eu quero”), comum em crianças pequenas.

Repetições com **mais de duas unidades**, ritmo rápido ou irregular e tensão indicam maior risco.

Palavra × sílaba

eu, eu quero
Repete a palavra
Comum entre 2 e 5 anos, sem tensão.

ca-ca-casa
Repete a sílaba
Típica da gagueira.

Atenção para “ca-ca-ca-casa” (mais de 2 repetições) e para ritmo rápido.

Qual o risco?

As repetições têm mais de 2 unidades ou vêm com tensão?

SIM — Maior risco
Faça a avaliação completa da gagueira (Ficha 38).

NÃO — Acompanhe
Oriente a família e reavalie em alguns meses.

Como avaliar: passo a passo

1. **Amostra de fala**
   Grave a fala e conte as repetições em 200 sílabas.
2. **Tipo**
   Separe repetições de sílaba das de palavra inteira.
3. **Unidades**
   Conte quantas vezes a sílaba se repete em cada ocorrência.
4. **Ritmo**
   As repetições são rápidas, irregulares ou com tensão?
5. **Frequência**
   Calcule a porcentagem de disfluências típicas da gagueira.
6. **Reações**
   A criança percebe, se frustra ou evita falar?

Estratégias de terapia

- **Modelo do adulto:** fale mais devagar e com suavidade, sem pedir que ela imite.
- **Elogio à fala fluente:** de forma leve e natural, com orientação da fono.
- **Frases fáceis:** jogos com frases curtas e previsíveis, que geram fala fluente.
- **Hora certa:** evite exigir fala quando a criança estiver cansada ou agitada.

Do mais fácil ao mais difícil

1. **Nomear figuras**
2. **Frases-modelo curtas**
3. **Frases mais longas**
4. **Conversa livre**

Sinais de atenção

- Mais de 2 repetições por vez
- Repetições com tensão
- Aumento das repetições com o tempo
- Criança frustrada ao falar

Orientação à família

- Não peça para repetir nem para começar de novo.
- Mostre que está ouvindo o que ela diz, não como diz.
- Evite interromper: espere a vez dela.

Base: literatura de fluência e gagueira (incluindo ABFW – Fluência)

FICHA 42 FLUÊNCIA

Pisca ou faz força ao falar

Movimentos que aparecem **junto com a gagueira**



O que é

Os **comportamentos associados** são movimentos e sons que surgem durante a gagueira, muitas vezes como tentativa de "empurrar" a palavra ou escapar do bloqueio.

Com o tempo, viram hábito e podem chamar mais atenção do que a própria gagueira. São mais comuns quando a gagueira já dura algum tempo.

Os mais comuns

- Piscar ou fechar os olhos
- Tensão no rosto e caretas
- Movimentos de cabeça
- Movimentos de braços ou pernas
- Sons de "partida" antes da palavra ("é...", "tipo...")

Gagueira ou tique?

Os movimentos aparecem só durante as disfluências?

SIM Comportamentos associados
Fazem parte da gagueira: inclua-os na terapia.

NÃO Investigue tiques
Movimentos fora da fala podem ser tiques: encaminhe ao médico.

Como avaliar: passo a passo

1. **Filme a fala**
   Grave um vídeo de conversa e de leitura, com autorização.
2. **Liste os comportamentos**
   Anote cada movimento ou som que aparece junto com a gagueira.
3. **Gravidade**
   Pontue de 0 a 5 por grupo, como na escala SSI-4.
4. **Momento**
   Eles aparecem antes, durante ou depois do bloqueio?
5. **Consciência**
   A pessoa percebe os movimentos quando assiste ao vídeo?
6. **Impacto**
   Há vergonha, evitação ou comentários dos colegas?

Estratégias de terapia

- **Identificação:** assistam ao vídeo juntos e nomeiem os comportamentos, sem julgamento.
- **Gagueira mais fácil:** trocar o esforço por uma repetição ou um prolongamento suave.
- **Soltar a tensão:** perceber onde o corpo aperta e relaxar esse ponto durante a fala.
- **Dessensibilização:** falar sobre a gagueira e treinar situações temidas reduz o medo.

Caminho da mudança

1. Identificar
2. Dessensibilizar
3. Modificar
4. Manter os ganhos

Sinais de atenção

- Esforço físico intenso ao falar
- Movimentos que chamam a atenção dos colegas
- Movimentos também fora da fala
- Vergonha ou isolamento

Orientação à família

- Não comente nem imite os movimentos.
- Mantenha o olhar tranquilo enquanto ela fala.
- Valorize o que ela diz, não a fluência.

Base: literatura de fluência e gagueira (incluindo SSI-4)

FICHA 43 FLUÊNCIA

Como orientar os pais da criança que gagueja

A família pergunta: **"Mando falar devagar?"**



O que é

A gagueira tem forte **componente genético e neurológico**. Os pais não causam a gagueira, mas o jeito de conversar em casa pode ajudar muito a criança.

Orientar a família é parte central da terapia, principalmente nos **primeiros anos**.

O que ajuda × o que atrapalha

Ajuda

Esperar com calma, falar mais devagar, olhar tranquilo e um tempo especial juntos.

Atrapalha

Completar palavras, dizer "respira" ou "fala devagar", interromper, pedir para repetir.

Por onde começar?

A família está ansiosa ou se sente culpada pela gagueira?

SIM **Acolha primeiro**
Explique que os pais não causam a gagueira.

NÃO **Orientações práticas**
Escolha com a família 1 ou 2 mudanças por vez.

Como conduzir a orientação

1. **Escute**
   Pergunte sobre dúvidas, medos e o que já tentaram.
2. **Explique**
   O que é a gagueira e por que ela não é culpa de ninguém.
3. **Observe**
   Filme os pais brincando com a criança e assistam juntos.
4. **Uma mudança por vez**
   Escolha 1 ou 2 ajustes de conversa para a semana.
5. **Tempo especial**
   Combine alguns minutos diários de brincadeira sem pressa.
6. **Retorno**
   Na sessão seguinte, revise o que funcionou e ajuste.

Orientações principais

- **Ritmo:** os adultos falam mais devagar e com pausas, sem pedir que a criança imite.
- **Turnos:** uma pessoa fala de cada vez, sem interrupções.
- **Menos perguntas:** mais comentários e menos perguntas seguidas.
- **Falar sobre a gagueira:** se a criança notar, acolha dizendo "Às vezes a palavra fica presa, tudo bem."

Tempo especial

1. **5 minutos por dia**
2. **Brincadeira escolhida pela criança**
3. **Adulto calmo e sem pressa**
4. **Sem telas e poucas perguntas**

Quando reforçar a orientação

- Família completa as palavras da criança
- Pede para respirar ou falar devagar
- Irmãos ou colegas zombam da gagueira
- Rotina com pressa constante

Orientação à família

- Você não causou a gagueira.
- Ouça o que a criança diz, não como diz.
- Converse com a escola sobre como agir.

Base: literatura de fluência e gagueira

FICHA 44 FLUÊNCIA

Fala rápida e embolada

Atropela as palavras: **taquifemia**



O que é

A **taquifemia** é um distúrbio de fluência em que a fala é rápida ou irregular demais, com sílabas "engolidas", pausas fora do lugar e muitas hesitações.

A pessoa costuma **perceber pouco** a própria dificuldade. Pode vir junto com gagueira, TDAH e dificuldades de leitura e escrita.

Taquifemia × gagueira

Taquifemia
Fala rápida e embolada, pouca consciência. Melhora quando presta atenção.

Gagueira
Bloqueios e repetições de sílabas, com tensão. Costuma perceber e se incomodar.

Taquifemia ou gagueira?

A fala melhora bastante quando ela presta atenção e fala devagar?

SIM Sugestivo de taquifemia
Trabalhe ritmo, pausas e automonitoramento.

NÃO Investigue gagueira
Avalie as disfluências típicas da gagueira (Ficha 38).

Como avaliar: passo a passo

1. **Várias tarefas**
   Grave conversa, leitura em voz alta e reconto de história.
2. **Velocidade**
   Calcule as sílabas por segundo e compare entre as tarefas.
3. **Sílabas engolidas**
   Anote palavras encurtadas, como "ventidor" por "ventilador".
4. **Disfluências**
   Conte hesitações, revisões e repetições de palavras.
5. **Consciência**
   Assistam à gravação juntos: ela percebe as dificuldades?
6. **Associados**
   Investigue atenção, leitura e escrita.

Estratégias de terapia

- **Automonitoramento:** ouvir as próprias gravações e identificar os trechos rápidos.
- **Ritmo marcado:** falar com uma batida por sílaba e, depois, voltar à fala natural.
- **Pausas:** inserir pausas entre as ideias, como vírgulas na fala.
- **Sinal combinado:** um gesto discreto para lembrar de diminuir a velocidade.

Ritmo em etapas

1. **Palavras sílaba a sílaba**
2. **Frases com pausas marcadas**
3. **Leitura com pausas**
4. **Conversa monitorada**

Sinais de atenção

- Fala muito difícil de entender quando acelera
- Não percebe a própria dificuldade
- Dificuldades de leitura e escrita
- Sinais de desatenção ou impulsividade

Orientação à família

- Combine um sinal discreto para lembrar de ir mais devagar.
- Elogie quando ela fizer pausas.
- Fale você mais devagar, como exemplo.

Base: literatura de fluência e gagueira

FICHA 45 FLUÊNCIA

Gagueira no adulto: evitação e ansiedade

Troca palavras para **não gaguejar**



O que é

No adulto, a gagueira visível costuma ser só a **ponta do iceberg**. Por baixo, há vergonha, medo e evitação: trocar palavras, falar menos, fugir do telefone.

A terapia trabalha a fala e também **a relação da pessoa com a gagueira**, com objetivos definidos junto com ela.

O iceberg da gagueira

O que se vê
Repetições, bloqueios, prolongamentos e tensão.

O que fica escondido
Vergonha, medo, troca de palavras e situações evitadas.

Por onde começar?

O medo e a evitação pesam mais do que a gagueira visível?

SIM — Foco em atitudes
Trabalhe evitação e medo, em parceria com psicologia se preciso.

NÃO — Foco na fala
Combine técnicas de fluência e de gagueira mais suave.

Como avaliar: passo a passo

1. **Entrevista** — História da gagueira, tratamentos anteriores e o que a pessoa deseja.
2. **Gravidade** — Aplique a SSI-4 em fala e leitura.
3. **Impacto** — Use o OASES para medir o impacto na vida diária.
4. **Situações evitadas** — Liste as situações temidas, da mais fácil à mais difícil.
5. **Ansiedade** — Se for intensa, encaminhe também para psicologia.
6. **Objetivos** — Defina metas concretas junto com a pessoa.

Estratégias de terapia

- **Gagueira mais suave:** gaguejar com menos esforço, sem fugir da palavra.
- **Técnicas de fluência:** início suave da voz, contato leve e fala contínua.
- **Enfrentar situações:** praticar as situações evitadas, da mais fácil à mais difícil.
- **Grupos de apoio:** conhecer outras pessoas que gaguejam ajuda na aceitação.

Exemplo de hierarquia

1. Falar com um amigo
2. Pedir informação
3. Ligar para uma loja
4. Falar em reunião
5. Apresentar em público

Sinais de atenção

- Evita telefonar ou se apresentar
- Troca palavras com frequência
- Ansiedade social intensa
- Prejuízo no trabalho ou nos estudos

Para quem convive

- Espere a pessoa terminar, sem completar.
- Mantenha o contato visual natural.
- Pergunte como ela prefere que você aja.

Base: literatura de fluência e gagueira no adulto (incluindo SSI-4 e OASES)

FICHA 46 MOTRICIDADE OROFACIAL

Respira pela boca

Boca aberta, **olheiras e ronco**



O que é

A **respiração oral** pode ter causa obstrutiva (adenoide ou amígdalas aumentadas, rinite, desvio de septo) ou ser um hábito que persiste depois que a causa foi tratada.

Afeta o crescimento do rosto, a mordida, o sono, a atenção na escola, a mastigação e a fala. O cuidado é em **equipe**.

Sinais típicos

- Boca aberta em repouso
- Olheiras e lábios ressecados
- Ronco e baba no travesseiro
- Cansaço e desatenção durante o dia
- Língua baixa e lábios flácidos

Causa ou hábito?

Depois da avaliação do otorrino, existe obstrução nasal?

TEM OBSTRUÇÃO — Trate a causa
O tratamento médico vem antes; a fono atua junto ou depois.

SEM OBSTRUÇÃO — Trabalhe o hábito
Vedamento labial, respiração nasal e posição da língua.

Como avaliar: passo a passo

1. **Repouso**
   Observe lábios, língua e postura da cabeça com a criança distraída.
2. **Espelho no nariz**
   Um espelho sob o nariz embaça dos dois lados quando o ar passa bem.
3. **Lábios fechados**
   Ela consegue manter um pouco de água na boca, de lábios fechados, por alguns minutos?
4. **Músculos**
   Avalie o tônus de lábios, língua e bochechas.
5. **Mordida**
   Observe palato alto, mordida cruzada ou aberta.
6. **Sono**
   Pergunte sobre ronco, pausas na respiração e sono agitado.

Estratégias de terapia

- **Higiene nasal:** lavagem com soro, conforme orientação médica.
- **Vedamento labial:** exercícios e lembretes para manter os lábios fechados.
- **Respiração nasal:** brincadeiras de inspirar pelo nariz, como “cheirar a flor”.
- **Posição da língua:** ponta da língua apoiada atrás dos dentes de cima (Ficha 09).

Equipe envolvida

1. **Otorrinolaringologista**
2. **Pediatra ou alergista**
3. **Ortodontista**
4. **Fonoaudiólogo**

Sinais de atenção

- Ronco ou pausas na respiração ao dormir
- Sonolência ou desatenção na escola
- Mordida cruzada ou aberta
- Infecções de garganta e ouvido frequentes

Orientação à família

- Se houver ronco, filme a criança dormindo para mostrar ao médico.
- Faça a lavagem nasal como o médico orientou.
- Lembre com gentileza de fechar a boca durante o dia.

Base: literatura de motricidade orofacial

FICHA 47 MOTRICIDADE OROFACIAL

Língua presa

Frênulo curto que **limita os movimentos** da língua



O que é

Na **língua presa** (anquiloglossia), o frênulo que fica embaixo da língua é curto ou preso perto da ponta e limita os movimentos.

No Brasil, o **Teste da Linguinha** é obrigatório nas maternidades (Lei 13.002/2014). Nem todo frênulo alterado precisa de cirurgia: decide a avaliação da função.

Sinais

- Ponta da língua em formato de coração
- Não eleva a língua com a boca aberta
- Não alcança o lábio de cima
- Bebê com dificuldade de pega ao mamar
- Dificuldade com R fraco, L e sons de ponta

Precisa de cirurgia?

A alteração prejudica alguma função (amamentação, fala, mastigação)?

SIM Encaminhe para avaliação cirúrgica
Frenotomia ou frenectomia, com fono antes e depois.

NÃO Acompanhe
Trabalhe mobilidade se for preciso e reavalie.

Como avaliar: passo a passo

1. **Bebês**
   Aplique o Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês (Martinelli).
2. **Crianças maiores**
   Use o protocolo com escores para crianças.
3. **Mobilidade**
   Peça para elevar, protrair, lateralizar e estalar a língua.
4. **Amamentação**
   Observe pega, sucção, dor da mãe e ganho de peso.
5. **Fala**
   Avalie os sons de ponta de língua: R fraco, L, T, D, N.
6. **Mastigação**
   Observe como a língua leva o alimento para os dentes.

Estratégias de terapia

- **Antes do procedimento:** avaliação funcional completa e orientação à família.
- **Depois do procedimento:** exercícios de mobilidade, exatamente como orientado pela equipe.
- **Fala:** treino dos sons de ponta de língua (Fichas 01 e 13).
- **Equipe:** fono, odontopediatra ou cirurgião e pediatra decidem juntos.

Exercícios de mobilidade

1. **Língua no céu da boca**
2. **Estalos de língua**
3. **Ponta no lábio de cima**
4. **Varrer o céu da boca**

Sinais de atenção

- Bebê com dor ou dificuldade para mamar
- Pouco ganho de peso
- Sons de ponta de língua alterados
- Língua em formato de coração

Orientação à família

- Confira se o Teste da Linguinha foi feito na maternidade.
- Faça os exercícios somente como a fono orientou.
- Nem todo frênulo precisa de cirurgia: a avaliação decide.

Base: literatura de motricidade orofacial (incluindo Protocolo de Martinelli e Lei 13.002/2014)

FICHA 48 MOTRICIDADE OROFACIAL

Língua empurra os dentes ao engolir

Deglutição com **a língua entre os dentes**



O que é

Na **deglutição atípica**, a língua avança e empurra os dentes da frente ou se coloca entre eles ao engolir, em vez de se apoiar no céu da boca.

Está ligada a hábitos (chupeta, dedo), respiração oral e alterações da mordida. Pode atrapalhar o tratamento ortodôntico e favorecer **recidivas**.

Atípica × adaptada

Atípica
O movimento está alterado, sem causa estrutural. A terapia pode corrigir.

Adaptada
A língua se adapta a uma mordida alterada. É preciso tratar a causa.

Atípica ou adaptada?

Há mordida aberta ou outra alteração que explique a posição da língua?

SIM **Deglutição adaptada**
Trabalhe junto com o ortodontista.

NÃO **Deglutição atípica**
Terapia miofuncional para reorganizar o movimento.

Como avaliar: passo a passo

1. **Com água**
   Peça goles de água e afaste levemente o lábio para ver a língua.
2. **Com sólido**
   Observe a deglutição de um alimento como pão ou biscoito.
3. **Esforço facial**
   Há contração do queixo ou dos lábios ao engolir?
4. **Resíduos e ruídos**
   Sobra alimento na boca? Há ruído ao engolir?
5. **Mordida**
   Avalie mordida aberta, cruzada e posição dos dentes.
6. **Hábitos e respiração**
   Investigue chupeta, dedo e respiração oral.

Estratégias de terapia

- **Ponto da língua:** posição de repouso com a ponta atrás dos dentes de cima.
- **Treino da deglutição:** engolir com a língua no céu da boca e os dentes encostados.
- **Mobilidade e força:** exercícios de língua conforme a avaliação.
- **Causas associadas:** retirada de hábitos e respiração nasal (Fichas 46, 49 e 50).

Treino da deglutição

1. **Língua no ponto**
2. **Dentes encostados**
3. **Lábios fechados sem força**
4. **Engolir água**
5. **Engolir alimentos**

Sinais de atenção

- Mordida aberta que não melhora
- Língua entre os dentes no S (Ficha 09)
- Respiração pela boca
- Volta da alteração após o aparelho

Orientação à família

- Lembre a criança do “ponto da língua” com gentileza.
- Ajude na retirada da chupeta e da mamadeira.
- Mantenha o ortodontista e a fono trabalhando juntos.

Base: literatura de motricidade orofacial

FICHA 49 MOTRICIDADE OROFACIAL

Chupeta e mamadeira prolongadas

Uso que continua **depois da idade recomendada**



O que é

O uso prolongado de **chupeta e mamadeira** pode alterar a mordida, o formato do céu da boca, a posição da língua, a deglutição e a fala.

Quanto mais tempo e mais horas por dia, maior o risco. A retirada deve ser **planejada com a família**, sem castigos.

Idades de referência

~1 ano
Mamadeira → copo
Comece a oferecer líquidos no copo.

até 3 anos
Chupeta
Retirada recomendada, de preferência antes.

Por onde começar?

A criança usa a chupeta só para dormir ou ao longo do dia?

SÓ PARA DORMIR **Planeje a despedida**
Combine um ritual para a retirada final.

O DIA TODO **Reduza durante o dia**
Comece tirando nos momentos de brincadeira.

Como avaliar: passo a passo

1. **História do uso**
   Desde quando usa, por quantas horas e em quais momentos.
2. **Mordida**
   Observe mordida aberta, cruzada e formato do céu da boca.
3. **Respiração**
   Investigue respiração oral e ronco (Ficha 46).
4. **Língua e deglutição**
   Avalie a posição da língua e a forma de engolir (Ficha 48).
5. **Fala**
   Observe ceceio e outras distorções (Ficha 09).
6. **Função emocional**
   A chupeta é usada para acalmar? Em quais situações?

Estratégias de retirada

- **Aos poucos:** combine com a criança e reduza o uso por etapas.
- **Ritual de despedida:** entregar a chupeta para alguém especial, com uma história.
- **Outros confortos:** ursinho, música e colo na hora de dormir.
- **Copo de transição:** copo aberto ou com canudo no lugar da mamadeira.

Plano de retirada

1. **Combinar com a criança**
2. **Tirar durante o dia**
3. **Tirar para dormir**
4. **Despedida**
5. **Comemorar a conquista**

Sinais de atenção

- Mordida aberta ou cruzada
- Respiração pela boca
- Otites frequentes
- Mamadeira noturna com leite ou suco (risco de cárie)

Orientação à família

- Nunca molhe a chupeta em açúcar ou mel.
- A partir de 1 ano, ofereça líquidos no copo.
- Evite retirar em fases de mudança, como irmão novo ou escola nova.

Base: literatura de motricidade orofacial

FICHA 50 MOTRICIDADE OROFACIAL

Chupa o dedo

Sucção digital, principalmente **para dormir ou se acalmar**



O que é

A **sucção digital** é comum nos primeiros anos e costuma diminuir sozinha entre 2 e 4 anos. Quando persiste, pode alterar a mordida e a fala.

É um hábito mais difícil de retirar do que a chupeta, porque o dedo está **sempre disponível**. A abordagem é gradual e sem punição.

Possíveis efeitos

- Mordida aberta na frente
- Dentes da frente projetados para fora
- Céu da boca alto e estreito
- Língua baixa e ceceio (Ficha 09)

Por onde começar?

A criança demonstra vontade de parar?

SIM **Combine o plano com ela**
Lembretes, calendário e elogios às conquistas.

NÃO **Trabalhe a motivação**
Converse, ofereça outros confortos e evite punições.

Como avaliar: passo a passo

1. **Quando acontece**
   Na hora de dormir, vendo TV, com tédio ou ansiedade?
2. **Intensidade**
   Observe se há calo ou ferida no dedo.
3. **Mordida**
   Avalie mordida aberta e posição dos dentes.
4. **Língua e respiração**
   Investigue posição da língua e respiração oral.
5. **Fala**
   Observe distorções no S e em outros sons.
6. **Emoções**
   Pergunte sobre mudanças recentes e situações de estresse.

Estratégias de retirada

- **Consciência:** ajudar a criança a perceber quando o dedo vai à boca.
- **Lembretes gentis:** um curativo colorido ou luva à noite, como lembrete, nunca como castigo.
- **Calendário de conquistas:** marcar os dias sem o dedo, com elogios.
- **Mãos ocupadas:** massinha, bolinha ou brinquedos de apertar nos momentos críticos.

Plano em etapas

1. **Perceber os momentos**
2. **Combinar um lembrete**
3. **Ocupar as mãos**
4. **Comemorar os dias sem dedo**
5. **Avaliar com o dentista**

Sinais de atenção

- Hábito depois dos 4 anos
- Mordida aberta ou dentes para fora
- Calo ou ferida no dedo
- Ansiedade intensa associada

Orientação à família

- Não brigue nem faça piada: isso aumenta a ansiedade.
- Elogie os momentos sem o dedo.
- Ofereça outras formas de conforto na hora de dormir.

Base: literatura de motricidade orofacial

FICHA 51 MOTRICIDADE OROFACIAL

Mastiga de um lado só

Mastigação **unilateral**



O que é

Na **mastigação unilateral**, a pessoa mastiga sempre ou quase sempre do mesmo lado. O padrão esperado é alternar os dois lados durante a refeição.

Pode ser causada por dor, cárie, falta de dente, mordida cruzada ou hábito, e com o tempo gerar **assimetrias** e problemas na articulação da mandíbula.

Esperado × alterado

Bilateral alternada
O alimento passa pelos dois lados durante a refeição.

Unilateral
Sempre do mesmo lado. Pode causar assimetria no rosto.

Por onde começar?

Há dor, cárie, falta de dente ou mordida cruzada?

SIM Trate a causa
Encaminhe ao dentista antes da terapia.

NÃO Trabalhe o padrão
Treine a mastigação alternada dos dois lados.

Como avaliar: passo a passo

1. **Com alimento sólido**
   Ofereça pão ou biscoito e conte os golpes de cada lado.
2. **Lábios**
   Ela mastiga de boca fechada ou aberta?
3. **Tempo e ruído**
   Observe o tempo de mastigação e se há ruídos.
4. **Dentes e mordida**
   Verifique cáries, falhas e mordida cruzada.
5. **Mandíbula**
   Pergunte sobre dor e estalos ao mastigar (Ficha 53).
6. **Simetria**
   Observe diferenças entre os dois lados do rosto.

Estratégias de terapia

- **Consciência:** usar o espelho e contar os golpes de cada lado.
- **Lado menos usado:** começar a mastigar alimentos macios desse lado.
- **Mobilidade e força:** exercícios para o lado menos usado, conforme a avaliação.
- **Ritmo:** mastigar devagar, de boca fechada, alternando os lados.

Treino em etapas

1. **Alimento macio do lado menos usado**
2. **Alimento mais firme**
3. **Alternar os lados**
4. **Refeição completa**

Sinais de atenção

- Dor ao mastigar
- Estalos na mandíbula
- Assimetria no rosto
- Engole sem mastigar bem

Orientação à família

- Ofereça alimentos firmes, como frutas e legumes crus.
- Comam juntos, devagar e de boca fechada.
- Leve a criança ao dentista regularmente.

Base: literatura de motricidade orofacial

FICHA 52 | MOTRICIDADE OROFACIAL

Baba além da idade esperada

Escape de saliva **depois dos 4 anos**



O que é

Babar é comum até cerca de 18 a 24 meses, principalmente na fase dos dentes. O controle da saliva costuma estar estabelecido até os **4 anos**.

Depois disso, o escape de saliva (**sialorreia**) merece avaliação. Ele irrita a pele, molha roupas e materiais e pode gerar constrangimento.

Possíveis causas

- Respiração pela boca
- Lábios e língua com pouco tônus
- Pouca percepção da saliva na boca
- Deglutição pouco frequente
- Alterações neurológicas (ex.: paralisia cerebral)

Por onde começar?

Há alguma alteração neurológica associada?

SIM — Trabalhe em equipe
Neurologista, fisioterapeuta e TO. O médico avalia opções de tratamento.

NÃO — Foco miofuncional
Vedamento labial, percepção oral e deglutição.

Como avaliar: passo a passo

1. **Gravidade** — Classifique o quanto a saliva escapa (veja a escala ao lado).
2. **Frequência** — Acontece o tempo todo, às vezes ou só em atividades de concentração?
3. **Postura** — Observe o alinhamento de cabeça e tronco.
4. **Lábios** — Avalie se os lábios ficam fechados em repouso.
5. **Deglutição** — Conte quantas vezes ela engole a saliva em alguns minutos.
6. **Sensibilidade** — Ela percebe quando a boca ou o queixo estão molhados?

Estratégias de terapia

- **Percepção:** ajudar a criança a notar a boca molhada e engolir ou limpar.
- **Vedamento labial:** exercícios e lembretes para manter os lábios fechados.
- **Engolir com frequência:** lembretes visuais ou sonoros combinados com a criança.
- **Postura:** cabeça e tronco alinhados durante as atividades.

Gravidade da baba

1	Seco
2	Lábios molhados
3	Lábios e queixo
4	Roupa molhada
5	Roupa, mãos e objetos

Sinais de atenção

- Baba depois dos 4 anos
- Pele irritada ao redor da boca
- Engasgos com a própria saliva
- Constrangimento na escola

Orientação à família

- Use um lembrete combinado: “boca fechada, engole”.
- Ofereça um lenço para a criança se limpar sozinha.
- Elogie quando ela percebe e engole.

Base: literatura de motricidade orofacial

FICHA 53 MOTRICIDADE OROFACIAL

Dor e estalo na mandíbula

Disfunção temporomandibular (DTM)



O que é

A **DTM** envolve a articulação da mandíbula (ATM) e os músculos da mastigação. Causa dor, estalos e dificuldade para abrir a boca e mastigar.

Tem várias causas: apertar ou ranger os dentes, estresse, mastigação de um lado só e alterações da mordida. O tratamento é em **equipe**: dentista, fono, fisioterapeuta e psicólogo.

Sinais comuns

- Dor na frente do ouvido ou no rosto
- Estalos ao abrir ou fechar a boca
- Dificuldade para abrir muito a boca
- Cansaço ou dor ao mastigar
- Mandíbula desvia ao abrir

Por onde começar?

Há dor intensa, travamento da boca ou limitação importante para abrir?

SIM — Dentista especialista
Encaminhe para avaliação de DTM antes da terapia.

NÃO — Atuação da fono
Hábitos, mastigação e relaxamento, junto com o dentista.

Como avaliar: passo a passo

1. **Dor**
   Localização e intensidade de 0 a 10.
2. **Abertura da boca**
   Meça com régua. Em adultos, o esperado é 40 mm ou mais.
3. **Movimentos**
   Observe desvios ao abrir e os movimentos para os lados.
4. **Ruídos**
   Estalos ou rangidos na articulação?
5. **Hábitos**
   Apertar os dentes, ranger, roer unhas, mascar chiclete.
6. **Protocolo**
   Use um protocolo específico (ex.: ProDTMmulti).

Estratégias de terapia

- **Orientação:** nas crises, alimentos mais macios; evite chiclete e abrir muito a boca.
- **Mastigação bilateral:** alternar os dois lados ao mastigar (Ficha 51).
- **Relaxamento:** compressas mornas e automassagem, conforme orientação.
- **Soltar os dentes:** perceber o apertamento e voltar à posição de repouso.

Posição de repouso

1. Lábios fechados
2. Dentes separados
3. Língua no céu da boca
4. Rosto relaxado

Sinais de atenção

- Boca trava aberta ou fechada
- Dor intensa ou contínua
- Dificuldade importante para comer
- Dor de cabeça frequente

No dia a dia

- Evite chiclete e alimentos muito duros nas crises.
- Observe se você aperta os dentes ao se concentrar.
- Cuide do sono e do estresse.

Base: literatura de motricidade orofacial e DTM

FICHA 54 MOTRICIDADE OROFACIAL

Lábios entreabertos e flácidos

Lábio de baixo **virado para fora**



O que é

Lábios que ficam abertos em repouso, com o lábio de baixo virado para fora, costumam ter **tônus diminuído**.

Na maioria das vezes estão ligados à **respiração oral** (Ficha 46) e também afetam a deglutição, a mordida e os sons feitos com os lábios.

Esperado × alterado

Lábios vedados
Juntos em repouso, sem esforço.

Lábios entreabertos
Abertos, com o lábio de baixo virado para fora.

Por onde começar?

Ela consegue fechar os lábios com facilidade quando é pedido?

SIM — Trabalhe o hábito
Lembretes e consciência de manter os lábios fechados.

NÃO — Investigue a causa
Avalie respiração e tônus; pode haver obstrução (Ficha 46).

Como avaliar: passo a passo

1. **Repouso**
   Observe os lábios com a criança distraída, vendo um desenho.
2. **Respiração**
   Ela respira pelo nariz com os lábios fechados?
3. **Tônus e força**
   Avalie a firmeza dos lábios e a força para mantê-los fechados.
4. **Mordida**
   Observe dentes da frente projetados ou mordida aberta.
5. **Deglutição**
   Os lábios fazem força ao engolir? (Ficha 48)
6. **Fala**
   Avalie os sons feitos com os lábios: P, B e M.

Estratégias de terapia

- **Exercícios de lábios:** escolhidos conforme a avaliação, de forma lúdica.
- **Lembretes:** um adesivo ou sinal combinado para fechar a boca.
- **Funções:** soprar e sugar com canudos de espessuras diferentes.
- **Respiração:** tratar a causa da respiração oral, quando houver.

Atividades lúdicas

1. **Bico e sorriso**
2. **Mandar beijos estalados**
3. **Sugar com canudo**
4. **Encher as bochechas de ar**
5. **Soprar bolhas e apitos**

Sinais de atenção

- Respiração pela boca
- Baba (Ficha 52)
- Mordida aberta ou dentes para fora
- Dificuldade nos sons P, B e M

Orientação à família

- Lembre com gentileza de fechar a boca.
- Brinquem de soprar bolhas e apitos.
- Use canudos em sucos e vitaminas.

Base: literatura de motricidade orofacial

FICHA 55 MOTRICIDADE OROFACIAL

Paralisia facial periférica

Um lado do rosto **não se mexe**



O que é

Na **paralisia facial periférica**, o nervo facial é afetado e um lado inteiro do rosto perde movimento, inclusive a testa. A forma mais comum é a paralisia de Bell.

O início é rápido e o tratamento médico deve começar **o quanto antes**. A maioria das pessoas melhora; a fono ajuda na recuperação dos movimentos.

Periférica × central

Periférica
Todo um lado do rosto, inclusive a testa.

Central (ex.: AVC)
Só a parte de baixo do rosto; a testa se mexe. É emergência.

É emergência?

Há outros sinais de AVC, como fraqueza no braço ou fala enrolada?

SIM — Emergência
Procure atendimento médico imediato.

NÃO — Médico e fono
Avaliação médica rápida e reabilitação com a fono.

Como avaliar: passo a passo

1. **Grau**
   Classifique pela escala de House-Brackmann (I a VI).
2. **Fotos**
   Registre o rosto em repouso e nos movimentos, para comparar depois.
3. **Olho**
   O olho fecha totalmente? Se não, o médico orienta a proteção.
4. **Alimentação**
   Há escape de líquidos ou comida presa na bochecha?
5. **Fala**
   Avalie os sons P, B, M e F.
6. **Sincinesias**
   Observe movimentos involuntários, como o olho fechar ao sorrir.

Estratégias de terapia

- **Movimentos suaves:** exercícios lentos e simétricos, diante do espelho.
- **Sem força exagerada:** esforço excessivo pode favorecer movimentos involuntários.
- **Massagem:** massagem facial suave, conforme orientação.
- **Alimentação:** porções pequenas, mastigando do lado não afetado.

Exercícios no espelho

1. **Levantar as sobrancelhas**
2. **Fechar os olhos devagar**
3. **Sorrir sem mostrar os dentes**
4. **Fazer bico**
5. **Encher as bochechas**

Sinais de atenção

- Olho que não fecha (risco para a córnea)
- Sinais de AVC: procure a emergência
- Nenhuma melhora após algumas semanas
- Movimentos involuntários no rosto

No dia a dia

- Proteja o olho como o médico orientou.
- Faça os exercícios com calma e sem força.
- Coma devagar, em porções pequenas.

Base: literatura de motricidade orofacial (incluindo escala de House-Brackmann)

FICHA 56 MOTRICIDADE OROFACIAL

Dificuldade na pega do peito

Dor na mãe e **bebê que não ganha peso**



O que é

Uma **pega adequada** permite que o bebê retire leite com eficiência e sem machucar a mãe. Amamentar não deve doer.

Dor, fissuras e baixo ganho de peso podem ter relação com posição, pega, frênulo da língua ou dificuldades de sucção. O apoio deve ser **precoce**.

Sinais de boa pega

- Boca bem aberta
- Lábios virados para fora
- Queixo encostado na mama
- Mais aréola visível acima da boca do que abaixo
- Bochechas cheias, não encovadas

Por onde começar?

A mãe sente dor durante a mamada?

SIM **Corrija posição e pega**
E avalie o frênulo da língua (Ficha 47).

NÃO **Avalie a eficiência**
Observe ganho de peso, sucção e duração das mamadas.

Como avaliar: passo a passo

1. **Mamada completa**
   Observe do início ao fim, sem interferir.
2. **Posição**
   Corpo do bebê de frente para a mãe, cabeça e corpo alinhados.
3. **Pega**
   Confira os sinais de boa pega do quadro acima.
4. **Sucção**
   Ritmo de sucção, deglutição e respiração; sons de engolir.
5. **Frênulo**
   Confira se o Teste da Linguinha foi feito (Ficha 47).
6. **Ganho de peso**
   Peso, número de fraldas molhadas e satisfação após as mamadas.

Estratégias de terapia

- **Posição:** bebê de frente, barriga com barriga, nariz na altura do mamilo.
- **Pega:** esperar a boca abrir bem e trazer o bebê até a mama.
- **Variar posições:** deitada, cavalinho ou invertida, conforme o caso.
- **Equipe:** pediatra e consultora de amamentação, quando necessário.

Checklist da pega

1. Boca bem aberta
2. Lábios para fora
3. Queixo na mama
4. Mais aréola acima
5. Bochechas cheias

Sinais de atenção

- Dor forte ou fissuras no mamilo
- Bebê não ganha peso
- Poucas fraldas molhadas por dia
- Mamadas muito longas e bebê sempre com fome

Orientação à família

- Procure ajuda cedo: dor ao amamentar não é normal.
- Ofereça o peito sempre que o bebê pedir.
- Peça apoio da família nas tarefas da casa.

Base: OMS, UNICEF e literatura de fonoaudiologia neonatal

FICHA 57 MOTRICIDADE OROFACIAL

Dificuldade na introdução alimentar

Recusa de sólidos e **ânsia com pedaços**



O que é

A **introdução alimentar** começa aos 6 meses, com aleitamento exclusivo até essa idade. As texturas devem progredir até a comida da família.

Ânsia com texturas novas é comum no começo. Recusa persistente, engasgos e atraso na evolução das texturas merecem **avaliação**.

Progressão das texturas

6 meses
Amassado
Amassado com garfo, nunca liquidificado.

~8 meses
Pedacinhos
Pedaços pequenos e macios.

~12 meses
Família
Comida da família, cortada.

Por onde começar?

A criança tem ânsia ou recusa com qualquer textura nova?

SIM **Avalie a motricidade oral**
Investigue sensibilidade e mastigação (Fichas 33 e 51).

NÃO **Siga a progressão**
Avance as texturas com paciência e repetição.

Como avaliar: passo a passo

1. **Desenvolvimento**
   Ela senta com apoio e controla bem a cabeça?
2. **Textura atual**
   O que ela come hoje: líquido, pastoso, amassado ou pedaços?
3. **Mastigação**
   A língua leva o alimento para os lados? Há movimento de mastigar?
4. **Ânsia × engasgo**
   A ânsia é esperada no início; o engasgo com tosse e esforço não.
5. **Rotina**
   Telas, distrações e pressão para comer durante as refeições?
6. **Crescimento**
   Peso e altura acompanhados pelo pediatra.

Estratégias e orientação

- **Textura certa:** alimentos amassados com garfo, nunca liquidificados ou peneirados.
- **Progressão:** avance a textura a cada fase, sem ficar parado no pastoso.
- **Refeição em família:** a criança à mesa com os adultos, sem telas.
- **Paciência:** um alimento novo pode precisar de muitas ofertas até ser aceito.

Segurança

1. **Sentada e ereta**
2. **Sempre com um adulto olhando**
3. **Nada de uva, pipoca ou amendoim inteiros**
4. **Cortes em tiras ou pedaços pequenos**

Sinais de atenção

- Engasgos frequentes, com tosse e esforço
- Só aceita comida liquidificada após 1 ano
- Vômitos frequentes
- Perda de peso ou baixo ganho

Orientação à família

- Ofereça o mesmo alimento várias vezes, sem pressão.
- Deixe a criança tocar e explorar a comida.
- Não ofereça mel antes de 1 ano.

Base: OMS, Sociedade Brasileira de Pediatria e literatura de motricidade orofacial

FICHA 58 VOZ

Criança rouca

Grita muito e a **voz fica "quebrada"**



O que é

A **rouquidão infantil** é frequente em idade escolar e costuma estar ligada ao uso intenso da voz: gritar, imitar vozes e falar alto em ambientes barulhentos.

A causa mais comum são os nódulos vocais, mas só o **exame da laringe**, feito pelo otorrino, confirma o diagnóstico.

Causas comuns

- Nódulos vocais (uso intenso da voz)
- Cistos nas pregas vocais
- Alergias e infecções de repetição
- Refluxo

Por onde começar?

A rouquidão dura mais de 2 semanas?

SIM **Encaminhe ao otorrino**
O exame da laringe vem antes da terapia de voz.

NÃO **Oriente e acompanhe**
Higiene vocal e reavaliação se não melhorar.

Como avaliar: passo a passo

1. **História**
   Desde quando está rouca e em quais situações piora.
2. **Hábitos vocais**
   Gritos, imitação de vozes, torcida, canto sem orientação.
3. **Escala GRBAS**
   Avalie grau, rugosidade, soprosidade, astenia e tensão.
4. **Relação s/z**
   Compare o tempo de "sss" e "zzz". Valores acima de 1,2 sugerem alteração.
5. **Ambiente**
   Barulho em casa e na escola, irmãos, salas cheias.
6. **Exame da laringe**
   Solicite avaliação do otorrino.

Estratégias de terapia

- **Higiene vocal:** hábitos saudáveis de voz, explicados de forma lúdica.
- **Voz de dentro × de fora:** jogos para ajustar a intensidade da voz a cada lugar.
- **Exercícios lúdicos:** vibração de lábios e sons com canudo, conforme o caso.
- **Família e escola:** todos envolvidos para reduzir os gritos e o barulho.

Higiene vocal infantil

1. **Beber água ao longo do dia**
2. **Chamar indo até a pessoa**
3. **Evitar imitar vozes fortes**
4. **Descansar a voz após jogos e festas**

Sinais de atenção

- Rouquidão por mais de 2 semanas
- Voz que some ou falha
- Dor ou esforço para falar
- Barulho ou falta de ar ao respirar

Orientação à família

- Chame a criança indo até ela, sem gritar.
- Ofereça água ao longo do dia.
- Diminua o barulho em casa, como a TV alta.

Base: literatura de voz (incluindo escala GRBAS)

FICHA 59 VOZ

Professor rouco

A voz **piora ao longo da semana**



O que é

Professores estão entre os profissionais com **maior risco de alterações de voz**: falam muitas horas por dia, em salas barulhentas e muitas vezes sem pausas.

Quando a alteração está ligada ao trabalho, é reconhecida como **Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho (DRT)**.

Fatores de risco

- Muitas horas de fala por dia
- Ruído e salas grandes ou cheias
- Pouca água e poucas pausas
- Poeira de giz e ar seco
- Estresse e sono ruim

Por onde começar?

Há rouquidão por mais de 2 semanas ou falhas na voz?

SIM Otorrino
Exame da laringe antes de iniciar a terapia.

NÃO Prevenção
Higiene vocal, aquecimento e ajustes na sala de aula.

Como avaliar: passo a passo

1. **História profissional**
   Horas de aula, número de alunos, tipo de sala e ruído.
2. **Sintomas**
   Cansaço, dor, pigarro, falhas e perda de voz.
3. **Escala GRBAS**
   Avalie a qualidade da voz.
4. **Medidas**
   Tempo máximo de fonação e relação s/z.
5. **Autoavaliação**
   Use um questionário (ex.: Índice de Desvantagem Vocal).
6. **Exame da laringe**
   Encaminhe ao otorrino.

Estratégias de terapia

- **Aquecimento:** exercícios antes das aulas (Ficha 67).
- **Sala de aula:** amplificador de voz, sinais combinados para pedir silêncio e aproximação dos alunos.
- **Hidratação e pausas:** água entre as aulas e silêncio no intervalo.
- **Exercícios vocais:** canudo e vibração de lábios, conforme a avaliação.

Na sala de aula

1. **Usar amplificador**
2. **Combinar sinais de silêncio**
3. **Não competir com o barulho**
4. **Beber água entre as aulas**
5. **Descansar a voz no intervalo**

Sinais de atenção

- Rouquidão por mais de 2 semanas
- Perda da voz
- Dor ao falar
- Afastamentos frequentes por causa da voz

No dia a dia

- Durma bem: a voz também se recupera no sono.
- Fale menos no intervalo e depois das aulas.
- Evite pigarrear: prefira engolir ou beber água.

Base: literatura de voz e Protocolo DRT (Ministério da Saúde, 2018)

FICHA 60 VOZ

Voz cansa no fim do dia

Fadiga vocal: **começa bem e termina rouca**



O que é

Na **fadiga vocal**, a voz piora com o uso ao longo do dia: fica rouca, mais grave e exige mais esforço. Pode haver dor ou aperto na garganta.

Costuma estar ligada a uso intenso, tensão e pouca hidratação. Quando persiste, pode ser o **primeiro sinal** de uma alteração na laringe.

Sinais de fadiga

- Voz pior no fim do dia
- Esforço para falar
- Dor ou tensão no pescoço
- Garganta seca ou apertada
- Vontade de parar de falar

Funcional ou lesão?

A voz se recupera depois de uma noite de descanso?

SIM — Fadiga funcional
Ajuste o uso da voz, a técnica e a hidratação.

NÃO — Investigue lesão
Encaminhe ao otorrino para exame da laringe.

Como avaliar: passo a passo

1. **Diário vocal** — Anote quantas horas fala por dia e em quais situações.
2. **Quando piora** — Em que momento a voz começa a cansar?
3. **Questionário** — Aplique o Índice de Fadiga Vocal.
4. **Tensão** — Observe e palpe pescoço e ombros.
5. **Hábitos** — Água, café, álcool, cigarro e qualidade do sono.
6. **Exame** — Se não houver melhora, encaminhe ao otorrino.

Estratégias de terapia

- **Pausas programadas:** intervalos de silêncio ao longo do dia de trabalho.
- **Exercícios com canudo:** sons e sopros com canudo diminuem o esforço da voz.
- **Relaxamento:** alongar e soltar pescoço e ombros.
- **Hidratação:** beber água em pequenos goles ao longo do dia.

Pausa vocal

1. A cada hora de fala
2. Beber água
3. Alongar o pescoço
4. Alguns minutos de silêncio

Sinais de atenção

- Voz não se recupera com descanso
- Dor ao falar ou engolir
- Rouquidão contínua
- Perda dos agudos ao cantar

No dia a dia

- Tenha sempre uma garrafa de água por perto.
- Evite falar alto em lugares barulhentos.
- Respeite as pausas, mesmo nos dias corridos.

Base: literatura de voz (incluindo escala GRBAS)

FICHA 61 VOZ

Voz fraca e soprosa

"Sai **mais ar do que voz**"



O que é

Na **voz soprosa**, as pregas vocais não fecham completamente e o ar escapa enquanto a pessoa fala. A voz fica fraca, sussurrada e cansa rápido.

Pode ser causada por nódulos, paralisia de prega vocal, envelhecimento ou doenças neurológicas. O tratamento depende do **diagnóstico do otorrino**.

Como soa

Soprosa
Escape de ar audível, voz parecida com sussurro.

Fraca
Pouca intensidade: some no barulho e cansa.

Qual a urgência?

A voz mudou de repente, após cirurgia (ex.: de tireoide) ou intubação?

SIM — Otorrino com urgência
Investigar paralisia de prega vocal.

NÃO — Avaliação completa
Avaliação de voz e exame da laringe.

Como avaliar: passo a passo

1. **Tempo máximo de fonação**
   Peça um "aaa" longo: tempo curto sugere escape de ar.
2. **Relação s/z**
   Compare o tempo de "sss" e "zzz".
3. **Escala GRBAS**
   Atenção ao item soprosidade (B).
4. **Respiração**
   Observe a coordenação entre respiração e voz.
5. **História**
   Cirurgias, intubação e doenças neurológicas.
6. **Exame da laringe**
   Encaminhe ao otorrino.

Estratégias de terapia

- **Fechamento das pregas:** exercícios específicos, escolhidos conforme o diagnóstico.
- **Respiração e voz:** coordenar a saída do ar com o início da voz.
- **Exercícios com canudo:** ajudam a produzir voz com menos esforço.
- **Projeção:** aumentar a intensidade sem forçar a garganta.

Antes dos exercícios

1. **Exame da laringe**
2. **Diagnóstico da causa**
3. **Plano de exercícios**
4. **Reavaliação periódica**

Sinais de atenção

- Início súbito após cirurgia ou intubação
- Engasgos ao beber líquidos
- Falta de ar ao falar
- Piora progressiva da voz

No dia a dia

- Fale de frente e perto das pessoas, sem gritar.
- Evite competir com o barulho do ambiente.
- Beba água ao longo do dia.

Base: literatura de voz (incluindo escala GRBAS)

FICHA 62 VOZ

Pigarro constante

Limpa a garganta **o tempo todo**



O que é

O **pigarro** é o hábito de limpar a garganta com força. Cada pigarro atrita as pregas vocais, o que aumenta a irritação e a vontade de pigarrear de novo.

Pode ter causa médica, como refluxo, rinite ou secreção que desce do nariz, ou ser só um **hábito** que se mantém sozinho.

Possíveis causas

- Refluxo (Ficha 63)
- Rinite e secreção descendo pela garganta
- Pouca hidratação e ar seco
- Hábito após gripes ou alergias
- Alterações nas pregas vocais

Causa ou hábito?

Há sinais de refluxo, rinite ou secreção descendo pela garganta?

SIM — Trate a causa
Encaminhe ao otorrino ou gastro, junto com a terapia.

NÃO — Provável hábito
Trabalhe a percepção e a substituição do pigarro.

Como avaliar: passo a passo

1. **Frequência**
   Conte os pigarros durante 10 minutos de conversa.
2. **Momentos**
   Piora ao acordar, depois de comer ou ao falar muito?
3. **Sintomas associados**
   Azia, nariz entupido, secreção ou tosse?
4. **Hidratação**
   Quanta água a pessoa bebe por dia?
5. **Voz**
   Avalie a qualidade vocal pela escala GRBAS.
6. **Exame**
   Encaminhe ao otorrino se houver rouquidão persistente.

Estratégias de terapia

- **Percepção:** notar a vontade de pigarrear antes que ela aconteça.
- **Substituição:** no lugar do pigarro, engolir em seco ou tomar um gole de água.
- **Hidratação:** beber água em pequenos goles ao longo do dia.
- **Exercícios suaves:** sons com canudo para relaxar a garganta.

No lugar do pigarro

1. Perceber a vontade
2. Fechar a boca
3. Engolir ou beber água
4. Esperar a sensação passar

Sinais de atenção

- Pigarro com rouquidão persistente
- Azia ou queimação
- Sensação de bolo na garganta
- Dificuldade para engolir

No dia a dia

- Tenha água sempre por perto.
- Na vontade de pigarrear, engula em seco.
- Observe se piora depois das refeições ou ao deitar.

Base: literatura de voz

FICHA 63 VOZ

Refluxo e voz

Rouquidão **pela manhã** e bolo na garganta



O que é

No **refluxo laringofaríngeo**, o conteúdo do estômago sobe até a garganta e irrita a laringe. Muitas vezes acontece **sem azia**.

O diagnóstico e o tratamento são médicos (otorrino ou gastro). A fono trata os efeitos na voz e orienta hábitos.

Dois tipos de refluxo

Gastroesofágico
Azia e queimação no peito.

Laringofaríngeo
Rouquidão, pigarro, tosse e bolo na garganta, muitas vezes sem azia.

Por onde começar?

Há rouquidão ao acordar, pigarro e sensação de bolo na garganta?

SIM Encaminhe ao médico
Otorrino ou gastro para diagnóstico e tratamento.

NÃO Investigue outras causas
Avalie hábitos vocais e outras alterações.

Como avaliar: passo a passo

1. **Sintomas**
   Quais aparecem e em que horário do dia?
2. **Questionário**
   Aplique o Índice de Sintomas de Refluxo: acima de 13 sugere refluxo.
3. **Alimentação**
   Jantar tarde, café, álcool, frituras, chocolate e alimentos ácidos.
4. **Hábitos**
   Cigarro, peso e deitar logo depois de comer.
5. **Voz**
   Avalie a qualidade vocal pela escala GRBAS.
6. **Exame**
   Encaminhe para avaliação médica.

Orientações e terapia

- **Jantar cedo:** fazer a última refeição de 2 a 3 horas antes de deitar.
- **Cabeceira elevada:** elevar a cabeceira da cama, conforme orientação médica.
- **Alimentação:** reduzir café, álcool, frituras, chocolate e alimentos muito ácidos.
- **Terapia de voz:** trabalhar pigarro e tensão junto com o tratamento médico.

Hábitos que ajudam

1. **Refeições menores**
2. **Jantar cedo**
3. **Cabeceira elevada**
4. **Não deitar após comer**
5. **Não fumar**

Sinais de atenção

- Dificuldade ou dor para engolir
- Perda de peso sem explicação
- Rouquidão persistente
- Tosse crônica ou falta de ar

No dia a dia

- Evite deitar logo depois de comer.
- Prefira refeições leves à noite.
- Siga o tratamento médico até o fim.

Base: literatura de voz (incluindo Índice de Sintomas de Refluxo)

FICHA 64 VOZ

Voz fina no adolescente

Muda vocal **incompleta** após a puberdade



O que é

Na puberdade, a laringe cresce e a voz fica mais grave, principalmente nos meninos. Na **muda vocal incompleta**, a laringe já se desenvolveu, mas a voz continua aguda.

Geralmente tem causa funcional ou emocional e costuma **responder bem e rápido** à terapia de voz, depois de o otorrino descartar causas orgânicas.

Esperado × alterado

Muda esperada
A voz desce e oscila por alguns meses durante a puberdade.

Muda incompleta
A voz continua aguda depois que a puberdade terminou.

Por onde começar?

A voz grave aparece quando ele tosse ou pigarreia?

SIM — Use a tosse como ponte
Parta da tosse para chegar à voz grave na fala.

NÃO — Investigue a causa
Otorrino e, se preciso, endocrinologista.

Como avaliar: passo a passo

1. **Desenvolvimento** — Idade e sinais de puberdade (com o médico).
2. **Comparação** — Compare a voz da fala com a voz da tosse e do riso.
3. **Exame da laringe** — Encaminhe ao otorrino para confirmar laringe sem alterações.
4. **Emoções** — Ele se sente desconfortável com a voz grave? Há timidez?
5. **Impacto** — Há apelidos, bullying ou dificuldade ao telefone?
6. **Registro** — Grave a voz para comparar a evolução.

Estratégias de terapia

- **Da tosse à voz:** tosse sonorizada, depois um “humm” grave e, então, palavras.
- **Laringe mais baixa:** técnica manual feita ou orientada pela fono.
- **Bocejo-suspiro:** relaxa a garganta e favorece a voz mais grave.
- **Generalização:** levar a nova voz para leitura, conversa e telefone.

Da tosse à fala

1. Tosse sonorizada
2. “Humm” grave
3. Vogais
4. Palavras
5. Frases e conversa

Sinais de atenção

- Voz aguda após o fim da puberdade
- Bullying ou sofrimento com a voz
- Sinais de atraso na puberdade
- Voz que falha com frequência

Orientação à família

- Não faça brincadeiras com a voz do adolescente.
- Valorize a voz nova quando ela aparecer.
- Apoie a terapia: a evolução costuma ser rápida.

Base: literatura de voz

FICHA 65 VOZ

Voz do idoso

Presbifonia: voz **mais fraca e trêmula**



O que é

A **presbifonia** é o envelhecimento da voz. As pregas vocais perdem massa e firmeza, e a voz pode ficar mais fraca, soprosa, rouca ou trêmula.

Não é inevitável nem "normal da idade" a ponto de não ter tratamento: os **exercícios vocais** trazem bons resultados.

Mudanças mais comuns

Nos homens
A voz tende a ficar mais aguda.

Nas mulheres
A voz tende a ficar mais grave.

Nos dois casos, a voz pode ficar mais fraca e cansar mais rápido.

Envelhecimento ou outra causa?

A mudança foi rápida ou veio com tremor nas mãos, engasgos ou perda de peso?

SIM — Investigue outras causas
Encaminhe ao médico (neurologista, otorrino).

NÃO — Presbifonia
Exercícios vocais e orientação.

Como avaliar: passo a passo

1. **História**
   Quando a voz mudou e o que a pessoa sente ao falar.
2. **Escala GRBAS**
   Avalie rouquidão, soprosidade e fraqueza.
3. **Tempo máximo de fonação**
   Peça um "aaa" longo e cronometre.
4. **Respiração**
   Observe o apoio respiratório durante a fala.
5. **Audição**
   Perda auditiva altera o volume da própria voz: investigue.
6. **Exame da laringe**
   Encaminhe ao otorrino.

Estratégias de terapia

- **Força vocal:** exercícios para fechamento e firmeza das pregas vocais.
- **Respiração e apoio:** coordenar a respiração com a fala.
- **Exercícios com canudo:** voz com menos esforço e mais resistência.
- **Usar a voz todo dia:** ler em voz alta e cantar; o isolamento enfraquece a voz.

Rotina de 10 minutos

1. **Aquecer com canudo**
2. **Vogais longas**
3. **Leitura em voz alta**
4. **Cantar uma música**

Sinais de atenção

- Engasgos ao comer ou beber (Ficha 71)
- Tremor ou lentidão nos movimentos
- Rouquidão súbita
- Perda auditiva sem acompanhamento

Orientação à família

- Converse com a pessoa todos os dias.
- Fale de frente, em lugar silencioso.
- Incentive o canto e a leitura em voz alta.

Base: literatura de voz

FICHA 66 VOZ

Higiene vocal: o que orientar

Hábitos que **protegem a voz**



O que é

A **higiene vocal** reúne hábitos que protegem as pregas vocais e previnem alterações de voz. É útil para todos e essencial para quem usa a voz no trabalho.

Funciona melhor com **poucas metas por vez**, escolhidas junto com a pessoa, do que com uma lista longa de proibições.

Faça × evite

Faça

Beber água, fazer pausas, dormir bem, aquecer a voz antes de usar muito.

Evite

Gritar, pigarrear, fumar, falar alto no barulho, usar pastilhas que anestesiam.

Que orientação dar?

A pessoa usa a voz no trabalho (professor, cantor, vendedor, atendente)?

SIM Orientação completa
Higiene vocal mais aquecimento e desaquecimento (Ficha 67).

NÃO Orientação básica
Os hábitos principais, com metas simples.

Como orientar

1. **Levante os hábitos**
   Pergunte sobre água, gritos, pigarro, cigarro, sono e ambiente.
2. **Priorize**
   Escolha os 3 hábitos que mais prejudicam a voz.
3. **Metas pequenas**
   Uma ou duas mudanças por semana.
4. **Diário vocal**
   A pessoa anota o uso da voz e os sintomas.
5. **Reavalie**
   Revise as metas a cada retorno.
6. **Envolva outros**
   Família e trabalho podem ajudar nas mudanças.

Os quatro pilares

- **Hidratação:** água em pequenos goles ao longo do dia.
- **Uso da voz:** sem gritar, com pausas e sem competir com o barulho.
- **Saúde geral:** sono, alimentação e tratamento de refluxo e alergias.
- **Ambiente:** menos ruído, ar menos seco e boa acústica.

Por que evitar

1. **Pastilhas: mascaram o cansaço**
2. **Pigarro: atrita as pregas**
3. **Cigarro: irrita a laringe**
4. **Sussurro forçado: também cansa**

Procure avaliação se houver

- Rouquidão por mais de 2 semanas
- Dor ao falar
- Perda de voz frequente
- Esforço constante para falar

No dia a dia

- Tenha uma garrafa de água por perto.
- Chame as pessoas indo até elas, sem gritar.
- Descanse a voz depois de usá-la muito.

Base: literatura de voz

FICHA 67 VOZ

Aquecimento e desaquecimento vocal

Rotina **antes e depois** de usar muito a voz



O que é

O **aquecimento vocal** prepara músculos e pregas vocais para um uso intenso, como aulas, canto ou palestras. O desaquecimento leva a voz de volta ao padrão de fala.

Os exercícios devem ser **confortáveis**: nunca causar dor ou cansaço.

Antes × depois

5–10 min
Aquecimento
Antes do uso intenso. Prepara a voz.

3–5 min
Desaquecimento
Depois do uso. Relaxa e volta ao normal.

Que rotina usar?

A pessoa vai usar a voz por muito tempo ou com intensidade?

SIM Rotina completa
Os 6 passos do aquecimento e o desaquecimento depois.

NÃO Rotina curta
Alongamento, vibração de lábios e "humm" já ajudam.

Sequência do aquecimento

1. **Alongamento**
   Movimentos suaves de pescoço e ombros.
2. **Respiração**
   Inspirar pelo nariz e soltar o ar devagar em "sss".
3. **Vibração**
   Vibrar os lábios ("brrr") ou a língua ("trrr"), subindo e descendo o tom.
4. **Canudo**
   Fazer sons dentro de um canudo, variando do grave ao agudo.
5. **"Humm"**
   Sons nasais em tom confortável, sentindo a vibração no rosto.
6. **Articulação**
   Exagerar as vogais e falar trava-línguas devagar.

Sequência do desaquecimento

- **Bocejo-suspiro:** bocejar e soltar o ar com um suspiro suave.
- **Descida de tom:** deslizar a voz do agudo para o grave, bem leve.
- **"Humm" grave:** sons nasais suaves, no tom da fala.
- **Alongamento final:** soltar pescoço, ombros e mandíbula.

Cuidados

1. **Sem dor nos exercícios**
2. **Volume confortável**
3. **Pare se houver incômodo**
4. **Beba água antes e depois**

Sinais de atenção

- Dor durante os exercícios
- Rouquidão que não melhora
- Cansaço vocal mesmo aquecendo
- Perda de voz

No dia a dia

- Aqueça a voz no caminho para o trabalho.
- Depois de usar muito a voz, faça alguns minutos de silêncio.
- Beba água antes, durante e depois do uso.

Base: literatura de voz

FICHA 68 DISFAGIA

Tosse ao beber líquidos

Engasga **com água**



O que é

Tossir durante ou logo depois de engolir pode indicar que o líquido está indo para a via aérea (**penetração ou aspiração**). Os líquidos finos, como a água, são os mais difíceis de controlar.

Atenção: há também a **aspiração silenciosa**, sem tosse. Pneumonias de repetição podem ser o único sinal.

Sinais de alerta

- Tosse durante ou logo após engolir
- Voz "molhada" depois de engolir
- Pigarro depois de beber
- Falta de ar ou cansaço nas refeições
- Pneumonias de repetição

Qual a conduta?

Há tosse ou voz molhada depois de engolir líquidos?

SIM — Suspeita de aspiração
Avaliação completa e exame instrumental, se necessário.

NÃO — Fique atento
Com pneumonias de repetição, investigue aspiração silenciosa.

Como avaliar: passo a passo

1. **História**
   Doenças neurológicas, AVC, Parkinson, idade e medicamentos.
2. **Teste clínico**
   Ofereça volumes crescentes de água, com segurança.
3. **Sinais**
   Observe tosse, voz molhada e mudanças na respiração.
4. **Oximetria**
   Queda da saturação durante as refeições pode ser um sinal.
5. **Exame instrumental**
   Videofluoroscopia ou videoendoscopia da deglutição, quando indicado.
6. **Registro**
   Classifique a ingestão oral pela escala FOIS (Ficha 74).

Estratégias de terapia

- **Consistência:** líquidos espessados, conforme a avaliação (IDDSI, Ficha 73).
- **Postura:** queixo para baixo, se indicado pelo exame (Ficha 77).
- **Volume:** goles pequenos, um de cada vez.
- **Exercícios:** fortalecimento e coordenação da deglutição, conforme o caso.

Na hora de beber

1. Sentado e ereto
2. Atenção total
3. Goles pequenos
4. Um gole por vez
5. Esperar engolir

Sinais de atenção

- Pneumonias de repetição
- Febre depois das refeições
- Perda de peso
- Desidratação

Orientação à família

- Não ofereça líquidos com a pessoa deitada.
- Evite TV e conversas durante as refeições.
- Siga a consistência indicada pela fono.

Base: literatura de disfagia (incluindo IDDSI e FOIS)

FICHA 69 DISFAGIA

Engasgo com alimento sólido

A comida **"para na garganta"**



O que é

A dificuldade com sólidos pode estar na boca e na garganta (**disfagia orofaríngea**) ou no esôfago (disfagia esofágica). Saber onde a comida "para" orienta o encaminhamento.

Mastigação ruim, próteses mal adaptadas e refeições apressadas também aumentam o risco de **engasgos**.

Onde está a dificuldade?

Orofaríngea
Dificuldade para iniciar a deglutição, tosse e comida parada na garganta.

Esofágica
Sensação de comida parada no peito, que piora com sólidos.

Para onde encaminhar?

A sensação é de comida parada no peito, piorando com o tempo?

SIM Gastroenterologista
Investigar o esôfago.

NÃO Avaliação da deglutição
Avaliação fonoaudiológica orofaríngea.

Como avaliar: passo a passo

1. **Alimentos**
   Quais causam dificuldade: carne, pão, arroz, comprimidos?
2. **Mastigação**
   Avalie dentes, próteses e eficiência da mastigação.
3. **Tempo**
   Quanto tempo dura uma refeição? A pessoa come apressada?
4. **Resíduos**
   Sobra comida na boca ou a pessoa precisa engolir várias vezes?
5. **Sinais de aspiração**
   Tosse, voz molhada e falta de ar durante as refeições.
6. **Exame instrumental**
   Videofluoroscopia ou videoendoscopia, quando indicado.

Estratégias de terapia

- **Consistência:** alimentos mais macios e úmidos, conforme a avaliação.
- **Porções:** pequenas porções e mastigação completa.
- **Prótese:** próteses dentárias bem adaptadas (dentista).
- **Exercícios:** força e coordenação da deglutição, conforme o caso.

Engasgo grave

1. **Não consegue tossir nem falar**
2. **Ligue 192 (SAMU)**
3. **Manobra de Heimlich, por quem souber**
4. **Se desmaiar, iniciar a reanimação**

Sinais de atenção

- Engasgos graves ou frequentes
- Perda de peso
- Dor ao engolir
- Dificuldade crescente com sólidos

Orientação à família

- Corte os alimentos em pedaços pequenos.
- Coma sentado, devagar e sem pressa.
- Aprenda a manobra de Heimlich.

Base: literatura de disfagia (incluindo IDDSI e FOIS)

FICHA 70 DISFAGIA

Disfagia após AVC: triagem à beira do leito

Antes de liberar comida e água pela boca



O que é

A disfagia é frequente após o AVC e aumenta o risco de **pneumonia aspirativa**, desnutrição e desidratação.

Por isso, a recomendação é fazer a **triagem da deglutição antes** de oferecer qualquer alimento, líquido ou medicamento pela boca.

Antes de testar

- Paciente alerta e colaborativo
- Consegue ficar sentado
- Controla a saliva
- Tem tosse voluntária
- Respiração estável

Pode testar?

O paciente está alerta e consegue ficar sentado com segurança?

SIM Aplique a triagem
Use um protocolo padronizado.

NÃO Nada pela boca
Mantenha jejum oral e reavalie depois.

Como avaliar: passo a passo

1. **Prontuário**
   Tipo de AVC, intubação, uso de oxigênio e nível de consciência.
2. **Exame da boca e do rosto**
   Lábios, língua, palato, força e simetria.
3. **Saliva**
   Observe a deglutição da própria saliva.
4. **Teste com água**
   Volumes crescentes, observando cada gole.
5. **Sinais**
   Tosse, voz molhada, falta de ar e queda da saturação.
6. **Conduta**
   Defina a dieta ou a via alternativa e registre.

Conduta após a triagem

- **Falhou:** nada pela boca e avaliação completa da deglutição.
- **Passou com restrições:** consistências seguras, definidas pela IDDSI (Ficha 73).
- **Cuidados:** cabeceira elevada e higiene oral, que ajuda a prevenir pneumonia.
- **Equipe:** informe enfermagem, médico e nutricionista sobre a conduta.

Protocolos usados

PARD · GUSS · Teste de água

Sinais de atenção

- Pneumonia depois do AVC
- Febre e queda da saturação
- Tosse ou voz molhada nas refeições
- Desidratação ou perda de peso

Orientação à família

- Não ofereça comida nem água sem liberação da equipe.
- Mantenha a cabeceira elevada.
- Ajude na higiene da boca.

Base: literatura de disfagia neurogênica (incluindo PARD e GUSS)

FICHA 71 DISFAGIA

Disfagia no idoso

Come mais devagar e **engasga com frequência**



O que é

Com a idade, a deglutição muda: fica mais lenta, a língua perde força e a boca produz menos saliva. Essas mudanças são chamadas de **presbifagia**.

A presbifagia não é doença, mas deixa o idoso mais vulnerável. Engasgos, perda de peso e pneumonias indicam **disfagia** e precisam de avaliação.

O que muda com a idade

- **Deglutição mais lenta**
- **Menos força na língua**
- **Menos saliva, também por medicamentos**
- **Próteses mal adaptadas**
- **Menor sensibilidade na garganta**

Presbifagia ou disfagia?

Há engasgos frequentes, tosse nas refeições ou pneumonias?

SIM Disfagia
Avaliação completa da deglutição (Ficha 68).

NÃO Presbifagia
Prevenção, exercícios e refeições seguras.

Como avaliar: passo a passo

1. **Alimentação**
   O que a pessoa evita comer e quanto tempo leva a refeição.
2. **Dentes e próteses**
   Próteses bem adaptadas? Dor ou feridas na boca?
3. **Medicamentos**
   Alguns causam boca seca ou sonolência.
4. **Nutrição**
   Peso e hidratação, com nutricionista ou médico.
5. **Sinais de aspiração**
   Tosse, voz molhada e falta de ar nas refeições.
6. **Teste clínico**
   Avalie a deglutição com diferentes consistências.

Estratégias de terapia

- **Exercícios:** força da língua e da deglutição, conforme a avaliação.
- **Consistências:** adaptar os alimentos quando for necessário (Ficha 73).
- **Ambiente:** refeições sentado, sem pressa e sem distrações.
- **Saúde bucal:** higiene oral e próteses ajustadas pelo dentista.

Refeição segura

1. **Sentado e ereto**
2. **Prótese bem colocada**
3. **Pequenas porções**
4. **Sem pressa**
5. **Sentado por 30 minutos depois**

Sinais de atenção

- **Perda de peso**
- **Desidratação**
- **Engasgos frequentes**
- **Pneumonias**

Orientação à família

- **Acompanhe as refeições e observe tosse ou engasgo.**
- **Leve ao dentista para ajustar a prótese.**
- **Ofereça água várias vezes ao dia.**

Base: literatura de disfagia (incluindo IDDSI e FOIS)

FICHA 72 DISFAGIA

Disfagia na doença de Parkinson

Dificuldade para engolir que **avança aos poucos**



O que é

A disfagia é frequente na **doença de Parkinson** e pode atingir todas as fases da deglutição: mastigação lenta, dificuldade para iniciar a deglutição e resíduos na garganta.

A aspiração costuma ser **silenciosa**, sem tosse. Por isso, a avaliação deve ser periódica, mesmo sem queixa.

Sinais comuns

- Refeições demoradas e cansativas
- Baba e acúmulo de saliva
- Comida parada na garganta
- Tosse ou voz molhada nas refeições
- Dificuldade para engolir comprimidos

Por onde começar?

Há pneumonias, perda de peso ou tosse frequente nas refeições?

SIM — Avaliação instrumental
Videofluoroscopia ou videoendoscopia para definir a conduta.

NÃO — Avaliação clínica periódica
Acompanhe e trabalhe exercícios preventivos.

Como avaliar: passo a passo

1. **Horário dos remédios**
   Avalie no período em que o medicamento está fazendo efeito.
2. **Mastigação e língua**
   Observe lentidão, tremor e força da língua.
3. **Teste clínico**
   Diferentes consistências e volumes, com segurança.
4. **Comprimidos**
   Pergunte como a pessoa engole os remédios.
5. **Voz e tosse**
   Voz fraca e tosse fraca aumentam o risco de aspiração.
6. **Peso e pneumonias**
   Histórico de perda de peso e infecções respiratórias.

Estratégias de terapia

- **Refeição no horário certo:** comer quando o remédio está fazendo efeito.
- **Força expiratória:** treino com aparelho específico, sob orientação da fono.
- **Voz forte:** programas de voz com alta intensidade também ajudam a deglutição.
- **Adaptações:** consistências e manobras conforme a avaliação (Fichas 73 e 77).

Refeição segura

1. No horário do remédio
2. Sentado e ereto
3. Porções pequenas
4. Sem pressa e sem TV
5. Atenção à tosse

Sinais de atenção

- Pneumonias de repetição
- Perda de peso
- Refeições muito longas
- Engasgos com comprimidos

Orientação à família

- Ofereça as refeições no horário de efeito do remédio.
- Acompanhe as refeições e observe tosse ou engasgo.
- Pergunte ao médico sobre outras formas de tomar os comprimidos.

Base: literatura de disfagia neurogênica

FICHA 73 DISFAGIA

Consistências pela IDDSI

Como classificar **líquidos e alimentos** (níveis 0 a 7)



O que é

A **IDDSI** é uma padronização internacional de consistências para pessoas com disfagia. Ela usa números e cores, de 0 a 7, para que toda a equipe fale a mesma língua.

Os níveis 0 a 4 servem para líquidos e os níveis 3 a 7 para alimentos. Os níveis 3 e 4 **valem para os dois**.

Teste do fluxo (líquidos)

10 mL
Seringa
Encha a seringa de 10 mL e solte por 10 segundos.

sobra
Resultado
O que sobra na seringa define o nível (veja ao lado).

Para alimentos, use os testes do garfo e da colher, descritos no site oficial da IDDSI.

Líquido ou alimento?

Você vai classificar uma bebida ou uma comida?

LÍQUIDO Teste do fluxo
Use a seringa de 10 mL (níveis 0 a 4).

ALIMENTO Testes do garfo e da colher
Observe textura, pressão e escoamento (níveis 3 a 7).

Os níveis da IDDSI

1. **Nível 0 · Fino**
   Como a água. Escoa totalmente da seringa.
2. **Níveis 1 e 2**
   Levemente e pouco espessados: sobra de 1 a 8 mL na seringa.
3. **Nível 3 · Moderado**
   Liquidificado: escoa devagar, pode ser tomado no copo.
4. **Nível 4 · Extremo**
   Pastoso e liso: comido de colher, não escoa da seringa.
5. **Níveis 5 e 6**
   Picado e úmido (5); macio e em pedaços pequenos (6).
6. **Nível 7 · Normal**
   Alimentos do dia a dia, incluindo os fáceis de mastigar.

Como usar na prática

- **Prescrição clara:** registre o nível de líquido e o de alimento separadamente.
- **Teste sempre:** espessantes variam por marca, então teste a bebida pronta.
- **Equipe treinada:** cozinha, enfermagem e família usam os mesmos números.
- **Reavalie:** a consistência muda conforme a evolução do paciente.

Sobra na seringa (10 s)

< 1 mL	Nível 0
1–4 mL	Nível 1
4–8 mL	Nível 2
> 8 mL	Nível 3
10 mL	Nível 4 (não escoa)

Cuidados

- Nunca mude o nível sem nova avaliação
- Espessante em excesso também é um risco
- Gelo e gelatina derretem e viram líquido fino
- Confira os nomes oficiais no site da IDDSI

Orientação à família

- Siga exatamente o nível indicado pela fono.
- Prepare o espessante conforme a medida orientada.
- Na dúvida, faça o teste da seringa.

Base: International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI)

FICHA 74 DISFAGIA

Escala FOIS: nível de ingestão oral

Como **registrar a evolução** da alimentação



O que é

A **FOIS** (Functional Oral Intake Scale) classifica o quanto a pessoa consegue se alimentar pela boca, em 7 níveis.

É rápida, fácil de aplicar e muito usada para **registrar a evolução** e comunicar o quadro à equipe.

Três grandes grupos

1–3
Via alternativa
Depende de sonda ou gastrostomia.

4–5
Via oral com limites
Uma consistência ou preparos especiais.

6–7
Via oral ampla
Poucas ou nenhuma restrição.

Por onde classificar?

A pessoa usa sonda ou gastrostomia para se alimentar?

COM SONDA **Níveis 1 a 3**
Veja quanto ela consegue comer ou beber pela boca.

SÓ VIA ORAL **Níveis 4 a 7**
Veja quantas consistências e quais restrições existem.

Os 7 níveis

1 Nível 1
Nada por via oral.

2 Nível 2
Via alternativa, com mínima ingestão de alimento ou líquido pela boca.

3 Nível 3
Via alternativa, com ingestão oral consistente de alimento ou líquido.

4 Nível 4
Via oral total de uma única consistência.

5 Nível 5
Via oral total com várias consistências, mas com preparo especial ou compensações.

6 Níveis 6 e 7
Várias consistências sem preparo especial, com restrições específicas (6) ou sem restrições (7).

Como usar na prática

- **Na admissão:** registre o nível no primeiro atendimento.
- **A cada evolução:** atualize o nível quando a dieta mudar.
- **Na alta:** informe o nível final no relatório.
- **Com a equipe:** use a FOIS junto com os níveis da IDDSI (Ficha 73).

Exemplo de registro

1. **Admissão: FOIS 1**
2. **Semana 1: FOIS 3**
3. **Semana 3: FOIS 5**
4. **Alta: FOIS 6**

Cuidados

- Classifique pelo que a pessoa realmente come
- Não confunda nível de ingestão com segurança
- Reclassifique a cada mudança de dieta
- Registre a data de cada classificação

Orientação à família

- Pergunte à fono em que nível a pessoa está.
- Siga a dieta indicada para aquele nível.
- Avise a equipe se a pessoa piorar ou recusar comida.

Base: Functional Oral Intake Scale (FOIS), Crary e colaboradores (2005)

FICHA 75 DISFAGIA

Comida fica na boca depois de engolir

Resíduo oral nas bochechas e embaixo da língua



O que é

O **resíduo oral** é o alimento que sobra na boca depois de engolir: nas bochechas, embaixo da língua ou no céu da boca.

Ele mostra que a língua e as bochechas não estão controlando bem o alimento. Esse resto pode ser **aspirado depois**, quando a pessoa se deita ou fala.

Causas comuns

- Língua fraca ou lenta
- Pouca sensibilidade na boca
- Paralisia facial (Ficha 55)
- Próteses mal adaptadas
- Doenças neurológicas e demência

Por onde começar?

A pessoa percebe que ficou comida na boca?

SIM — Ensine a limpar
Engolir de novo e usar a língua para varrer a boca.

NÃO — Trabalhe a sensibilidade
Estímulos de sabor e temperatura, e supervisão nas refeições.

Como avaliar: passo a passo

1. **Inspeção** — Depois de engolir, olhe a boca com uma lanterna.
2. **Local** — Anote onde o alimento fica: bochechas, língua ou céu da boca.
3. **Consistência** — Compare o resíduo com alimentos pastosos e sólidos.
4. **Língua** — Avalie força, mobilidade e coordenação.
5. **Sensibilidade** — A pessoa percebe toques e sabores nos dois lados?
6. **Próteses** — Verifique a adaptação das dentaduras.

Estratégias de terapia

- **Deglutições múltiplas:** engolir duas ou mais vezes a cada porção.
- **Língua varredora:** passar a língua pelas bochechas e dentes depois de cada porção.
- **Estímulos sensoriais:** sabores mais intensos e alimentos frios, conforme a avaliação.
- **Exercícios de língua:** força e mobilidade, conforme o caso.

Depois da refeição

1. Olhar a boca
2. Retirar os restos
3. Escovar dentes e língua
4. Ficar sentado por 30 minutos

Sinais de atenção

- Resíduo grande depois de todas as refeições
- Tosse ao deitar depois de comer
- Pneumonias de repetição
- Feridas ou dor na boca

Orientação à família

- Confira se não sobrou comida na boca antes de a pessoa deitar.
- Faça a higiene da boca depois de cada refeição.
- Leve ao dentista para ajustar a prótese.

Base: literatura de disfagia

FICHA 76 DISFAGIA

Pneumonia aspirativa: sinais de alerta

Febre e tosse **depois das refeições**



O que é

A **pneumonia aspirativa** acontece quando saliva, alimento ou líquido vão para o pulmão e causam infecção. É uma das complicações mais graves da disfagia.

A higiene oral ruim aumenta muito o risco, porque as bactérias da boca chegam ao pulmão junto com a saliva. O diagnóstico é **médico**.

Fatores de risco

- Disfagia, com ou sem tosse
- Higiene oral ruim
- Dependência para comer
- Sonolência ou confusão
- Refluxo e vômitos

Qual a conduta?

Há febre, falta de ar, tosse com secreção ou piora do estado geral?

SIM — Avaliação médica já
Comunique a equipe médica imediatamente.

NÃO — Prevenção
Higiene oral, postura e consistências seguras.

Como avaliar: passo a passo

1. **Sinais respiratórios** — Febre, tosse com secreção, falta de ar, chiado.
2. **Idosos** — Confusão e sonolência podem ser os únicos sinais.
3. **Saturação** — Queda do oxigênio no oxímetro.
4. **Refeições** — Tosse e voz molhada durante ou depois de comer?
5. **Boca** — Avalie higiene, saburra na língua e próteses.
6. **Deglutição** — Reavalie a deglutição após cada pneumonia.

Prevenção

- **Higiene oral:** escovar dentes, língua e prótese pelo menos 2 vezes ao dia.
- **Postura:** cabeceira elevada e sentado durante e depois das refeições.
- **Consistência segura:** seguir o nível indicado pela fono (Ficha 73).
- **Supervisão:** acompanhar quem precisa de ajuda para comer.

Higiene oral

1. Escovar os dentes
2. Escovar a língua
3. Limpar a prótese
4. Também em quem usa sonda

Sinais de atenção

- Febre sem causa aparente
- Falta de ar ou chiado no peito
- Confusão ou sonolência súbita
- Queda da saturação

Orientação à família

- Escove a boca da pessoa, mesmo que ela use sonda.
- Mantenha a cabeceira elevada.
- Avise a equipe se surgir febre ou falta de ar.

Base: literatura de disfagia

FICHA 77 DISFAGIA

Manobras posturais e de proteção

Queixo para baixo, cabeça virada e **outras estratégias**



O que é

As **manobras** mudam a posição da cabeça ou o jeito de engolir para tornar a deglutição mais segura. Cada uma serve para um problema específico.

Por isso, só devem ser usadas com **indicação da fono**, de preferência após um exame que mostre que a manobra funciona naquele caso.

Dois tipos

Posturais
Mudam a posição da cabeça: queixo para baixo, cabeça virada, cabeça inclinada.

De proteção
Mudam o jeito de engolir: prender a respiração, engolir com força.

Posso indicar?

O exame mostrou que a manobra torna a deglutição mais segura?

SIM Indique e treine
Ensine a manobra e confira se a pessoa consegue fazer.

NÃO Não use sem teste
Uma manobra errada pode piorar a segurança.

Principais manobras

1. **Queixo para baixo**
   Ajuda a proteger a via aérea quando a deglutição demora a começar.
2. **Cabeça virada**
   Para o lado mais fraco da garganta, direcionando o alimento para o lado bom.
3. **Cabeça inclinada**
   Para o lado mais forte, usando a gravidade.
4. **Deglutição supraglótica**
   Prender a respiração, engolir e tossir logo depois.
5. **Deglutição com esforço**
   Engolir apertando com força a língua e a garganta.
6. **Deglutições múltiplas**
   Engolir mais de uma vez a cada porção.

Como ensinar

- **Uma por vez:** ensine uma manobra de cada vez, sem alimento primeiro.
- **Confira a execução:** observe se a pessoa faz a manobra do jeito certo.
- **Com alimento:** só depois passe para a refeição, com supervisão.
- **Reavalie:** manobras podem deixar de ser necessárias com a evolução.

Antes de indicar

1. Avaliação clínica
2. Exame instrumental
3. Testar a manobra
4. Treinar sem alimento
5. Treinar com alimento

Cuidados

- Não indique sem avaliação
- Pessoa confusa pode não conseguir fazer
- Manobras de proteção cansam
- Cabeça para trás só com indicação

Orientação à família

- Use somente a manobra que a fono ensinou.
- Lembre a pessoa da manobra a cada porção.
- Avise a fono se a pessoa tossir mesmo usando a manobra.

Base: literatura de disfagia

FICHA 78 LEITURA E ESCRITA

Troca P/B, T/D, F/V na escrita

A criança escreve **“bato”** em vez de **“pato”**



O que é

A **troca de surdas e sonoras** na escrita (P/B, T/D, F/V, C/G, S/Z, X/J) é comum no início da alfabetização, porque esses sons se diferenciam só pela vibração da voz.

Quando persiste depois do **3º ano**, merece avaliação da percepção auditiva, da consciência fonológica e da audição.

Os pares surdo × sonoro

P × B	T × D	F × V
C × G	S × Z	X × J

• surdo (sem vibração) • sonoro (com vibração)

Só na escrita ou também na fala?

A criança troca esses sons só ao escrever ou também ao falar?

SÓ NA ESCRITA **Percepção e escrita**
Trabalhe discriminação auditiva e consciência fonológica.

TAMBÉM NA FALA **Comece pela fala**
Trate a troca na fala e investigue a audição (Ficha 08).

Como avaliar: passo a passo

1. **Ditado de palavras** — Use palavras com os 6 pares e anote as trocas.
2. **Ditado de pares** — Dite pares como “pato/bato” e “faca/vaca”.
3. **Discriminação auditiva** — Ela percebe a diferença quando ouve os pares?
4. **Fala** — Verifique se a troca também aparece na fala.
5. **Audição** — Solicite avaliação audiológica, principalmente com histórico de otites.
6. **Consciência fonológica** — Avalie rima, sílaba e fonema (Ficha 83).

Estratégias de terapia

- [x] **Mão no pescoço:** sentir a vibração na sonora (“vvv”) e a ausência dela na surda (“fff”).
- [x] **Pares escritos:** jogos de escolher a palavra certa (pato ou bato?).
- [x] **Ditado com pistas:** a criança diz a palavra baixinho e sente a vibração antes de escrever.
- [x] **Revisão do texto:** ensinar a reler o próprio texto procurando as trocas.

Pares para o ditado

pato × bato

faca × vaca

tia × dia

Mais palavras

pote · bote · cola · gola · selo · zelo

Sinais de atenção

- Trocas frequentes depois do 3º ano
- A mesma troca também na fala
- Histórico de otites ou suspeita auditiva
- Dificuldade geral de leitura

Orientação à família

- Brinquem de “motor ligado e desligado” com a mão no pescoço.
- Leiam juntos palavras com esses pares.
- Elogie quando ela encontrar e corrigir a própria troca.

Base: literatura de linguagem escrita e aprendizagem

FICHA 79 LEITURA E ESCRITA

Espelha letras (b/d, p/q)

Escreve o **"b" virado** para o lado errado



O que é

O **espelhamento** de letras (b/d, p/q, e números como 3 e 7) é comum no início da alfabetização. Nosso cérebro aprende a reconhecer objetos de qualquer lado, e as letras são uma exceção.

Costuma diminuir até cerca de **7 a 8 anos**. Espelhar sozinho não significa dislexia.

Esperado × atenção

Esperado
Espelhamentos ocasionais no 1° e no 2° ano, diminuindo com o tempo.

Atenção
Persiste após os 8 anos, junto com leitura lenta ou outras trocas.

Fase ou sinal de alerta?

O espelhamento persiste após os 8 anos e vem junto com dificuldade de leitura?

SIM — Avalie a linguagem escrita
Investigue dislexia e outras dificuldades (Ficha 82).

NÃO — Fase esperada
Use pistas visuais e acompanhe a evolução.

Como avaliar: passo a passo

1. **Idade e ano escolar** — Considere a fase da alfabetização da criança.
2. **Frequência** — Os espelhamentos são raros ou aparecem o tempo todo?
3. **Leitura** — Ela também confunde b e d ao ler?
4. **Outras trocas** — Há trocas de sons ou omissões na escrita?
5. **Lateralidade** — Ela sabe direita e esquerda no próprio corpo?
6. **Visão** — Confirme se a visão foi avaliada.

Estratégias de terapia

- **Palavra-chave com figura:** "b" de bola, "d" de dado, sempre visíveis na mesa.
- **Multissensorial:** traçar a letra grande no ar, na areia ou com massinha.
- **Ponto de partida:** ensinar por onde a letra começa e para onde vai.
- **Uma letra por vez:** consolidar o "b" antes de apresentar o "d".

Palavras-chave

b · bola | d · dado | p · pato | q · queijo

Sequência

1. Traçar no ar
2. Traçar na areia
3. Escrever grande
4. Escrever no caderno

Sinais de atenção

- Espelhamento frequente após os 8 anos
- Leitura lenta e com muitos erros
- Dificuldade com direita e esquerda
- Casos de dislexia na família

Orientação à família

- Cole na mesa um cartão com "b de bola" e "d de dado".
- Não chame a atenção na frente dos colegas.
- Brinquem de escrever letras na areia ou com massinha.

Base: literatura de linguagem escrita e aprendizagem

FICHA 80 LEITURA E ESCRITA

Leitura lenta e silabada

Lê "ca-sa" sem fluência



O que é

A **fluência de leitura** reúne precisão, velocidade e entonação. Quando a criança lê sílaba por sílaba, gasta tanta energia decifrando que sobra pouco para entender o texto.

Pode ser causada por decodificação fraca, pouca prática de leitura ou **dislexia** (Ficha 82).

Os três componentes

- **Precisão:** ler as palavras corretamente
- **Velocidade:** ler em ritmo adequado ao ano escolar
- **Entonação:** ler com pausas e expressão

Por onde começar?

Ela lê as palavras corretamente, mesmo que devagar?

SIM — Trabalhe a fluência
Leitura repetida e com modelo para ganhar velocidade.

NÃO — Trabalhe a decodificação
Relação letra-som e consciência fonológica (Ficha 83).

Como avaliar: passo a passo

1. **Leitura cronometrada**
   Conte as palavras lidas corretamente em 1 minuto.
2. **Compare com o ano escolar**
   Use referências para a série da criança.
3. **Tipos de erro**
   Troca de letras, omissões ou adivinhação pela primeira sílaba?
4. **Palavras inventadas**
   A leitura de palavras sem sentido mostra a decodificação pura.
5. **Compreensão**
   Faça perguntas sobre o texto lido (Ficha 81).
6. **Visão e audição**
   Confirme que foram avaliadas.

Estratégias de terapia

- **Leitura repetida:** ler o mesmo texto curto várias vezes até ficar fluente.
- **Leitura com modelo:** o adulto lê primeiro e a criança repete o trecho.
- **Leitura em coro:** adulto e criança leem juntos, no mesmo ritmo.
- **Palavras frequentes:** treinar as palavras mais comuns até serem lidas de imediato.

Leitura repetida

1. **Texto curto e adequado**
2. **Adulto lê primeiro**
3. **Criança lê 3 vezes**
4. **Cronometrar e comemorar**

Sinais de atenção

- Leitura silabada após o 2º ano
- Muitos erros ao ler palavras simples
- Evita ler em voz alta
- Casos de dislexia na família

Orientação à família

- Leiam juntos todos os dias, por alguns minutos.
- Deixe a criança reler livros de que ela gosta.
- Elogie o esforço, não só a velocidade.

Base: literatura de linguagem escrita e aprendizagem

FICHA 81 LEITURA E ESCRITA

Lê, mas não entende

Dificuldade de **compreensão leitora**



O que é

Compreender um texto depende de duas habilidades: **decodificar** as palavras e **compreender a linguagem**. Se uma das duas falha, a compreensão cai.

Por isso, a primeira pergunta é: a criança entende o texto quando **alguém lê para ela**?

Visão Simples da Leitura

Decodificação
Transformar letras em palavras, com precisão e fluência.

Compreensão oral
Entender o significado: vocabulário, frases e inferências.

Compreensão leitora = decodificação × compreensão oral.

Onde está a dificuldade?

Ela entende o mesmo texto quando alguém lê em voz alta para ela?

SIM Decodificação
A leitura consome toda a atenção: trabalhe fluência (Ficha 80).

NÃO Linguagem
Vocabulário, frases e inferência (Fichas 23 e 27).

Como avaliar: passo a passo

1. **Leitura e perguntas**
   Peça a leitura de um texto e faça perguntas sobre ele.
2. **Texto lido para ela**
   Leia outro texto em voz alta e compare as respostas.
3. **Tipos de pergunta**
   Separe as literais (está no texto) das inferenciais (é preciso deduzir).
4. **Reconto**
   Peça que ela conte o texto com as próprias palavras.
5. **Vocabulário**
   Ela conhece as palavras importantes do texto?
6. **Fluência**
   Avalie a velocidade e a precisão da leitura (Ficha 80).

Estratégias de terapia

- **Antes de ler:** falar sobre o tema, o título e as figuras para ativar o que ela já sabe.
- **Vocabulário:** explicar as palavras-chave antes da leitura.
- **Durante a leitura:** parar para perguntar e prever o que vem depois.
- **Depois de ler:** resumir com as próprias palavras e responder perguntas de inferência.

Perguntas para o texto

1. **Quem? Onde?**
2. **O que aconteceu?**
3. **Por que aconteceu?**
4. **O que você acha que vem depois?**
5. **Qual é a ideia principal?**

Sinais de atenção

- Não entende nem quando o texto é lido para ela
- Leitura muito lenta e cansativa
- Vocabulário restrito para a idade
- Queda no rendimento em todas as matérias

Orientação à família

- Depois da leitura, conversem sobre a história.
- Pergunte: “O que você acha que vai acontecer?”
- Explique as palavras novas que aparecerem.

Base: literatura de linguagem escrita e aprendizagem (incluindo o modelo da Visão Simples da Leitura)

FICHA 82 LEITURA E ESCRITA

Dislexia: sinais de alerta

Dificuldade **persistente** para ler e escrever



O que é

A **dislexia** é um transtorno específico de aprendizagem, de origem neurobiológica, que afeta a leitura precisa e fluente e a ortografia. A dificuldade principal está no processamento dos sons da fala.

Não tem relação com inteligência nem com visão. É frequente na mesma família e o diagnóstico é **interdisciplinar**.

Sinais por fase

- **Pré-escola:** dificuldade com rimas e nomes das letras
- **1º e 2º ano:** dificuldade em ligar letras e sons
- **Depois:** leitura lenta e com muitos erros
- **Ortografia** muito alterada
- **Evita** ler e escrever

Dislexia ou falta de oportunidade?

A dificuldade persiste mesmo com ensino adequado e estímulo intensivo?

SIM — Avaliação interdisciplinar
Fono, neuropsicólogo e escola, para investigar dislexia.

NÃO — Intensifique o ensino
Ensino explícito da leitura e reavaliação em alguns meses.

Como avaliar: passo a passo

1. **História**
   Atraso de fala, dificuldades escolares e casos de dislexia na família.
2. **Consciência fonológica**
   Avalie rima, sílaba e fonema (Ficha 83).
3. **Leitura de palavras**
   Compare palavras reais com palavras inventadas.
4. **Fluência**
   Conte as palavras lidas corretamente por minuto (Ficha 80).
5. **Escrita**
   Ditado de palavras e produção de texto.
6. **Compreensão oral**
   Ela entende bem quando ouve? Isso ajuda a diferenciar de outros quadros.

Estratégias de terapia

- **Ensino explícito:** relação letra-som ensinada de forma sistemática e em sequência.
- **Multissensorial:** ver, ouvir, falar e traçar as letras ao mesmo tempo.
- **Fluência:** leitura repetida de textos curtos (Ficha 80).
- **Adaptações escolares:** tempo extra, leitura das questões e provas orais, quando necessário.

Equipe

1. **Fonoaudiólogo**
2. **Neuropsicólogo ou psicólogo**
3. **Escola e professores**
4. **Médico, quando necessário**

Sinais de atenção

- **Leitura muito abaixo do esperado no 3º ano**
- **Casos de dislexia na família**
- **Baixa autoestima ligada à escola**
- **Evita** ler e escrever

Orientação à família

- **Continue lendo para a criança, mesmo que ela já leia.**
- **Valorize o esforço e os outros talentos dela.**
- **Converse com a escola sobre as adaptações previstas em lei.**

Base: literatura de linguagem escrita e aprendizagem (incluindo Lei 14.254/2021)

FICHA 83 LEITURA E ESCRITA

Consciência fonológica: como avaliar

Rima, sílaba e fonema



O que é

A **consciência fonológica** é a capacidade de perceber e brincar com os sons das palavras: rimar, separar sílabas, identificar o primeiro som.

É uma das bases da alfabetização. Crianças com dificuldade nessa habilidade têm **mais risco** de problemas de leitura e escrita.

Três níveis

~4 anos
Rima
sol e anzol terminam igual.

~5 anos
Sílaba
ca-va-lo tem 3 pedaços.

6–7 anos
Fonema
sol começa com /s/.

A consciência dos fonemas se desenvolve junto com a alfabetização.

Por onde começar?

Ela já separa, junta e conta as sílabas das palavras?

SIM **Avance para os fonemas**
Som inicial, segmentação e síntese de sons.

NÃO **Rimas e sílabas**
Trabalhe primeiro os níveis mais simples.

Como avaliar: passo a passo

1. **Rima**
   "Qual termina igual a pão: mão ou pé?"
2. **Som inicial**
   "Quais começam com o mesmo som: faca, fogo, bola?"
3. **Separar sílabas**
   "Bata palmas para cada pedaço de cavalo."
4. **Tirar sílaba**
   "Sapato sem o 'sa' fica...?" (pato)
5. **Juntar sons**
   "/s/ /o/ /l/ forma que palavra?" (sol)
6. **Instrumento**
   Use um teste padronizado (ex.: CONFIAS).

Estratégias de terapia

- **Jogos de rima:** pares de figuras que rimam e músicas com rimas.
- **Sílabas:** palmas, tirar e colocar sílabas, inventar palavras.
- **Som inicial:** "Vamos achar coisas que começam com /m/?"
- **Som + letra:** ligar cada som à letra correspondente aumenta o efeito na leitura.

Ordem de trabalho

1. Rimas
2. Sílabas
3. Som inicial
4. Fonemas
5. Fonema + letra

Sinais de atenção

- Não percebe rimas aos 5 anos
- Não separa sílabas aos 6 anos
- Dificuldade na alfabetização
- Trocas de sons na fala (Fichas 01 a 14)

Orientação à família

- Cantem músicas e parlendas com rimas.
- Brinquem de "o que começa com...?".
- Batam palmas para separar as sílabas dos nomes da família.

Base: literatura de linguagem escrita e aprendizagem (incluindo CONFIAS)

FICHA 84 LEITURA E ESCRITA

Omite letras ao escrever

Escreve “cavlo” em vez de “cavalo”



O que é

As **omissões de letras** aparecem quando a criança não consegue analisar todos os sons da palavra. Acontecem mais nas sílabas complexas, como encontros e sílabas terminadas em consoante.

São comuns no início da alfabetização e diminuem com a prática. Quando persistem, indicam dificuldade de **análise fonológica**.

Onde aparecem mais

- Encontros: prato → “pato”
- R, S e L no fim da sílaba: porta → “pota”
- M e N no fim da sílaba: campo → “capo”
- Vogais em palavras longas: cavalo → “cavlo”
- Letras finais: comer → “come”

Só na escrita?

A criança também omite esses sons quando fala?

SÓ NA ESCRITA **Análise fonológica**
Trabalhe a percepção dos sons na hora de escrever.

TAMBÉM NA FALA **Comece pela fala**
Trate a omissão na fala (Fichas 02 e 03).

Como avaliar: passo a passo

1. **Ditado**
   Use palavras com sílabas simples e complexas.
2. **Classifique**
   Anote em que tipo de sílaba a letra foi omitida.
3. **Leitura do próprio texto**
   Peça que ela leia o que escreveu: ela percebe a falta?
4. **Consciência fonológica**
   Avalie a segmentação dos sons (Ficha 83).
5. **Fala**
   Verifique se a omissão também aparece na fala.
6. **Atenção**
   Omissões que variam muito podem indicar desatenção.

Estratégias de terapia

- **Caixinhas de sons:** um quadrado para cada som; a criança marca os sons antes de escrever.
- **Fala lenta:** dizer a palavra devagar enquanto escreve, som por som.
- **Sílabas em destaque:** usar cores diferentes para as sílabas complexas.
- **Revisão:** reler o próprio texto procurando o que faltou.

Escrever sem omitir

1. Dizer a palavra devagar
2. Contar os sons
3. Escrever
4. Ler o que escreveu
5. Comparar e corrigir

Sinais de atenção

- Omissões frequentes após o 3º ano
- Omissões também na fala
- Dificuldade de leitura
- Desatenção marcante

Orientação à família

- Peça que a criança leia em voz alta o que escreveu.
- Brinquem de contar os sons das palavras.
- Elogie quando ela mesma encontrar a letra que faltou.

Base: literatura de linguagem escrita e aprendizagem

FICHA 85 LEITURA E ESCRITA

Escreve como fala

Escreve “pexe” em vez de “peixe”



O que é

No **apoio na oralidade**, a criança escreve as palavras do jeito que pronuncia. É uma fase esperada: ela ainda acredita que a escrita é a fala “desenhada”.

Aos poucos, aprende que a escrita segue **convenções** que nem sempre correspondem à fala. Considere também o sotaque da região.

Exemplos comuns

- peixe → “pexe”
- tomate → “tomati”
- falou → “falô”
- menino → “minino”
- cantar → “cantá”

Por onde começar?

A criança já entende que falar e escrever são coisas diferentes?

SIM — Ensine as regularidades
Regras e padrões da ortografia, um de cada vez.

NÃO — Mostre a diferença
Compare fala e escrita com exemplos do dia a dia.

Como avaliar: passo a passo

1. **Ditado**
   Use palavras com ditongos, vogais átonas e R final.
2. **Classifique os erros**
   Separe por tipo: “ei” virando “e”, “e” virando “i”, R final omitido.
3. **Reflexão**
   Pergunte: “Por que você escreveu assim?”
4. **Sotaque**
   Considere a pronúncia típica da região da criança.
5. **Leitura**
   Crianças que leem pouco têm menos contato com a forma escrita.
6. **Ano escolar**
   Compare com o esperado para a série.

Estratégias de terapia

- **Fala × escrita:** “A gente fala ‘pexe’, mas escreve ‘peixe’.”
- **Famílias de palavras:** peixe, peixaria, peixinho mostram a forma escrita.
- **Regras em cartazes:** verbos no infinitivo terminam com R (cantar, comer, partir).
- **Jogos de correção:** encontrar e corrigir os erros num texto curto.

Como escreve × como fala

peixe	pexe
tomate	tomati
falou	falô

Sinais de atenção

- Muitos erros desse tipo após o 4º ano
- Não percebe o erro mesmo com ajuda
- Dificuldade geral de leitura
- Escreve muito pouco

Orientação à família

- Leiam juntos: quanto mais leitura, melhor a ortografia.
- Na dúvida, mostre a palavra escrita.
- Não corrija tudo de uma vez: escolha um tipo de erro.

Base: literatura de linguagem escrita e aprendizagem

FICHA 86 LEITURA E ESCRITA

Junta ou separa palavras errado

Escreve **“derrepente”** e **“a bacaxi”**



O que é

Na fala, as palavras saem emendadas. Por isso, no início da escrita, a criança pode **juntar palavras** (“derrepente”) ou **separar** uma palavra em duas (“a bacaxi”).

É comum no 1º e no 2º ano e diminui com a leitura. Quando persiste, merece atenção à **consciência de palavra**.

Dois tipos de erro

derrepente
Junta palavras
Hipossegmentação: “concerteza”, “derrepente”.

a bacaxi
Separa a palavra
Hipersegmentação: “a bacaxi”, “de pois”.

Fase ou dificuldade?

Os erros estão diminuindo com a leitura e o tempo de escola?

SIM **Fase esperada**
Atividades com palavras e muita leitura.

NÃO **Investigue mais**
Avalie consciência de palavra, leitura e linguagem.

Como avaliar: passo a passo

1. **Ditado de frases**
   Dite frases com expressões como “de repente” e “com certeza”.
2. **Classifique**
   Separe os erros de juntar dos erros de separar.
3. **Contar palavras**
   Ela conta quantas palavras tem uma frase falada?
4. **Leitura**
   Crianças que leem pouco erram mais.
5. **Outros erros**
   Há também omissões ou trocas (Fichas 78 e 84)?
6. **Ano escolar**
   Considere a fase da alfabetização.

Estratégias de terapia

- **Contar palavras:** uma ficha ou palma para cada palavra da frase.
- **Recortar frases:** cortar a frase escrita em palavras e montar de novo.
- **Teste do meio:** “Dá para colocar outra palavra no meio?” (a linda gente → a gente).
- **Leitura frequente:** ver as palavras escritas separadas fixa a forma correta.

Certo × errado

de repente	derrepente
com certeza	concerteza
abacaxi	a bacaxi

Sinais de atenção

- Erros frequentes após o 3º ano
- Não consegue contar as palavras de uma frase
- Dificuldade de leitura
- Outros erros de escrita associados

Orientação à família

- Leiam juntos, apontando cada palavra.
- Brinquem de contar as palavras das frases.
- Mostre a forma escrita das expressões em que ela erra.

Base: literatura de linguagem escrita e aprendizagem

FICHA 87 LEITURA E ESCRITA

Disortografia

Muitos erros de ortografia que **persistem**



O que é

A **disortografia** é uma dificuldade específica e persistente com a ortografia, que não se explica por falta de ensino ou de oportunidade.

Pode aparecer sozinha ou junto com a **dislexia**. A criança erra muito, inclusive palavras que já foram ensinadas.

Tipos de erro

- Trocas de sons: P/B, T/D (Ficha 78)
- Omissões de letras (Ficha 84)
- Regras de contexto: R/RR, M antes de P e B
- Palavras irregulares: X/CH, S/Z/Ç
- Junção e separação (Ficha 86)

Só a escrita?

Há também dificuldade importante de leitura?

SIM Investigue dislexia
Avaliação completa da leitura e da escrita (Ficha 82).

NÃO Foco na ortografia
Trabalhe os tipos de erro mais frequentes.

Como avaliar: passo a passo

1. **Ditado balanceado**
   Palavras regulares, com regras de contexto e irregulares.
2. **Classifique os erros**
   Agrupe por tipo para definir as prioridades.
3. **Produção de texto**
   Os erros aumentam na escrita espontânea?
4. **Leitura**
   Avalie precisão, fluência e compreensão.
5. **Consciência fonológica**
   Avalie rima, sílaba e fonema (Ficha 83).
6. **Ano escolar**
   Compare com o que já foi ensinado na série.

Estratégias de terapia

- **Regras explícitas:** uma regra por vez, com exemplos e prática (ex.: M antes de P e B).
- **Famílias de palavras:** casa, casinha, casarão ajudam a lembrar a escrita.
- **Dicionário pessoal:** um caderno com as palavras difíceis da própria criança.
- **Revisão guiada:** um roteiro curto para reler e corrigir o próprio texto.

Ordem de trabalho

1. Trocas de sons
2. Regras de contexto
3. Famílias de palavras
4. Palavras irregulares

Sinais de atenção

- Muitos erros após o 4º ano
- Erra palavras já ensinadas
- Dificuldade de leitura associada
- Evita escrever

Orientação à família

- Leiam juntos com frequência.
- Ajude a criança a montar o dicionário pessoal.
- Valorize as ideias do texto, não só a ortografia.

Base: literatura de linguagem escrita e aprendizagem

FICHA 88 AUDIÇÃO

Criança "desatenta" pode ser audição

A família diz: **"Só ouve quando quer"**



O que é

Perdas auditivas leves, em um ouvido só ou que vão e voltam (como nas otites) costumam passar despercebidas e ser confundidas com **desatenção**.

Por isso, toda criança com queixa de atenção, fala ou rendimento escolar deve ter a **audição avaliada**.

Sinais

- Pede para repetir com frequência
- Assiste à TV com volume alto
- Não atende quando chamada de longe
- Fala alto ou com trocas de sons
- Cansa e se distrai na sala de aula

Por onde começar?

A audição já foi avaliada com exames completos e recentes?

SIM — Audição normal
Investigue atenção e processamento auditivo (Ficha 91).

NÃO — Avalie a audição
Encaminhe para avaliação audiológica antes de tudo.

Como avaliar: passo a passo

1. **História**
   Otites, triagem neonatal, prematuridade, meningite e exposição a ruído.
2. **Comportamento**
   Ela responde quando chamada de costas ou de outro cômodo?
3. **Exames**
   Audiometria e imitanciometria, adequadas à idade.
4. **Um ouvido só**
   Atenção às perdas unilaterais: a criança parece ouvir bem.
5. **Fala e linguagem**
   Avalie trocas de sons e vocabulário.
6. **Escola**
   Onde ela senta? A sala é barulhenta?

Orientações

- **Lugar na sala:** perto do professor e longe de portas, janelas e ventiladores.
- **Antes de falar:** chamar a atenção e falar de frente para a criança.
- **Otites:** tratar e acompanhar com o otorrino (Ficha 90).
- **Perda confirmada:** aparelho auditivo e terapia, quando indicados (Ficha 94).

Na sala de aula

1. **Sentar na frente**
2. **Longe do barulho**
3. **Ver o rosto do professor**
4. **Instruções também por escrito**

Sinais de atenção

- Pede para repetir com frequência
- TV sempre muito alta
- Atraso ou trocas na fala
- Otites frequentes

Orientação à família

- Chame a criança pelo nome e espere o olhar antes de falar.
- Fale de frente e em lugar silencioso.
- Leve para avaliação auditiva se ainda não fez.

Base: literatura de audiologia infantil

FICHA 89 AUDIÇÃO

Teste da Orelhinha

Triagem auditiva neonatal: **falhou, e agora?**



O que é

A **triagem auditiva neonatal** (Teste da Orelhinha) é obrigatória no Brasil (Lei 12.303/2010). É rápida, sem dor e feita com o bebê dormindo.

Falhar na triagem **não é diagnóstico de surdez**: muitas vezes há só secreção no ouvido. Mas o reteste e, se preciso, o diagnóstico não podem atrasar.

Regra 1-3-6

1 mês
Triagem
Até o primeiro mês de vida.

3 meses
Diagnóstico
Para quem falhou.

6 meses
Intervenção
Aparelho e terapia, se houver perda.

Qual o próximo passo?

Qual foi o resultado da triagem auditiva?

PASSOU **Acompanhe**
Com indicador de risco, monitore a audição nos primeiros anos.

FALHOU **Reteste e diagnóstico**
Reteste em até 30 dias; se falhar, diagnóstico completo.

Como avaliar: passo a passo

1. **Caderneta**
   Confira o resultado da triagem registrado na caderneta.
2. **Indicadores de risco**
   UTI neonatal, infecções na gestação, casos de surdez na família.
3. **Tipo de exame**
   Emissões otoacústicas ou PEATE automático (para bebês de risco).
4. **Reteste**
   Confirme que foi feito no prazo.
5. **Diagnóstico**
   Encaminhe para avaliação audiológica completa se falhar de novo.
6. **Desenvolvimento**
   Acompanhe reações a sons, balbucio e primeiras palavras.

Como orientar a família

- **Sem alarme:** falhar não significa surdez, e o reteste esclarece.
- **Sem atraso:** não faltar ao reteste nem ao exame de diagnóstico.
- **Observar em casa:** o bebê se assusta com barulhos? Acalma com a voz da mãe?
- **Quanto antes, melhor:** a intervenção precoce faz grande diferença na linguagem.

Fluxo da triagem

1. **Triagem na maternidade**
2. **Falhou: reteste**
3. **Falhou de novo: diagnóstico**
4. **Perda confirmada: intervenção**

Sinais de atenção

- Bebê não se assusta com barulhos fortes
- Falhou e não fez o reteste
- Tem indicadores de risco
- Não balbucia ou parou de balbuciar

Orientação à família

- Guarde a caderneta com o resultado da triagem.
- Não deixe de fazer o reteste no prazo.
- Converse e cante para o bebê todos os dias.

Base: literatura de audiologia infantil (incluindo Lei 12.303/2010)

FICHA 90 AUDIÇÃO

Otite de repetição e fala

Atraso de fala depois de **várias otites**



O que é

Na **otite com secreção**, fica líquido atrás do tímpano e a criança passa a ouvir "abafado", muitas vezes sem dor. A perda é leve, mas vai e volta.

Quando acontece com frequência nos primeiros anos, pode atrapalhar a percepção dos sons e o **desenvolvimento da fala**.

Dois tipos de otite

Otite aguda
Dor, febre e criança irritada. Costuma ser percebida.

Otite com secreção
Sem dor. A criança ouve abafado e pode passar despercebida.

Por onde começar?

As otites são muito frequentes ou a secreção dura mais de 3 meses?

SIM Otorrino
Avaliar o tratamento, incluindo tubos de ventilação.

NÃO Acompanhe
Monitore audição, fala e linguagem.

Como avaliar: passo a passo

1. **História**
   Quantas otites, quanto tempo durou cada uma e os tratamentos.
2. **Timpanometria**
   A curva tipo B indica líquido atrás do tímpano.
3. **Audiometria**
   Avalie o grau da perda durante e depois das otites.
4. **Fala**
   Observe trocas de sons, principalmente S, F e sonoras (Fichas 04 e 08).
5. **Linguagem**
   Vocabulário e frases adequados para a idade?
6. **Fatores de risco**
   Creche, fumaça de cigarro, chupeta e mamadeira deitado.

Estratégias de terapia

- **Durante as otites:** falar perto, de frente e um pouco mais alto, sem gritar.
- **Estimular a linguagem:** leitura, músicas e conversas, com o rosto visível.
- **Reduzir riscos:** sem fumaça de cigarro, chupeta ou mamadeira deitado.
- **Acompanhar:** reavaliar a audição depois do tratamento.

Aumentam o risco

1. **Fumaça de cigarro**
2. **Chupeta prolongada**
3. **Mamadeira deitado**
4. **Rinite sem tratamento**

Sinais de atenção

- Atraso de fala
- Parece não ouvir em alguns períodos
- Secreção saindo do ouvido
- 3 ou mais otites em 6 meses

Orientação à família

- Não fume perto da criança.
- Ofereça a mamadeira com a criança sentada.
- Durante as otites, fale perto e de frente.

Base: literatura de audiologia infantil

FICHA 91 AUDIÇÃO

Processamento auditivo central

Ouve bem, mas **entende mal o que ouve**



O que é

No **transtorno do processamento auditivo central**, a audição dos ouvidos é normal, mas o cérebro tem dificuldade para analisar o que ouve: separar a fala do ruído, ordenar sons e perceber diferenças rápidas.

A avaliação é feita por fonoaudiólogo, com uma bateria de testes, geralmente **a partir dos 7 anos**.

Sinais

- Entende mal em ambientes barulhentos
- Pede para repetir
- Demora para responder
- Esquece ordens longas
- Dificuldade com leitura, escrita e rimas

Por onde começar?

A audiometria está normal?

SIM **Avalie o processamento**
Bateria de testes de processamento auditivo.

NÃO **Trate a perda**
A perda auditiva vem antes de qualquer outra investigação.

Como avaliar: passo a passo

1. **Audiometria normal**
   Pré-requisito: confirme a audição periférica.
2. **Questionário**
   Use uma escala de comportamento auditivo com pais e professores.
3. **Bateria de testes**
   Fala no ruído, testes dicóticos e de padrões temporais.
4. **Linguagem e leitura**
   Avalie se há dificuldades associadas.
5. **Atenção**
   Diferencie de TDAH, com a equipe.
6. **Escola**
   Pergunte sobre o rendimento e o ambiente da sala.

Estratégias de terapia

- **Treinamento auditivo:** em cabine ou com jogos e programas de computador.
- **Ambiente:** reduzir ruído e sentar perto do professor.
- **Estratégias:** anotar, pedir repetição e usar apoio visual.
- **Linguagem e leitura:** trabalhar em paralelo, quando houver dificuldade.

Habilidades treinadas

1. **Ouvir no ruído**
2. **Ordenar sons**
3. **Perceber diferenças rápidas**
4. **Ouvir com os dois ouvidos**

Sinais de atenção

- Dificuldade escolar persistente
- Muita dificuldade em lugares barulhentos
- Histórico de otites de repetição
- Sinais de desatenção

Orientação à família

- Fale de frente e em lugar silencioso.
- Dê uma instrução de cada vez.
- Peça que ela repita o que entendeu.

Base: literatura de audiologia infantil (incluindo Escala de Comportamento Auditivo)

FICHA 92 AUDIÇÃO

Dificuldade de ouvir no ruído

Entende em casa, mas **não no restaurante**



O que é

Entender a fala no meio do barulho é uma das tarefas mais difíceis para a audição. A dificuldade em **ambientes ruidosos** costuma ser o primeiro sinal de uma perda auditiva nos sons agudos.

Também pode estar ligada ao processamento auditivo ou à atenção. A investigação começa sempre pela **audiometria**.

Possíveis causas

- Perda auditiva nos sons agudos
- Exposição frequente a ruído alto
- Envelhecimento da audição
- Processamento auditivo (Ficha 91)
- Atenção e cansaço

Por onde começar?

A audiometria mostra perda auditiva?

SIM — Trate a perda
Avalie a indicação de aparelho auditivo (Ficha 94).

NÃO — Investigue mais
Processamento auditivo e atenção.

Como avaliar: passo a passo

1. **História**
   Exposição a ruído no trabalho ou no lazer, idade e zumbido.
2. **Audiometria**
   Atenção especial às frequências agudas.
3. **Fala no ruído**
   Teste de reconhecimento de fala com ruído de fundo.
4. **Situações difíceis**
   Restaurante, reuniões, telefone ou TV?
5. **Impacto**
   A pessoa evita encontros ou se isola?
6. **Processamento auditivo**
   Se a audiometria for normal, investigue (Ficha 91).

Estratégias de terapia

- **Posição:** ficar de frente e perto de quem fala, longe da fonte de barulho.
- **Leitura labial:** olhar o rosto de quem fala ajuda a completar o que não ouviu.
- **Treinamento auditivo:** exercícios de escuta no ruído, conforme a avaliação.
- **Tecnologia:** aparelho auditivo e microfone remoto, quando indicados.

Em lugares barulhentos

1. **Sentar de costas para o ruído**
2. **Ficar perto de quem fala**
3. **Ver o rosto da pessoa**
4. **Pedir para repetir com outras palavras**

Sinais de atenção

- Exposição frequente a ruído alto
- Zumbido associado (Ficha 93)
- Isolamento social
- Piora progressiva

Orientação à família

- Fale de frente e sem cobrir a boca.
- Abaixe a TV antes de conversar.
- Se a pessoa não entender, repita com outras palavras.

Base: literatura de audiologia

FICHA 93 AUDIÇÃO

Zumbido no ouvido

"Um **chiado** que não para"



O que é

O **zumbido** é a percepção de um som (chiado, apito, barulho de chiar) sem nenhuma fonte externa. É muito comum e, na maioria das vezes, está ligado a alguma perda auditiva.

Pode afetar sono, concentração e humor. Mesmo quando não tem cura, há **formas eficazes de controle**.

Possíveis causas

- Perda auditiva e exposição a ruído
- Envelhecimento da audição
- Cera ou otite
- Alguns medicamentos
- Problemas na mandíbula e estresse

É urgente?

O zumbido pulsa no ritmo do coração ou veio de repente com perda em um ouvido?

SIM — Médico com urgência
Perda súbita é emergência; zumbido pulsátil precisa de investigação.

NÃO — Avaliação audiológica
Avalie a audição e o impacto do zumbido.

Como avaliar: passo a passo

1. **Características**
   Um ou dois ouvidos, tipo de som e desde quando.
2. **Audiometria**
   Investigue perda auditiva associada.
3. **Medidas do zumbido**
   Estime o tom e o volume do zumbido (acufenometria).
4. **Impacto**
   Aplique um questionário de incômodo (ex.: THI).
5. **Sono e emoções**
   Pergunte sobre insônia, ansiedade e humor.
6. **Fatores associados**
   Ruído, medicamentos, café, estresse e mandíbula.

Formas de controle

- **Aconselhamento:** entender o zumbido diminui a ansiedade e o incômodo.
- **Enriquecimento sonoro:** sons suaves de fundo, principalmente na hora de dormir.
- **Aparelho auditivo:** quando há perda auditiva, costuma reduzir o incômodo.
- **Cuidados gerais:** proteção contra ruído, sono e controle do estresse.

Para dormir melhor

1. **Som suave de fundo**
2. **Evitar o silêncio total**
3. **Rotina de sono**
4. **Menos telas antes de deitar**

Sinais de atenção

- Zumbido que pulsa como o coração
- Zumbido com perda súbita em um ouvido
- Tontura forte associada
- Ansiedade ou insônia intensas

No dia a dia

- Proteja os ouvidos em lugares barulhentos.
- Evite fones de ouvido com volume alto.
- Não fique em silêncio total: um som suave ajuda.

Base: literatura de audiologia (incluindo questionário THI)

FICHA 94 AUDIÇÃO

Terapia com aparelho ou implante coclear

Habilitação e reabilitação **auditiva**



O que é

O aparelho auditivo e o implante coclear dão acesso aos sons, mas o cérebro precisa **aprender a usá-los**. Esse é o papel da terapia auditiva.

O resultado depende muito do **uso diário e constante** do dispositivo e da participação da família.

Os dois dispositivos

Aparelho auditivo
Amplifica os sons. Indicado em perdas de leves a severas.

Implante coclear
Estimula o nervo auditivo. Para perdas severas a profundas sem benefício do aparelho.

Por onde começar?

A criança usa o dispositivo todos os dias, durante o dia inteiro?

SIM **Siga a hierarquia auditiva**
Detecção, discriminação, reconhecimento e compreensão.

NÃO **Trabalhe o uso**
Garanta o uso constante com a família antes de tudo.

Como avaliar: passo a passo

1. **Tempo de uso**
   Confira as horas de uso registradas no próprio aparelho.
2. **Checagem**
   Bateria, molde e funcionamento, no início de cada sessão.
3. **Sons de Ling**
   Teste a resposta a 6 sons: m, u, a, i, x e s.
4. **Habilidades auditivas**
   Em qual nível a criança está (veja ao lado)?
5. **Linguagem**
   Avalie vocabulário, compreensão e fala.
6. **Escola**
   Avalie a necessidade de microfone remoto na sala.

Estratégias de terapia

- **Escuta primeiro:** apresentar o som antes de mostrar a figura ou o objeto.
- **Passo a passo:** avançar de detectar sons até compreender conversas.
- **Família parceira:** a terapia continua em casa, em todas as rotinas.
- **Ambiente:** menos ruído e microfone remoto na escola.

Habilidades auditivas

1. **Detectar: há som?**
2. **Discriminar: é igual ou diferente?**
3. **Reconhecer: qual é?**
4. **Compreender: o que significa?**

Sinais de atenção

- Uso irregular do aparelho
- Não responde aos sons de Ling
- Linguagem que não evolui
- Aparelho com defeito ou molde apertado

Orientação à família

- Coloque o aparelho ao acordar e tire só para dormir e no banho.
- Confira o funcionamento todos os dias.
- Converse, narre o dia e cante para a criança.

Base: literatura de audiologia (incluindo Teste dos Sons de Ling)

FICHA 95 ADULTO • NEUROLOGIA

Entende, mas não consegue falar

Afasia de expressão após o AVC



O que é

A **afasia** é uma alteração da linguagem causada por lesão cerebral, como o AVC. Na afasia de expressão, a fala fica lenta, com esforço e poucas palavras, mas a compreensão está relativamente preservada.

A pessoa percebe os próprios erros e costuma se frustrar. A **inteligência continua preservada**.

Sinais

- Fala lenta e com esforço
- Frases curtas, sem palavras de ligação
- Dificuldade para achar palavras
- Entende melhor do que fala
- Percebe os erros e se frustra

Que tipo de afasia?

A compreensão está relativamente preservada?

SIM — Afasia de expressão
Foco na produção da fala.

NÃO — Avalie a compreensão
Pode ser afasia de compreensão ou global (Ficha 96).

Como avaliar: passo a passo

1. **Conversa**
   Observe a fala espontânea: fluência, esforço e conteúdo.
2. **Nomeação**
   Peça para nomear objetos e figuras.
3. **Repetição**
   Palavras e frases de tamanhos diferentes.
4. **Compreensão**
   Ordens simples e complexas, perguntas de sim ou não.
5. **Leitura e escrita**
   Também costumam estar afetadas.
6. **Bateria padronizada**
   Use um instrumento validado (ex.: MTL-Brasil).

Estratégias de terapia

- **Pistas de nomeação:** pistas de sentido e de som (primeira sílaba) para achar a palavra.
- **Entonação melódica:** cantar frases curtas ajuda a fala a sair.
- **Comunicação alternativa:** gestos, desenhos e pranchas como apoio.
- **Frases funcionais:** treinar as frases mais úteis do dia a dia da pessoa.

Como conversar

1. **Frases curtas e devagar**
2. **Dar tempo para responder**
3. **Perguntas de sim ou não**
4. **Aceitar gestos e desenhos**

Sinais de atenção

- Piora súbita da fala (novo AVC)
- Tristeza ou isolamento
- Dificuldade para engolir (Ficha 70)
- Família sem orientação

Orientação à família

- Não fale pela pessoa nem complete tudo.
- Trate-a como adulta: a inteligência está preservada.
- Tenha à mão papel, caneta e figuras.

Base: literatura de fonoaudiologia neurológica do adulto (incluindo Bateria MTL-Brasil)

FICHA 96 | ADULTO • NEUROLOGIA

Fala, mas sem sentido

Afasia de compreensão: **troca e inventa palavras**



O que é

Na **afasia de compreensão**, a fala sai fluente e com ritmo normal, mas o conteúdo fica confuso: há trocas de palavras e de sons e até palavras inventadas.

A compreensão está alterada e a pessoa muitas vezes **não percebe** que não está sendo entendida.

Sinais

- Fala fluente, mas sem sentido
- Troca palavras (“mesa” por “cadeira”)
- Troca sons e inventa palavras
- Dificuldade para entender o que ouve
- Pouca percepção dos próprios erros

Por onde começar?

A pessoa percebe quando não está sendo entendida?

SIM — Automonitoramento
Ensine a perceber e corrigir as trocas.

NÃO — Compreensão e atenção
Comece pela compreensão e pela atenção à conversa.

Como avaliar: passo a passo

1. **Conversa** — Observe a fluência e o conteúdo da fala.
2. **Compreensão** — Palavras isoladas, ordens simples e complexas.
3. **Repetição** — Palavras e frases curtas.
4. **Nomeação** — Anote o tipo de troca: de palavra ou de som.
5. **Consciência dos erros** — A pessoa percebe as trocas quando ouve uma gravação?
6. **Bateria padronizada** — Use um instrumento validado (ex.: MTL-Brasil).

Estratégias de terapia

- **Compreensão com apoio:** figuras, objetos e gestos junto com a fala.
- **Automonitoramento:** ouvir a própria fala gravada e identificar as trocas.
- **Redirecionar:** interromper com gentileza e voltar ao assunto.
- **Sim e não:** perguntas fechadas e escolhas facilitam a troca.

Como conversar

1. **Frases curtas e simples**
2. **Uma ideia por vez**
3. **Gestos e objetos**
4. **Confirmar se entendeu**

Sinais de atenção

- Piora súbita da fala
- Agitação por não ser entendida
- Riscos por não entender orientações
- Dificuldade para engolir

Orientação à família

- Fale devagar, com frases curtas.
- Use gestos e mostre os objetos.
- Não discuta: confirme com perguntas simples.

Base: literatura de fonoaudiologia neurológica do adulto

FICHA 97 | ADULTO • NEUROLOGIA

Fala arrastada

Disartria: **voz e fala "emboladas"**



O que é

A **disartria** é uma alteração motora da fala causada por lesão neurológica. Os músculos ficam fracos, lentos ou descoordenados, e isso afeta respiração, voz, ressonância e articulação.

Aparece após AVC, em doenças como Parkinson e ELA e após traumatismos. A **linguagem** em si pode estar preservada.

Não confunda

Disartria
Músculos fracos ou descoordenados. Erros constantes.

Apraxia
Planejamento do movimento. Erros variáveis (Ficha 99).

Afasia
Linguagem. Troca ou falta de palavras (Fichas 95 e 96).

Qual o foco?

A fala está tão difícil que a pessoa não é entendida no dia a dia?

SIM — Comunicação alternativa
Use CAA junto com a terapia de fala.

NÃO — Inteligibilidade
Trabalhe velocidade, articulação e voz.

Como avaliar: passo a passo

1. **Respiração e voz**
   Apoio respiratório, intensidade e qualidade da voz.
2. **Ressonância**
   A voz está anasalada?
3. **Articulação**
   Peça "pa-ta-ka" repetido e observe precisão e ritmo.
4. **Prosódia e velocidade**
   A fala está rápida, lenta ou monótona?
5. **Inteligibilidade**
   Quanto da fala um ouvinte consegue entender?
6. **Deglutição**
   A disartria costuma vir junto com disfagia.

Estratégias de terapia

- **Velocidade:** falar mais devagar, sílaba por sílaba, com pausas.
- **Articulação exagerada:** abrir bem a boca e caprichar nos movimentos.
- **Respiração e voz:** apoio respiratório e voz mais forte.
- **Estratégias do ouvinte:** a família aprende a facilitar a conversa.

Para ser entendido

1. **Falar devagar**
2. **Exagerar os movimentos**
3. **Uma ideia por frase**
4. **Confirmar se foi entendido**

Sinais de atenção

- Dificuldade para engolir
- Piora rápida da fala
- Voz muito fraca
- Isolamento social

Orientação à família

- Converse de frente, em lugar silencioso.
- Diga o que entendeu para a pessoa confirmar.
- Não finja que entendeu.

Base: literatura de fonoaudiologia neurológica do adulto

FICHA 98 | ADULTO • NEUROLOGIA

Comunicação na demência

Orientação para **familiares e cuidadores**



O que é

Nas demências, como a doença de Alzheimer, a **comunicação muda aos poucos**: primeiro somem palavras, depois fica difícil acompanhar conversas e entender frases longas.

A fono ajuda a manter a comunicação pelo maior tempo possível e orienta quem cuida. A forma de conversar faz **muita diferença** no bem-estar da pessoa.

Mudanças comuns

- Dificuldade para achar palavras
- Repete perguntas e histórias
- Perde o fio da conversa
- Entende menos as frases longas
- Nas fases avançadas, fala pouco

Qual o foco?

A pessoa ainda acompanha conversas simples?

SIM — Estimular
Conversas e atividades com significado para a pessoa.

NÃO — Conforto e não verbal
Toque, olhar, música e rotina.

Como avaliar: passo a passo

1. **Linguagem**
   Avalie nomeação, compreensão e conversa.
2. **Rastreio cognitivo**
   Com a equipe, use instrumentos como o Mini-Exame do Estado Mental.
3. **Audição e visão**
   Óculos e aparelho auditivo corretos melhoram muito a comunicação.
4. **Deglutição**
   Investigue engasgos e perda de peso (Ficha 71).
5. **Rotina**
   Horários, ambiente e pessoas que convivem com ela.
6. **Cuidador**
   Avalie a sobrecarga e as dúvidas de quem cuida.

Estratégias de terapia

- **Livro de memórias:** fotos com nomes da família e momentos importantes da vida.
- **Música:** canções da época da pessoa estimulam memória e conversa.
- **Temas conhecidos:** conversar sobre a profissão, a cidade e os gostos dela.
- **Orientar quem cuida:** ensinar as estratégias de conversa (veja ao lado).

Como conversar

1. **Chamar pelo nome**
2. **Frases curtas**
3. **Uma pergunta por vez**
4. **Perguntas de sim ou não**
5. **Não corrigir nem discutir**

Sinais de atenção

- Engasgos ou perda de peso
- Piora súbita (pode ser infecção)
- Sobrecarga do cuidador
- Agitação durante as conversas

Orientação à família

- Evite perguntar “lembra?”: conte você a informação.
- Acolha os sentimentos em vez de corrigir.
- Use fotos e músicas da época da pessoa.

Base: literatura de comunicação no envelhecimento e nas demências

FICHA 99 | ADULTO • NEUROLOGIA

Apraxia de fala adquirida

Tenta, mas **erra o movimento** da fala



O que é

A **apraxia de fala adquirida** é uma dificuldade de planejar e sequenciar os movimentos da fala depois de uma lesão cerebral, como o AVC. Os músculos não estão fracos.

Muitas vezes aparece junto com a afasia de expressão. A pessoa sabe o que quer dizer e percebe os erros, mas **a boca não obedece**.

Sinais

- Erros que mudam a cada tentativa
- Tateio: a boca "procura" a posição
- Dificuldade maior em palavras longas
- Fala automática melhor que a voluntária
- Ritmo da fala lento e quebrado

Apraxia ou disartria?

Os erros mudam a cada tentativa da mesma palavra?

SIM **Sugestivo de apraxia**
Erros variáveis e tateio indicam apraxia.

NÃO **Considere disartria**
Erros constantes sugerem disartria (Ficha 97).

Como avaliar: passo a passo

1. **Repetição tripla**
   A mesma palavra 3 vezes: os erros mudam?
2. **Palavras crescentes**
   "mar", "marido", "maravilhoso".
3. **Diadococinesia**
   "pa-ta-ka" repetido: a sequência se desorganiza?
4. **Automática × voluntária**
   Contar até 10 e cantar × nomear e repetir.
5. **Tateio**
   Observe a boca procurando a posição antes de falar.
6. **Afasia associada**
   Avalie compreensão, nomeação e escrita.

Estratégias de terapia

- **Ver, ouvir e imitar:** modelo do terapeuta, espelho e pistas de posição da boca.
- **Prática intensa:** muitas repetições, em sessões frequentes.
- **Ritmo e melodia:** cantar e marcar as sílabas ajudam a encadear os movimentos.
- **Palavras funcionais:** começar por nomes, "sim", "não", "água" e "ajuda".

Complexidade crescente

1. Sons e sílabas
2. Palavras curtas
3. Palavras longas
4. Frases
5. Conversa

Sinais de atenção

- Piora súbita da fala
- Frustração intensa ao falar
- Dificuldade para engolir
- Comunicação insuficiente no dia a dia

Orientação à família

- Dê tempo para a pessoa tentar.
- Aceite gestos, escrita e figuras.
- Pratique em casa as palavras treinadas na terapia.

Base: literatura de fonoaudiologia neurológica do adulto

FICHA 100 ADULTO • NEUROLOGIA

Voz fraca na doença de Parkinson

Fala baixo e **não percebe**



O que é

Na **doença de Parkinson**, a voz costuma ficar baixa, monótona e rouca, e a fala pode acelerar e embolar.

Um ponto central: a pessoa geralmente **acha que fala normal**. Por isso, a terapia trabalha a voz e também a percepção do próprio volume.

Sinais

- Voz baixa, que some no barulho
- Voz monótona, sem entonação
- Fala rápida e embolada
- Voz rouca ou soprosa
- Acha que está falando normal

Por onde começar?

A pessoa percebe que fala baixo?

SIM — Treine a intensidade
Exercícios de voz forte com acompanhamento.

NÃO — Mostre o volume
Use gravações e medidor de volume para ela perceber.

Como avaliar: passo a passo

1. **Volume**
   Meça a intensidade da voz com um medidor ou aplicativo.
2. **Tempo máximo de fonação**
   Peça um "aaa" longo e cronometre.
3. **Escala GRBAS**
   Avalie a qualidade da voz.
4. **Inteligibilidade**
   Quanto da fala os outros entendem?
5. **Deglutição**
   Investigue engasgos e tosse nas refeições (Ficha 72).
6. **Remédios**
   Avalie no período em que o medicamento faz efeito.

Estratégias de terapia

- **Programa intensivo:** terapia com foco em "falar alto" (ex.: LSVT LOUD, com profissional certificado).
- **Exercícios diários:** vogais longas e fortes e frases funcionais em voz alta.
- **Feedback:** gravações e medidor de volume para calibrar a voz.
- **Levar para a vida:** usar a voz forte nas conversas do dia a dia.

Rotina diária

1. **Vogal longa e forte**
2. **Subir e descer o tom**
3. **Frases do dia a dia**
4. **Leitura em voz alta**

Sinais de atenção

- Engasgos nas refeições (Ficha 72)
- Isolamento por não ser ouvido
- Piora rápida da voz
- Dificuldade para ser entendido ao telefone

Orientação à família

- Lembre com carinho: "Fala alto!".
- Converse de perto e sem barulho de fundo.
- Incentive a leitura e o canto em voz alta.

Base: literatura de voz e fala na doença de Parkinson (incluindo LSVT LOUD)